العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة

رؤية اجتهادية لمآلات الأحكام ونوازل العصر

القضايا المقررة هذا العام

التجارب الطبية وأثرها وحرمة جسد الإنسان	تأجير الأرحام وإشكالية ثبوت النسب	موت الدماغ وهل يعتبر موت حقيقي؟!

منارة الشريعة والقانون 01105405478

التجارب الطبية وحرمة جسد الإنسان

١ التعرف على التجارب وهل نشأت حديثاً؟

٢ بيان الحكم التكيفي على أنواع التجارب

٣ بيان القيود الواردة عليها

٤ بيان المسؤولية الشرعية والقانونية على التجارب

المبحث الأول: مفهوم التجارب الطبية وأنواعها

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يعتبر التحديد الدقيق لمفهوم التجارب الطبية وأنواعها من الأمور **الرئيسة** في بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من التجارب؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذا نعرض لمفهوم التجارب الطبية، وأنواعها وتاريخها فيما يلي:

١ مفهوم التجارب الطبية

المفهوم اللغوي

التجربة في اللغة: مأخوذة من الفعل **جَرَّبَ**، يقال: جَرَّبَهُ تجربةً: اختبره. ورجل **مُجَرِّبٌ** كمفطم على صيغة الفاعل، أي مُحدَّث قد عرف الأمور وجرَّبها، أي أن الأمور جرَّبته وأحكمته. وفي التهذيب: **المُجَرِّبُ** هو الذي جرَّب في الأمور وعرَف ما عنده. **والتجربة:** هي ما يحصل من المعرفة بالتكرار.

وفي الاصطلاح لا يختلف معناها الاصطلاحي كثيراً عن المعنى اللغوي.

تعريف الشاطبي (الموافقات)

"أمرٌ مُشَاهَدٌ في أي علمٍ كان".

تعريف علماء النفس

وسيلةٌ لِجَمْع دلالاتٍ تُظهِر تأثير متغير على آخر. وفي الظروف المثالية يتناول **المُجَرِّب** التغير المستقل، ويُثبِت سائر العوامل الأخرى، ثم يلاحظ ما يطرأ بعد ذلك على المتغير المتابع.

التعريف العام – إجرائياً

هي **إحداث ظاهرة في ظروف صناعية** معينة يُرتبها الباحث قبل إجراء التجربة، بقصد جمع معلومات عن ظاهرة تعينه على التحقق من صحة فرض افتراضي، أي أن التجربة في عمومها ليست إلا **سلسلة من الخطوات التي يُخطَّط لها بدقة وعناية**، ويكون الغرض منها اختبار فرض، أو حل مشكلة، أو الحصول على معلومات جديدة.

القانون الفرنسي رقم 88/1138 1988م

تعرَّض القانون الفرنسي رقم 88/1138 الصادر في **1988/12/20** المعدَّل بالقانون رقم 90/86 الصادر في **1990/1/23** لتعريف التجارب الطبية، فعرفها بأنها: "مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تُجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية".

أقوال العلماء في تحديد المفهوم

منارة الشريعة والقانون 01105405478

قيل: هي الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي تُعمَل دون ضرورة تمليها حالة المرضى ذواتهم، لإشباع شهوة علمية، أو لخدمة الطب والإنسانية.

وتُعرَّف بأنها: التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم الطبيب بإجرائها على مريضه.

وقيل: هي استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض، بغرض البحث العلمي، وفقاً للأصول العلمية، دون أن يكون في حاجة إليها.

التنبيه الجوهري: الفرق بين التجربة والتدخل العلاجي

وبناءً على ذلك فإن **التجارب الطبية تختلف عن التدخل العلاجي**؛ حيث إن الأخير عمل يقوم عليه الطب، وهو **مشروع بالاتفاق**، فالتدخل العلاجي يتمثل في مجموعة من الأعمال الفنية والطبية التي يباشرها الطبيب **لمصلحة المريض**، والتي تكون لغرض تحسين حالته الصحية.

ثانياً: أنواع التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تتنوع التجارب الطبية إلى نوعين رئيسين تبعاً للغرض من التجربة:

النوع الأول: التجارب العلاجية

هي التجارب التي تهدف إلى **علاج الشخص الخاضع للتجربة** من مرض ألمَّ به بطريقة مبتكرة جديدة ومتطورة، حيث إن المعرفة العلمية القائمة وقت إجراء التجربة لا تكفي لعلاج هذا المريض، وبالتالي يتم اختيار الطريقة الجديدة على المريض لتسجيل النتائج، وبمقتضاه يباشر الطبيب التجربة مستهدفاً علاج مريضه باستخدام وسائل حديثة، قد تحقق — من وجهة نظره — تقدماً في العلاج.

بتعبير أكثر دقة

التجارب العلاجية: هي التجربة التي يباشرها الطبيب بقصد علاج المريض باستخدام وسائل حديثة في الحالات المرضية التي تفتقد إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء. والغرض الأساسي من تقرير هذا النوع هو محاولة إيجاد علاج للمريض عن طريق تجربة العديد من الأدوية والعلاجات التي يرى الطبيب أنها **تُجدي نفعاً** في علاج المريض. ومن أمثلة هذا النوع: التدخلات العلاجية المحضة من حيث الغرض — وهو علاج المريض — إلا أن لهذا النوع من التجارب ميزة أخرى تتمثل في إمكانية الاستفادة من المعارف المكتسبة منها.

النوع الثاني: التجارب العلمية (غير العلاجية)

منارة الشريعة والقانون 01105405478

هي التجارب التي يخضع بمقتضاها الكائن البشري لطرق وأساليب **دون ضرورة تمليها حالته**.

وقيل: هي كُلُّ بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم، أو المساهمة فيها.

وقيل في تعريفها: هي أعمال فنية وعلمية يباشرها الطبيب على جسم المريض بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من الأمراض، أو المعالجة الوقائية، أو العلاج.

إشكال: هل التفرقة واضحة المعالم؟

يرى البعض أن التفرقة بين **التجارب العلاجية** و**التجارب العلمية** تبدو غير واضحة المعالم؛ لأن العلاج عمل بمقتضاه يقوم الطبيب بالعمل على شفاء المريض، وهذا العمل قد يكون **عقداً** كما في حالة اتفاق المريض مع طبيب خاص — سواء أكان هذا الاتفاق صراحةً أم ضمنًا — أما إذا كان العلاج في إحدى المستشفيات العامة فلا يمكن حينئذٍ القول بوجود عقد علاج بين المريض والطبيب، فالعلاج بذلك يكون من **أعمال المساعدة**.

طبيعة العمل في التجارب العلمية

أما التجارب العلمية فهي على العكس من ذلك؛ إذ إنها تسمح للباحث بالتحقق من صحة فرض معين عن طريق خلق الظروف والمعطيات الملائمة لعلم الطب، وهو بذلك يُعدّ **عملاً من أعمال الإيثار**، دافعه مصلحة الطب ذاته بهدف تطوير العلم والمعرفة وليس مصلحة من تُجرى عليه التجارب، وهو أيضاً عمل ليس له دافع شخصي من جانب الإنسان.

الفارق الجوهري بين النوعين

وجه المقارنة	التجارب العلاجية	التجارب العلمية
الهدف	إيجاد **أفضل طرق العلاج** المتاحة للمريض، وتعميم الفائدة إلى غيره من المرضى	**كشف طبي جديد** — تشخيصاً أو علاجاً — يتم تجربته على مجموعة من الأفراد
حالة الخاضع	مريض **تحتاجه حالته** للعلاج	قد يكونون أصحاء أو مرضى **دون مصلحة شخصية مباشرة**

الغرض من الفائدة	مصلحة المريض أولاً ثم تعميم الفائدة	مصلحة **الطب ذاته** وتطوير العلم والمعرفة

ثالثاً: تاريخ التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

لا تعتبر التجارب الطبية — كما يعتقد الكثيرون — من **نوازل العصر الحديث**، ولم يقتصر ظهورها عليه؛ فقد أوضح الأطباء القدماء — لا سيما أطباء اليونان — أن التجارب الطبية تُعتبر من الركائز الأساسية في علم الطب، حتى صرَّح الطبيب **أبقراط** بقوله:

«الطب قياس وتجربة»

الخريطة الزمنية لتطور التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

الطب اليوناني – أبقراط

صرَّح الطبيب أبقراط بأن الطب **قياس وتجربة**، مؤكداً أن التجربة ركيزة أساسية في علم الطب.

أبو بكر الرازي – تجارب على الإنسان

يذكر المؤرخون أن الطبيب أبو بكر الرازي أُتِيَ له بعددٍ من المرضى مصابين بمرض **السرسام** — وهو مرض يُقال له ورم في الدماغ — فقام بتقسيمهم إلى مجموعتين، وبدأ في علاج إحدى المجموعتين بالفصد تاركاً علاج المجموعة الأخرى، وراقب النتائج وحَلَّلها بدقة، ثم قرر بدء العلاج.

أبو بكر الرازي – تجارب على الحيوان

قام الرازي بتجربة تأثير **الزئبق وأملاحه على القرود**، وظل يراقبها، حيث أعطى الزئبق لقرد كان يسكن معه في بيته، فرأى القرد ملتوياً على نفسه، واضعاً يده على بطنه، وهو يصكّ أسنانه.

جالينوس – تصنيف كتاب في التجارب

لم يقتصر أمر إجراء التجارب على الطبيب الرازي وفقط؛ بل إن التاريخ حافل بالكثير من التجارب التي قام بها الأطباء على الإنسان، مما دعا الطبيب اليوناني الحاذق **جالينوس** إلى تصنيف كتاب خاص بالتجارب على الإنسان، ومن قام بها من الأطباء.

ابن سينا – التجربة السريرية

جرَّب **ابن سينا** وضع الثلج على الرأس وتغطيته به لمنع مادة تصوَّر أنها تريد النزول إلى حجاب الرأس — إذ إنه لا يأمن ورماً ينزل فيه — وذلك لصداع ألمَّ به، فنجحت هذه التجربة وعُوفِي المريض على إثرها.

ابن سينا – تجربة داء السل

أجرى ابن سينا تجربةً على امرأة مصابة بداء السل، حيث أمرها ألا تتناول شيئاً سوى دواء مُتَّخَذ من الورد والعسل يُسمى «**الجلنجبين السكري**»، فتناولت منه مائة، وشُفِيَت. وعزم ابن سينا على إثبات تلك التجارب في كتابه «القانون في الطب» إلا أن هذه التجارب فُقِدَت منه قبل إتمام كتابه.

ابن أصيبعة – «عيون الأنباء»

عقد **ابن أصيبعة** في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» فصلاً تكلم فيه عن أهمية التجارب، مؤكداً أن الطب في الكثير من مسائله مبني على **الملاحظة والتجربة**، وأن الإنسان يمكنه من خلال التجارب اكتشاف بعض الأدوية والعلاجات، ورَدَّ على من ادَّعى أن الطب يُؤخَذ من طريق الإلهام والوحي فقط، ولا دخل فيه للملاحظة والتجربة.

العصر الحديث – ضرورة التجربة على الإنسان

أيقن الأطباء أن التجارب على الحيوانات لم تعد وحدها كافيةً لإيجاد الحلول للكثير من المشكلات الطبية التي يعاني منها الإنسان؛ لأن تأثير الدواء في الكثير من الأحيان يختلف من الإنسان عنه في الحيوان، لذا بات ضرورياً اللجوء إلى إجراء تلك التجارب على الإنسان. إلا أنه في بداياتها لم يكن يتوفر لها من الضوابط ما يكفل حماية الشخص الخاضع لها، وإنما كان جُلُّ اعتمادها على ضمير الباحث وإنسانيته، الأمر الذي أدى إلى وجود عواقب سيئة لهذه التجارب، سواءً على الفرد أو على المجتمع.

واقعة الحرب العالمية الثانية (١٩٤٦م)

منارة الشريعة والقانون 01105405478

من أبرز الوقائع التي ظهرت في هذا الشأن: ما حدث عام **1946م** أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قام **ثلاثة وعشرون طبيباً ألمانياً** بإجراء تجارب طبية عنيفة على الآلاف من الأسرى والسجناء، مما كان سبباً في موت معظمهم، وإصابة العديد منهم بإعاقات جسدية مستديمة، وفي نهاية الحرب تمت محاكمة هؤلاء الأطباء من قِبل دول التحالف.

ميثاق نورمبرغ – نقطة التحوّل القانونية

اتجهت الأنظار عالميًّا إلى ضرورة وضع الضوابط والنظم التي تكفل نجاح تلك التجارب، والحفاظ على حياة الأشخاص الخاضعين لها. ومن الناحية التاريخية فقد كان للقانون الدولي اليد الطولى في وضع الأسس القانونية للتجارب الطبية التي تُجرى على الإنسان، وذلك عن طريق المبادئ التي أرستها **محكمة نورمبرغ سنة 1949م** عند محاكمة الأطباء النازيين عن الجرائم الحربية التي ارتكبوها باسم التجارب الطبية، حيث أدت المعاملات غير الإنسانية التي تعرض لها الكثير من البشر على أيدي هؤلاء الأطباء إلى صياغة العديد من المواثيق الدولية حول معاملة البشر في نطاق المجال الطبي.

إعلان هلسنكي الأول – التنظيم الدولي

كانت أولى الخطوات في هذا الشأن هو إعلان «**هلسنكي الأول**» — نسبةً إلى المدينة التي وُضِعَ فيها هذا الإعلان — حيث تم فيه وَضْعُ مجموعة من القواعد التي يَسترشِدُ بها الأطباء في عملية إجراء التجارب الطبية على الإنسان.

واقعة المراجعة – تجربة الزهري

منارة الشريعة والقانون 01105405478

ثم تمت مراجعة هذه الضوابط مرةً أخرى بعد قيام مجموعة من الأطباء بـ **أربعمائة تجربة على ستمائة رجل** من أصل إفريقي، كان منهم مصابون بمرض الزهري، وكان الهدف من هذه التجربة هو مراقبة تطور المرض دون تدخل علاجي، ولم يتم إخبار هؤلاء المرضى بطبيعة المرض، وتم منع الأدوية التي صُرِفَت لعلاجهم، ونَتَجَ عن هذه التجربة موت العديد من هؤلاء.

اتفاقية جينيف (١٩٤٦م)

نصت اتفاقية **جينيف** الصادرة عام 1946م والخاصة بالجرحى والمرضى من العسكريين على تحريم الأفعال التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تجاه المرضى والجرحى الذين يقعون في قبضتهم، ومن التصرفات التي نصت عليها: القتل المتعمد أو الإجهاز على المرضى والجرحى، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية تجاه المرضى والجرحى من الطرف المعادي، وإخضاع المرضى والجرحى إلى اختبارات بيولوجية، أو إجراء تجارب طبية أو علمية عليهم، أو التسبب المقصود في عدوانهم بأية أمراض أو بتر أي عضو من أجسامهم.

اتَّسم الإسلام بأنه **دين عام وشامل**، ولا يقف حجر عثرة أمام التقدم في أي مجال من المجالات، بل يقف وبقوة خلف كل تطور يؤدي إلى تحقيق مصلحة الإنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده. ولعل المجال الطبي من أهم المجالات التي يعمل الإسلام على دفعها للأمام؛ نظراً لتعلقه بحياة الإنسان، إذ من المقرر أن **حفظ النفس** وعدم تعريضها للخطر أو الاعتداء عليها من **الكليات الخمس** التي أولاها الشارع العناية، واهتم بها اهتماماً بالغاً.

وقد كان حرص الإسلام بالغاً في تكريس القوى للإبداع والتطوير في هذا المجال، لذا كان من المسلمين في العصور السابقة من لهم باع طويل في هذا المضمار، والتاريخ حافل بالنماذج التي تؤكد ذلك، وقد أمر النبي ﷺ بالتداوي.

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» [سنن ابن ماجه]

اشتراطات الشريعة في الدواء والتجريب

منارة الشريعة والقانون 01105405478

غاية ما في الأمر أن الإسلام اشترط في الدواء أن لا يكون محرَّماً، أو وسيلة لمحرَّم، وأن لا يكون في إجراء التجارب الطبية — مثلاً — اعتداء على **ثوابت الشريعة** ومخالفة نصوصها القاطعة، واعتداء على **خصوصيات المرضى** وهتك أسرارهم. لذا كان الأمر في بحبوحة وسعة من وجهة النظر الإسلامية — لا سيما إذا تمت مراعاة الضوابط والشروط التي سنذكرها لاحقاً.

1. ألا يكون الدواء ذاته محرَّماً
2. ألا يكون ذريعة أو وسيلة لمحرَّم
3. ألا يصطدم بثوابت الشريعة وأصولها
4. صيانة أسرار المرضى وحرماتهم

قررنا سابقاً أن التجارب الطبية تُعتبر **ضرورةً من الضرورات المفيدة** في تحقيق التقدم العلمي في المجال الطبي. وإذا كانت التجارب الطبية ظاهرةً واقعةً منذ الزمن البعيد، إلا أنها تعرضت في فترة من فترات التاريخ **للنقد الشديد**، مما أدى إلى رفضها كليةً، بسبب تلك الجرائم التي كانت تُرتكَب باسم الطب ومصلحة المرضى، الأمر الذي أدى إلى **تحوُّط وحذر شديدين** قبل إبداء الحكم الشرعي فيها — سواءً من الوجهة الشرعية أو من الوجهة القانونية.

ومن ناحية أخرى فإن التجارب على البشر **تختلف فيما بينها في مدى الخطورة** على الإنسان؛ ما بين تجارب مميتة تؤدي إلى هلاك الشخص الخاضع لها، وبين تجارب تتسم بالخطورة نظراً لما تؤدي إليه من إصابة الشخص الخاضع لها بأضرار جسدية.

⚠ التجارب باعتبار خطورتها – تنقسم إلى قسمين

منارة الشريعة والقانون 01105405478

⊗ القسم الأول: التجارب المميتة

خطورة قصوى

هي تلك التجارب المؤدية **حتماً إلى هلاك** الشخص الخاضع لها، أو **غلبة الظن بهلاكه** نتيجة إصابته بأمراض خطيرة. أي أننا لكي نكون أمام تجربة مميتة ينبغي توافر الشروط الآتية:

1. **أن يكون الموت هو النتيجة الطبيعية في حال عدم نجاح التجربة**
2. **أن يؤدي إجراء التجربة إلى الإصابة بأمراض تؤدي حتماً للوفاة**
3. **أن يغلب على ظن القائم بالتجربة موت الخاضع لها**

! **هذا النوع يتم دون علم من تُجرى عليهم التجربة في الغالب الأعم**

وهذا النوع من التجارب في الغالب الأعم يتم **دون علم** من تُجرى عليهم التجربة، بل وحتى دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إلحاق الضرر بهم. بل في الكثير الغالب تتم **دون علم السلطات** أو القائمين على حقوق الإنسان، حيث يؤدي عملهم إلى وقوع القائمين على التجربة تحت طائلة **المساءلة القانونية**.

وعادةً ما يكون هؤلاء من **المساجين وأسرى الحرب**، أو **الفقراء** الذين يسهل إغراؤهم بالمال؛ نظراً لضيق اليد وحاجتهم للأموال، حيث يجعلون أجسادهم محلاً للتجربة مقابل قدرٍ من المال قد يكون من وجهة نظرهم كبيراً. ومما يؤكد ذلك: **الازدياد الملحوظ لتجارة الأعضاء** في محيط الفقراء داخل الدول التي تسوء أحوالها الاقتصادية.

▤ أمثلة التجارب المميتة

منارة الشريعة والقانون 01105405478

١ — **التجارب الحيوية:** سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، إذ في هذه التجارب يتم **حقن الشخص الخاضع للتجربة بفيروس معين** يؤدي في الغالب إلى وفاته.

٢ — **التجارب الدوائية:** التي يكون الهدف منها معرفة **التأثيرات الجانبية لدواء معين**، سواءً من حيث النوع أو الكمية التي يجب إعطاؤها للمريض.

٣ — **تجارب الأسلحة والمواد الخطرة:** التي تُجرى للوصول إلى معرفة **الأضرار المحتملة والناجمة** عن استخدام سلاح معين أو استخدام مواد خطرة أثناء الحروب.

القسم الثاني: التجارب التي تؤدي إلى حدوث أضرار بالخاضع لها

وهي التجارب التي **تُلحِق أضراراً** بمن تُجرى عليه، سواء أكانت هذه الأضرار **جسدية** أم **عقلية**، وقد تكون **معنوية**.

والتاريخ الإنساني **حافل بالعديد من التجارب التي اتسمت بالوحشية**، والتي أدت إما إلى وفاة الخاضعين لها أو إصابتهم بأضرار بالغة الخطورة انتهت بوفاتهم، ومن هذه التجارب:

أبرز التجارب الوحشية على الإنسان

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تجارب توسكيجي – ألاباما الأمريكية (١٩٣٢م)

ما قام به الطبيب الأمريكي «**توسكيجي**»، والتي عُرِفَت في الوسط الأمريكي بتجارب توسكيجي، وذلك في عام **1932م** في ولاية «ألاباما الأمريكية»، حيث أراد الأطباء اختبار أدويةٍ جديدةٍ **أقل سُمّيةً وأكثر فعاليةً** لعلاج مرض الزهري، بعد ما ثبت فشل الزئبق في علاج هذا المرض الذي ينتقل بطريق الجنس. فبدأت تجارب هذا الطبيب **بتمويل من الحكومة الأمريكية**، وقام الفريق الطبي بإجراء التجارب على قرابة **399 مريضاً** من المصابين بالزهري، كانوا كلهم من **الزنوج الفقراء**، واستمرت التجارب مدةً وصلت إلى **أربعين عاماً**. وعلى الرغم من ظهور علاج فعال لمرض الزهري، إلا أن الأطباء **استمروا في تجاربهم**، الأمر الذي أدى إلى:

- قتل **ثمانية وعشرين مريضاً** منهم.
- وفاة **مائة آخرين** نتيجة مضاعفات المرض.
- إصابة قرابة **الأربعين سيدة** من زوجات المرضى.
- ولادة **تسعة عشر طفلاً** مصاباً بالزهري الحلقي.

تجارب جواتيمالا – أمريكا الوسطى

منارة الشريعة والقانون 01105405478

وفي مواصلة مستمرة للتجارب الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية **بتمويل تجارب جديدة** حول مرض الزهري. والغريب في الأمر أن هذه التجارب تم اللجوء إليها **بعد اكتشاف علاج للمرض**، أي أن التجارب آنذاك **لم يكن هناك مبرر لإجرائها**. ومع ذلك جرت التجارب في أمريكا الوسطى في ولاية «**جواتيمالا**»، حيث تم:

- إطلاق **العاهرات المصابات بالمرض** على المرضى العقليين والجنود في سجون جواتيمالا.
- نقل **العدوى عنوةً** إلى الحالات التي لم ينتقل إليها بالجنس.
- حتى وصل عدد المصابين إلى **ألف وخمسمائة شخص**، تُرِك **ثلثهم تقريباً بدون علاج**، حتى يكتشف الأطباء مضاعفات المرض عليهم.
- وانتهت تلك التجارب **بوفاة عدد كبير** من هؤلاء المرضى.

تجارب جزر مارشال (١٩٥٢م)

وفي واقعة هي **الأخطر من نوعها**، وتحديداً في عام **1952م** قامت الحكومة الأمريكية بإجراء تجارب على **جزيرة بأكملها**، حيث أُجريت دراسة طبية على سكان جزر مارشال الذين تعرضوا للإشعاع إثر **تجربة نووية أمريكية** في «كاستيل برافو» القريبة منهم. وقامت الحكومة الأمريكية بـ**مراقبة الضحايا في هدوء دون إبلاغهم** بتعرض جزيرتهم للخطر. وفي خلال **عشر سنوات**:

- زادت حالات **الإجهاض ووفيات الأجنة** داخل الرحم.
- مشكلات النمو لدى الأطفال.
- زيادة الإصابة بـ**سرطان الغدة الدرقية**.
- وبحلول عام **1974م** أصيب ما يقرب من **ثلث سكان الجزيرة بالأورام السرطانية**.

ونظراً لخطورة التجارب التي تتم على البشر — سواء على الفرد أو على المجتمع — وبما أن الإنسان يمر بمرحلتين: **مرحلة الحياة**، و**مرحلة الموت**، ولكل مرحلة منهما أحكامها الخاصة، قسمت هذا المبحث إلى **ثلاثة مطالب**:

١ حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

٢ حكم إجراء التجارب الطبية على الأموات

٣ حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة

← ومناقشة كل مطلب وأدلته والقول الراجح فيه

المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تعريف الأحياء

يُقصَد بالأحياء هنا: **الأشخاص الذين هم على قيد الحياة**، سواء أكانوا من المرضى أم من الأصحاء، أي أنهم من **المتطوعين** لإجراء التجارب عليهم.

وقد **اختلف الرأي** في مدى جواز إجراء التجارب على هؤلاء، على قولين:

القول	المضمون
القول الأول	يرى **جواز** إجراء التجارب الطبية على الأحياء.
القول الثاني	يرى **عدم جواز** إجراء التجارب الطبية على الأحياء.

سبب الخلاف

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى **أمرين**:

→ **السبب الأول – التعارض بين مصلحتين**

التعارض بين **مصلحة البشرية** في الوصول إلى علاج جديد لمرض من الأمراض، أو تطوير علاج قائم، وبين **الحق المقرر للإنسان على جسده**، وما له من حرمة لا يجوز للغير ولا للشخص ذاته التعدي عليها.

السبب الثاني – غياب النص الصريح

عدم وجود النص الصريح الذي يحسم المسألة، الأمر الذي كان سبباً في الخلاف، وإعمال قواعد **المصالح والمفاسد**؛ فمن رجَّح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد أجاز التجارب على الإنسان، ومن نظر إلى جانب الجسم البشري وحرمة الفرد وأهمل جانب المجتمع قال بعدم الجواز.

أدلة القول الأول (القائلون بالجواز)

استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء **بالكتاب والسنة والمعقول**:

الدليل الأول – آية الكهف ١

﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾ [الكهف: 74]

وجه الدلالة: دلت الآية على **جواز قتل النفس** إذا كان ذلك القتل محققاً للمصلحة. والمصلحة التي أرادها الخضر من قتل الغلام أشار إليها القرآن في قول الله عز وجل:

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: 80]

وهذه المصلحة **مصلحة خاصة**؛ لأنَّ نفعها مقتصر على الأبوين فقط، فمن باب أولى يجوز إذا كان محققاً **لمصلحة عامة للمرضى**، وبذلك تكون التجارب الطبية على الأحياء جائزة.

المناقشة الأولى: إن الخِضْرَ لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ لا علم له بالمستقبل، وإنما فعل ذلك **تنفيذاً لأمر الله**. فقد جاء في اللباب: «وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته باختياري ورأيي؛ بل فعلته بأمر الله وإلهامه؛ بأن الإقدام على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لا يجوز إلا بالوحي والنص القاطع». وقال ابن أبي حاتم: «كان عبداً مأموراً مضى لأمر الله».

المناقشة الثانية: إن الاستدلال بهذه الواقعة على جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء **لا يستقيم**؛ لأن المصلحة التي ابتغاها الخضر من وراء قتل الغلام **مصلحة شرعية**، إضافةً إلى كونها **مؤكدة**، بخلاف المصلحة من إجراء التجارب الطبية، فهي مصلحة **مظنونة**، إضافةً إلى كونها **غير مشروعة**.

يقول **ابن تيمية** رحمه الله: إن قصة الخضر «ليس فيها مخالفة للشريعة؛ بل الأمور التي فعلها إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر، ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال... وقصة الغلام مضمونها **جواز قتل الصبي الصائل**، ولهذا قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما عَلِمَهُ الخضر من الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم».

الدليل الثاني – آية المائدة ٢

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]

وجه الدلالة: أمر الله تبارك وتعالى **بإحياء النفوس**، ومدح من كان سبباً في إحيائها، وإحياء النفوس يكون **بإنقاذها من الهلاك** أو من الأسباب المؤدية إليه. جاء في تفسير البحر المديد: «ومن أحياها، أي: تسبب في حياتها بعفو منع من القتل، أو استبقاء من بعض أسباب الهلكة».

ويتفق العقلاء على أن **المرض أحد أسباب هلاك النفوس**، والأدوية من الأمور التي تنقذ الحياة، ولا يُتوصَّل إلى تلك الأدوية إلا **بالتجارب**، وبالتالي يكون إجراء التجارب على الإنسان من الأفعال التي امتدحها الله عز وجل؛ لأنها تؤدي إلى إحياء النفوس.

الدليل الثالث – آية البقرة ٣

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]

وجه الدلالة: نهى الله عز وجل في الآية عن إلقاء النفس في مواطن الهلكة، فدل هذا النهي على **استحباب التداوي** من الأمراض؛ إذ إن كلمة «التهلكة» وردت **عامة لم تخصص**، مما يدل على شمولها لكل ما يؤدي إلى الهلاك، ومنه **ترك التداوي**؛ ولا شك أن في ترك التداوي هلاك للفرد والمجتمع. فإذا تُرِك المرضى بدون علاج أدى ذلك إلى تضاؤل الثروة البشرية والقضاء عليها، وهو مخالف لما جاء به الإسلام. وبما أن التجارب الطبية على الأحياء تسهم في التقليل من عدد المرضى كان إجراؤها **مشروعاً**.

الدليل الرابع – حديث أنس بن مالك ٤

«أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بقومٍ يُلقِّحون النخل، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصاً، فمَرَّ بهم فقال: ما لنخلكم؟ فقالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم» [صحيح مسلم]

وجه الدلالة: دلَّ الحديث على **مشروعية التجارب**؛ حيث إن النبي ﷺ رأى النخيل على هيئة معينة فاقترح أمراً ليتحسن به النخل ويثمر، فأشار على الصحابة بعدم التلقيح، فامتثلوا لأمره، إلا أن النتائج جاءت على غير المتوقع، وعلى عكس ما أرادوا، فأوضح لهم النبي ﷺ أن هذا من الأمور التي تعتمد على **الخبرة**، فالحديث بذلك دليل على مشروعية التجارب وصولاً إلى النتائج الصحيحة.

ويناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه **خارج عن محل النزاع**؛ حيث إن النزاع فيما يجري من تجارب على **جسم الإنسان**، والحديث وارد في التجارب على **الثمار والنباتات**، وهو أمر لم يقل أحد بمنعه، ولم يختلف أحد في مشروعيته.

(أ) «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» [سنن أبي داود]

(ب) «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» [صحيح ابن حبان]

وجه الدلالة: تضمَّن هذا الحديث **إثبات الأسباب والمسببات** وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون الكلام على عمومه فيتناول سائر الأدوية والأدواء، إلا أنَّهُ عَلَّقَ الشفاء على **مصادفة الداء للدواء**.

والتجارب الطبية التي تتم على الأحياء **أحد مقومات العلاج**، ما لم تعتمد على محرَّم؛ إذ إن نتائجها تساهم في حدٍّ كبير في إيجاد العلاج الفعال والصحيح، لذا كان إجراؤها جائزاً ولا شيء فيه. وفيه **تصريح باشتراط حل الدواء**؛ لأنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، حيث نهى النبي ﷺ في أحاديث كثر عن التداوي بالخمر والنجاسات. والأمر بالتداوي في الحديثين **للوجوب**؛ إذ لا صارف له عنه إلى غيره، فيكون إجراء التجارب على الأحياء وفقاً لذلك لا شيء فيه.

ويرى البعض أن قوله ﷺ «لكل داء دواء» يحتمل معناه **أمرين**:

١ الأمر الأول – على عمومه

أن يكون على عمومه، فيتناول **الأدواء القاتلة**، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تُبرِئُها، ولكن **طوى علمها عن البشر**، ولم يجعل لهم إليها سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علَّمهم الله. ولهذا عَلَّقَ النبي ﷺ الشفاء على مصادفة الدواء للداء؛ فإنه لا شيء من المخلوقات إلا وله ضد، وكل داءٍ له ضِدٌّ من الدواء يُعالج به، فعلق النبي ﷺ البُرْءَ بموافقة الداء للدواء.

٢ الأمر الثاني – من العام الذي أُريد به الخاص

أن يكون من **العام الذي أُريد به الخاص**، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يُستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله عز وجل **لم يجعل داءً يقبل الدواء** إلا وضَعَ له دواء، فلا يدخل في ذلك الأدواء التي لا تقبل الدواء.

ما رُوي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: «رأيت عروة أصابه **الآكلة** — يعني هذا الداء — فقطع رجله من الركبة».

وجه الدلالة: استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء **بفعل عروة**؛ حيث إنه رضي الله عنه **أتلف عضواً من أعضائه** حفاظاً على باقي الأعضاء، أي أن ذلك من باب **إتلاف الجزء لاستبقاء الكل**. والتجارب التي تُجرى على الإنسان الحي يتم فيها **التضحية بعدد محدود** بهدف علاج باقي المرضى ومن يصيبهم المرض مستقبلاً، فكان في ذلك إتلاف للبعض في سبيل الحفاظ على الكل.

المناقشة الأولى: إن هذه الواقعة **خارجة عن محل النزاع**؛ لأن قطع رجله كان **ضرورةً حتمية** يترتب على عدم فعلها تلف جسمه كليةً، وبالتالي كان قطعها **واجباً شرعاً**. أما التجارب الطبية على الأحياء فليس فيها ضرورة محتمة؛ بل يمكن البحث عن بدائل أخرى في هذا الشأن.

المناقشة الثانية: على فرض التسليم بدخول واقعة عروة بن الزبير في المسألة، فإن عروة إنما فعل ذلك **حفاظاً على نفسه هو**، أما التجارب على الأحياء فإنما تتم **بهدف المحافظة على الغير** من المرضى الآخرين، فكان الفارق بينهما كبير.

يقول **الغزالي** في المستصفى معقّباً على ذلك: «وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا قَطْعُ الْيَدِ لِلْآكِلَةِ حِفْظًا لِلرُّوحِ؛ فَإِنَّهُ تَنْقَدِحُ الرُّخْصَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِ، وَقَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ لِلْإِضْرَارِ بِشَخْصٍ فِي قَصْدِ صَلَاحِهِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا قَطْعُ الْمُضْطَرِّ قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ الطَّعَامَ فَهُوَ كَقَطْعِ الْيَدِ. لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا ظَاهِرًا فِي الْهَلَاكِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ يَقِينُ الْخَلَاصِ فَلَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً».

الدليل السابع – ضرورة التقدم العلمي

٧

إن التجارب الطبية على الأحياء تعتبر من **الأمور الضرورية لتقدم العلوم الطبية**، وبدونها يقف الطب عاجزاً عن إيجاد العلاجات الفعالة للكثير من الأمراض التي تهدد كيان البشرية، أو على الأقل يكون التقدم في العلاج **بطيئاً**، لذا كان ضرورياً القيام بها والسماح بإجرائها.

ومما يدعم القول بالمشروعية أيضاً أن هناك **بعض الأمراض التي قد تصيب الإنسان ولا تصيب الحيوان**، كما أن هناك أمراض تصيب الحيوان دون الإنسان، لا سيما وقد أثبت العلم الحديث مدى **اختلاف تأثير الأدوية في الإنسان عنها في الحيوان**.

ولا يمكن القول بأن المخاطر التي تحيط بمسألة التجارب تؤدي إلى التقليل منها أو الحكم بعدم شرعيتها؛ لأن **العمل الطبي طبيعته أن يتضمن مخاطر** تهدد صحة من يُجرى عليه، إضافةً إلى أن العلم أثبت **عدم دقة النتائج** التي يحصل عليها نتيجة إجراء التجارب العلمية على الحيوانات بالنسبة للإنسان، وذلك مهما كانت درجة التشابه بين الحيوان والإنسان كبيرة؛ لأن **فسيولوجية الإنسان تختلف عن الحيوان** كثيراً، وبالتالي لا يمكن معرفة انعكاسات العقاقير الطبية على الإنسان ومقاومتها لعوامل وأسباب المرض، لاسيما وأن تأثير الأدوية الحديثة نادراً ما يكون واحداً على الإنسان والحيوان.

ويناقش الدليل السابق: بأننا نُسلّم لكم أن التجارب الطبية تحقق نفعاً للبشر، وتساهم في تقدم الطب، كما نُسلّم لكم أيضاً باختلاف التأثير الدوائي في الإنسان عنه في الحيوان، إضافةً إلى أن بعض الأمراض تقتصر على الحيوان دون الإنسان والعكس. **إلا أننا لا نُسلّم لكم** القول بمشروعية إجرائها على الإنسان الحي **دون أن يكون في حاجة لذلك**؛ فالقول بالمنع إنما يكون **لعدم حاجة الخاضع للتجربة**، وبالتالي يمكن تجربة الدواء على مرضى هم في حاجة للعلاج.

⚖ الدليل الثامن – قاعدة الاستثناءات الشرعية ٨

إن **الأصل العام المقرر** في الشريعة الإسلامية أن **التحريم يمتد إلى الكافة**؛ فكما أنه لا يجوز للطبيب إجراء التجارب على الإنسان، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يتبرع بجسده لإجراء التجارب عليه. إلا أن الشارع **خرج عن هذا الأصل**، وأورد عليه بعض **الاستثناءات**، حالة توافر ظروف استثنائية معينة، أو كان هذا الاستثناء تقتضيه مصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد.

وهذه المصلحة أجازت إتيان بعض الأفعال المحرمة على الكافة، وإذا كان الفعل المحرم قد أُبيح لتحقيق مصلحة معينة، فقد وجب منطقياً ألا يُؤتى الفعل المحرم إلا لتحقيق المصلحة التي أُبيح من أجلها؛ فإن تَمَّ الإتيان بالفعل المحرم لغرض آخر اعتبر **جريمة** ووجبت مساءلة الفاعل. فالطبيب الذي يجرح مريضاً بقصد علاجه يؤدي واجباً كُلّف به، وبالتالي فما قام به يعد **عملاً مباحاً**؛ أما إذا كان الجرح بقصد القتل ففعله **جريمة تستوجب العقاب**.

وبالتالي فالتجارب الطبية وإن كانت ممنوعة من حيث الأصل لمساسها بجسد الإنسان، إلا أن هذا التحريم **ارتفع لوجود الضرورة الطبية المجتمعية** التي تقتضي ذلك.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

⊘ أدلة القول الثاني (القائلون بالمنع)

منارة الشريعة والقانون 01105405478

استدل أصحاب القول الثاني على قولهم **بتحريم التجارب الطبية على الأحياء** بالأدلة الآتية:

📖 الدليل الأول – آية النساء ١

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]

وجه الدلالة: نهى الله تبارك وتعالى صراحةً الإنسان أن يقدم على **قتل نفسه**؛ لأنه لم يُبح للإنسان إتلاف نفسه أو شيء منها، وقد جاء النهي **عاماً من غير تحديد لوسيلة القتل**، لذا فإنه يَعُمُّ كل وسيلةٍ من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق النتيجة المنهي عنها، وهي قتل النفس. ومع أن مورد الآية في النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاً، إلا أنه أدخل فيها قتل الإنسان نفسه **لعظم خطره وشديد إثمه**؛ والآية وإن كانت دالة على تحريم إزهاق الإنسان نفسه، فمن باب أولى تدل على حرمة إزهاق نفس الغير. وإخضاع الشخص نفسه للتجارب الطبية يعتبر من **وسائل قتل النفس**، فكان محرماً شرعاً.

الدليل الثاني – آية الإسراء ٢

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

[الإسراء: 70]

وجه الدلالة: مَنَّ الله تبارك وتعالى على الإنسان **بتكريمه**، والتكريم — كما قال المفسرون — يتمثل في أمور كثيرة، منها: خَلْقِه على **صورة حسنة وهيئة كاملة**. ومن مقتضيات التكريم **صيانة جسمه كله أو بعضه عن العبث**، والتجارب الطبية تؤدي لا محالة إلى العبث بجسمه كله أو بعضه؛ لأنها إما أن تؤدي إلى موت محقق، أو تؤدي إلى أضرار تلحق بالشخص، وكلاهما **ينافي الكرامة** التي منحه الله إياها، لذا كان إجراء التجارب في هذه الحالة محرماً شرعاً.

الدليل الثالث – حديث أبي هريرة ٣

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» [صحيح البخاري]

وجه الدلالة: بيَّن النبي ﷺ **عظَمَ عقوبة من قتل نفسه** لاجترائه على أحكام الله عز وجل، وجعل الجزاء من جنس العمل — على اختلاف بين شراح الحديث في المراد بالخلود، حيث إن منهم من قال هو الخلود الأبدي، ومنهم من قال هو **المكث الطويل**.

والتجارب الطبية منها **ما هو خطير مميت** يودي بحياة الإنسان، لذا كان الإقدام عليها غير جائز لدخوله في تعمد الإنسان قتل نفسه. ولو تبرع شخص لإجراء تجارب عليه، **فليس للطبيب الحق في إجرائها**؛ لأن تصرف الإنسان في جسده بما يؤدي إلى هلاكه يخرج عن نطاق التصرفات الجائزة له، لذا كان إجراء التجارب على الجسم البشري الحي **محرماً شرعاً**.

الدليل الرابع – المعقول ٤

١ — **إن الإنسان لا يملك الحق في التصرف في جسده**، وبالتالي لا يُقبَل تطوعه بإجراء التجارب عليه؛ لأن جسده **أمانة يسأله الله عنها يوم القيامة**. فقد رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «**لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ**» [المعجم الكبير للطبراني]، وفي رواية «**وعن جسده فيما أبلاه**».

لذا لا يجوز للإنسان التصرف في جسده إلا بمقتضى التصرفات التي توافق مقتضى الشرع، وليس من التصرفات التي أباحها الشرع **التبرع بالجسد لإجراء التجارب عليه**، لذا كان إقدام الإنسان على هذا العمل لا يجوز.

ومما يؤكد ذلك: أن الفقهاء **رتبوا الإثم والعقوبة على من يتلف عضواً من أعضائه**، كما قال **العز بن عبد السلام**:

«وَكَذَلِكَ جِنَايَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَعْضَاءِ نَفْسِهِ يَتَفَاوَتُ إثْمُهَا بِتَفَاوُتِ مَنَافِعِ مَا جَنَى عَلَيْهِ، وَبِتَفَاوُتِ مَا فَوَّتَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ عَدْلِهِ وَإِقْسَاطِهِ وَبِرِّهِ وَإِنْصَافِهِ وَنُصْرَتِهِ لِلدِّينِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُتْلِفَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَلَيْسَ قَطْعُ الْعَالِمِ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُفْتِي أَوْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِسَانَ نَفْسِهِ كَقَطْعِ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِلِسَانِهِ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْبَطَلِ الشَّدِيدِ النِّكَايَةِ فِي الْجِهَادِ يَدَ نَفْسِهِ أَوْ رِجْلَ نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ قَطْعِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْجِهَادِ يَدَ نَفْسِهِ».

٢ — **عدم وجود الضرورة** في إخضاع إنسان سليم أو مريض لتجربة علمية **لا تعود عليه بالفائدة**؛ لأن مشروعية التجارب مرتبطة بالفائدة التي من الممكن أن تعود على الشخص الخاضع لها. ولا تكون للتجربة هذه الميزة إلا إذا تعلقت بالبحث عن دواء أو طرق علاجية لمرض **أَخْفَقَتِ الوسائل الموجودة في علاجه**؛ ومن ثم يجب أن يكون هناك مرضى مصابين بمرض معين لتجربة العلاج عليهم بسبب حاجتهم إليه، وبعد ذلك يمكن استخلاص النتائج المترتبة على استخدامه عليهم بدلاً من تجربته على إنسان **سليم البدن**. وعلة ذلك: أنه ليس هناك ضرورة للقيام بالتجربة على الإنسان إذا لم تُرجَ منها **فائدة مباشرة له**، أو كانت **غير مأمونة العواقب**.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

القول الراجح

منارة الشريعة والقانون 01105405478

الراجح – جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء وفق ضوابط

بعد عرض قولي الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، **يترجح عندي — والله أعلم — قول من قال بجواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء وفق ضوابط محددة**، وذلك لما يلي:

1 السبب الأول – تحقيق مقصد حفظ النفس

التجارب الطبية على الأحياء تؤدي إلى تحقيق **مقصد من مقاصد الشريعة**، وهو **حفظ النفس**، وحفظ النفس لا يتم إلا بالتداوي من الأمراض عن طريق العلاجات النافعة المفيدة، وهو ما لا يتم إلا بإجراء التجارب. يقول **الغزالي**: «مقصود الشرع من الخلق خمس، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يفوت هذه الأصول فهذه مفسدة، وكل ما يحقق هذه الأصول فهذه مصلحة».

2 السبب الثاني – الضوابط تمنع الاعتداء

إن التجارب الطبية على الأحياء إذا تمت وفق **الضوابط التي سنذكرها لاحقاً**، فليس فيها أدنى **اعتداء على حرمة الجسم البشري**؛ لما تؤدي إليه تلك الضوابط من **التأمين الكامل** لهذه العملية، وإزالة ما قد يشوبها من عوائق، سواء تعلقت بالخاضع للتجربة، أو بالقائم بها، أو بالمجتمع ككل.

الموقف القانوني من إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يتفق **الفقه والقضاء الغربيين** على القول **بمشروعية التجارب العلاجية** التي تتم على الإنسان، ويبررون ذلك بما يلي:

1 التبرير الأول – تحقيق الشفاء

إن **الغرض الرئيس من ممارسة الأعمال الطبية** هو تحقيق الشفاء، والحكم يرتبط به على الدوام؛ فما دامت تلك التجارب تؤدي إلى تحقيق الشفاء كانت مشروعة لتحقيقها **مصلحة أكيدة للمرضى**، غاية الأمر أن تؤدي هذه التجربة مُرادها والغرض المرجو منها، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كانت **نتائجها مضمونة**؛ أما إذا كانت نتائجها غير مؤكدة فإن **ضررها يكون أكثر من نفعها** مما يُرتب ضرراً محققاً للمريض الذي تُجرى عليه.

2 التبرير الثاني – ضرورة لا مناص منها

إن التجارب العلاجية على الإنسان في العصر الحاضر باتت **ضرورةً لا مناص منها**، حتى ولو كانت الأصول العلمية تحتم ضرورة إجراء التجربة على الحيوان، إلا أنه لا بد من إجرائها على الإنسان في **مرحلة من المراحل** بسبب **محدودية التجارب على الحيوان**. والسبب في ذلك أن **الاختلافات الفيزيولوجية** بين الإنسان والحيوان توجب التجريب على الإنسان لمعرفة الأثر الفعلي للأدوية على جسمه ومدى صلاحيتها للعلاج. وهذه الحقيقة العلمية دفعت البعض إلى القول بأن التجارب الطبية على الإنسان **ليست فقط مشروعة أخلاقياً؛ وإنما مطلوبة**.

3 التبرير الثالث – التوافق مع القواعد القانونية

عدم تعارض التجارب الطبية مع القواعد القانونية العامة التي تنظم الأعمال الطبية؛ حيث إن هناك **اتفاق في الغرض** الذي ترمي إليه القواعد القانونية والتجارب الطبية. فالطبيب يهدف إلى **علاج المريض** الخاضع للتجربة من خلال سعيه إلى تجربة الأدوية الجديدة التي يريد ملاحظة وتسجيل نتائجها، وكذلك ملاحظة **آثارها الجانبية** والنظر في إمكانية تطبيق هذه العلاجات على المرضى الذين تماثل حالاتهم حالة المريض الخاضع للتجربة. ولا شك أن هذه **أهداف نبيلة** تحقق نفعاً عاماً لبني الإنسان، دون ما نظر إلى دينه ومعتقده.

وتعتبر **فكرة العدالة** من الأفكار التي أُسِّست عليها مشروعية التجارب الطبية لدى القانونيين، إلا أن التسليم بها لم يكن **محل اتفاق**:

المؤيدون لفكرة العدالة

يستندون على هذه الفكرة مقررين أن **من حق كل إنسان أن يتمتع ويستفيد من تجارب من سبقوه**، ومن جملتها حقه في الاستفادة من التجارب الطبية التي تم إجراؤها في الماضي. ولعل مضمون تلك الحرية وفحوى هذه العدالة وتطبيقها على هذا النحو **يخفف الكثير من الآلام** التي يعاني منها بعض البشر، لاسيما في ظل انتشار الأمراض والأوبئة التي عمّت البلاد والعباد.

تأييد إضافي

يرى البعض الآخر مؤيداً الاستناد إلى فكرة العدالة أن **منافع هذه التجارب لن تقتصر على فئة معينة** من الناس أو دولة من الدول؛ بل إن **نفعها يمتد ليشمل الإنسانية ككل**.

الرافضون: يقرر البعض الآخر أنه **ليس هناك إجماع** بين الفقه بخصوص اعتبار فكرة العدالة أساساً لمشروعية التجارب الطبية؛ حيث رفضها البعض بناءً على أن **مشاركة الأطباء والمرضى في التجارب الطبية السابقة تمت بإرادتهم الحرة**، وفي إطار أعمال **التبرع أو الأعمال الخيرية**.

واعتمد الاتجاه المؤيد لمشروعية التجارب الطبية على **فكرة المصلحة**، حيث تستهدف التجارب تحقيق **مصلحة عامة** تتمثل في الرغبة في إيجاد **وسائل علاج جديدة** يتم بموجبها التغلب على الأمراض المستعصية. ولا يُغيِّر من مشروعية التجارب **فشلها وعدم نجاحها** في بعض الأحوال ما دام أنه تم إجراؤها وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.

ويرتبط هذا المبدأ **بفكرة الحق في سلامة الجسم**، فإذا كان الحق في سلامة الجسم يبيح للشخص **حرية التصرف في جسده** إلا أن ذلك مشروط **بعدم التعارض مع مصلحة المجتمع**؛ لأن مبدأ معصومية الجسد يرد عليه **حقان**:

١ حق خاص للفرد في أن يُصان جسده عن أي إيذاء	٢ حق عام للمجتمع في جواز المساس به متى تطلبت المصلحة العامة ذلك

وبناءً على ذلك فإجراء التجارب الطبية بهدف **كشف السبل الحديثة** لعلاج الأمراض المستعصية — عن طريق استجلاء الآثار المباشرة للعلاج المستحدث الذي سبق أن تمت تجربته على الحيوانات من خلال تجربته على الإنسان السليم خشية أن ينوء به الإنسان المريض — **لا يمثل اعتداءً على حق الفرد** في صيانة جسده متى عَبَّر عن **رضاه** بذلك، وطالما لا يترتب عليه اعتداء جسيم يعيقه عن أداء وظيفته الاجتماعية. لاسيما وأن إباحة مثل هذه التجارب من شأنه **تحقيق الدفاع الاجتماعي** في أبرز مظاهره — ليس ضد الجريمة فحسب؛ وإنما ضد المرض كذلك.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

فكرة السبب – الأساس الثالث

وذهب البعض إلى تأسيس مشروعية التجارب الطبية على **فكرة السبب**؛ فما دام السبب **مشروعاً** كان الفعل مباحاً. أي أن الهدف من التجارب الطبية ما دام يحقق **مصلحةً عليا للمجتمع**، وكانت هذه المصلحة من المصالح التي **يقرها القانون** ولا تتعارض مع **النظام العام**، وكانت مصحوبة **برضاء الشخص** الخاضع للتجربة، و**برجحان المنافع** المتوقعة منها على **الأضرار المحتملة** لها.

موقف الفقه الفرنسي: يرى بعض الفقه الفرنسي **حظر إجراء التجارب على الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام دون غيرهم**، إذ قالوا: إن العدالة والإنسانية تنافيان أن يجازف الإنسان بمثل هذه التجارب على أناس أحرار، ولكنهما **لا تأبيان** أن يجري ذلك على مجرم محكوم عليه بالإعدام.

موقف الفقه المصري: وقد أيَّد قِلَّةٌ من الفقه المصري هذا الاتجاه مستندين إلى إقرار **الدستور المصري** له، حيث نصَّت **المادة 43** من الدستور المصري على أنه: «**لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير رضائه الحر**».

فأساس مشروعية التجارب في نظر هؤلاء هو **رضاء الخاضع للتجربة** — وهو الأمر الذي اشترطه الدستور المصري — وأضاف البعض إلى ذلك **ضرورة أن يتأكد الطبيب** من أن نسبة نجاح التجربة **يفوق نسبة فشلها**، وأن يكون الهدف من إجراء التجربة **تحقيق تقدم علمي** في المجال الطبي.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب الطبية على الأموات

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تبرز الفلسفة الإسلامية في أبهى صورها في التعامل مع الإنسان، سواءً في حياته أو بعد مماته، فاهتمام الإسلام بالإنسان في الحالتين أمر لا ينكره عاقل — مع ملاحظة ما يملكه الإنسان الحي من قدرة يستطيع من خلالها **الدفاع عن نفسه** ضد أي اعتداء قد يُوجَّه إليه.

وقد كان اهتمام الإسلام بالميت **ذو طبيعة خاصة**؛ حيث إن الميت **منعدم الإرادة**، ولا قوة له يستطيع من خلالها القبول أو الرفض. أو بمعنى أوضح: ليست لديه المقدرة على دفع الاعتداء الذي قد يُمَارَس ضده، فهو جثة هامدة لا حراك فيها. لذا اعتبر الإسلام حالة الموت بالنسبة للميت **نوعًا من الضعف**، وشَرَعَ له من الأحكام ما يتناسب معها، ومن هذه الأحكام:

أحكام تكريم الميت في الشريعة

1 أمر الإسلام بتكريم الميت

عن طريق **تجهيزه ودفنه**، ومَسُّ الطيب جسده. حيث روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأوقصته، فقال النبي ﷺ:

«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبْعَث يوم القيامة مليبا» [صحيح البخاري]

2 الرفق واللين في التجهيز

عند تجهيز الميت أمر الإسلام القائمين على التجهيز **بالرفق واللين**، وعدم استعمال العنف والقسوة؛ حيث إن الميت لديه من **الشعور** ما يجعله يتأذى.

3 النهي عن إيذاء الميت

نهى الإسلام عن إيذاء الميت **بأي وجه من وجوه الإيذاء**، وقاسه على الحي بجامع **الشعور في كُلٍّ منهما**، فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [سنن أبي داود]

الحماية القانونية الدولية لجسد الميت

وعلى الصعيد القانوني، فإن كافة **المواثيق والاتفاقات الدولية** أولت الميت **حماية كاملة**، واعتبرت **حرمة الجسد** أحد الركائز الأساسية التي لا يجوز من حيث الأصل المساس بها، ومن هذه المواثيق:

1. **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٤٨م**
2. **اتفاقية الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس البشري — ديسمبر ١٩٤٨م**
3. **العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية — ١٩٦٦م**
4. **الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان**

MARA 01105405478

ومع هذا التكريم الذي أولاه الإسلام للميت، **بَرَزَت على ساحة الواقع مسائل طبية عديدة** تمس أجساد الموتى، مما ثار بشأنها جدلاً واسعاً، ومن تلك المسائل «**مسألة التجارب الطبية على أجساد الموتى**»، خاصةً بعد أن صار الاتجاه الغالب يميل إلى **حَظْرِهَا على الأحياء**، لما يترتب عليها من أضرار قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت.

تاريخ التجارب الطبية على الأموات

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يعتبر إجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى من **الأمور القديمة**، وليست حديثة كما يعتقد البعض. وهي وإن ظهرت منذ القدم إلا أن **أغراضها كانت تختلف** من واقعةٍ لأخرى، ومن أبرز الوقائع التي ظهرت قديماً ما يلي:

1 تحنيط الموتى

ويُقصَد به **حفظ جثث الموتى من التلف**. حيث أراد المصريون القدماء الاحتفاظ بجثث الموتى حتى لا تبلى، **إحياءً لذكراهم**، فلجأوا إلى عملية التحنيط في أول الأمر **من باب التجربة**. فكانوا يزيلون أمعاء الموتى حتى لا يصيبها التعفن، مضيفين مواد أخرى تمنع الجثث من التلف.

2 تشريح جثث الموتى

مصطلح **التشريح** عبارة عن ترجمة حرفية للفظ اليوناني، والذي يعني في الأصل: **تقطيع الشيء إلى أجزاء**. وكان التشريح في بادئ الأمر يعني تشريح الجثث، ثم وضع بعد ذلك عَلَمًا على العلم الخاص بالتشريح. وهذا العلم يبحث عن **الأجزاء التي تتألف منها الأجسام** باعتبار بنائها ووضعها.

وقد قام الكثير من الأطباء قديماً — **مسلمين وغير مسلمين** — بتشريح جثث الموتى على سبيل التجربة، واشتهر منهم **أبقراط** و**جالينوس**. ويعتبر المؤرخون أن «**جالينوس**» هو **رائد علم التشريح**، حيث لم يسبقه أحد إلى التأليف فيه.

يقول **ابن جلجل**: «وكان جالينوس هذا عالمًا بطريق البرهان، خطيبًا، وله كتاب ناقض فيه الشعراء وكتاب العامة. ولم يسبقه أحد إلى علم التشريح، فألف فيه **سبع عشرة مقالة في تشريح الموتى**، وألف في تشريح الأحياء كتابًا، وشرح كتب أبقراط كلها وبسطها».

الادعاء الغربي وردّه

هناك **ادّعاء أطلقه الغرب** مفاده أن المسلمين **لم يعرفوا التشريح ولم يمارسوه** من حيث الأصل، وذلك للاحترام الذي يفرضه الإسلام لأجساد الموتى. إلا أن هذا الادعاء **مخالف تمامًا للحقيقة الثابتة عبر التاريخ**، فالأطباء المسلمون **عرفوا التشريح ومارسوه** على مستوى الإنسان والحيوان، ومارسوه كذلك **بقصد التعليم**، ومما يؤكد ذلك مقولة **ابن رشد** الخالدة:

«من اشتغل بالتشريح ازداد إيماناً بالله».

ويؤكد المؤرخون قديماً أن **مصر** كانت تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث يذكر صاحب كتاب **التوضيح في أصول التشريح** أن **مدرسة الإسكندرية** التي أنشأها **بطليموس** تعتبر **أول مدارس العالم** في ذلك الوقت التي كان يُدَرِّسُ فيها علم التشريح، حيث كان يُدْعَى إليها المعلمون من كل مكان، وكانت الحكومة تدفع لهم **بجثث المقتولين لسبب جرائمهم** لأجل التشريح. ومن بين الذين اشتهروا في هذا الفن آنذاك «**إيراسيستراتوس**» و«**هيروفيلوس**» حيث أظهروا أشياء كثيرة من مكنونات هذا العلم، ووضعوا كثيرًا من أولياته.

الحكم الشرعي لإجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى

منارة الشريعة والقانون 01105405478

لم يكن حكم التجارب على الموتى بمنأى عن الخلاف بين العلماء، أسوةً بحكم التجارب على الأحياء، **بل إنه أولى منه**؛ إذ للحي إرادة وقدرة يتمكن من خلالها التعبير عن إرادته، بخلاف الميت فلا قوة له ولا إرادة يتمكن من خلالها التعبير عن إرادته قبولًا أو رفضًا. لذا كان الاحتياط في تلك المسألة المتعلقة به **أولى وأكد**.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تحرير محل النزاع

ما لا خلاف فيه – الحالة الأولى

لا خلاف بين العلماء في **جواز الأعمال الطبية** التي تُجْرَى على أجساد الموتى إذا كانت تهدف إلى **إثبات حق**، أو **نفي تهمة** عن شخص معين، سواءً كان حقًا لله أو حقًا للعبد. ومن ذلك: القيام بـ**تشريح جثة الميت** حالة الاشتباه في موته بسبب جناية، حيث إن معرفة الحقيقة ترتب حقوقًا لذويه، وكذلك ترتب حقًا للمجتمع، وهو ما يسمى بـ**التشريح الجنائي**.

ما لا خلاف فيه – الحالة الثانية

لا خلاف أيضًا في جواز التصرفات التي يُقْصَدُ منها **دفع وباء عن المجتمع**، كما لو تَمَّ الاشتباه في موت شخص بمرض من الأمراض الوبائية ولا يتم إظهار الحقيقة إلا بإجراء تجربة على جسد الميت لمعرفة نوع المرض ومدى خطورته. ففي هذه الحالة **لا مانع من إجرائها**، حفاظاً على المجتمع من انتشار هذا الوباء، حيث يقوم الطبيب **بتبليغ ذوي الشأن** ومن يعنيهم الأمر، لاتخاذ ما يلزم للحد من انتشار هذا الوباء.

ومع اتفاق العلماء على جواز ما تقدم، إلا أن الخلاف وقع في **التجارب الطبية التي تُجْرَى على الموتى بقصد التعليم**، أو بقصد تحقيق نتائج أو اكتشافات طبية يستفيد منها في علاج المرضى. وقد وقع الخلاف في مشروعيتها على **قولين**:

القول	المضمون	المنسوبون إليه
القول الأول	**عدم جواز** إجراء التجارب الطبية على الموتى	الحنابلة (تخريجًا على قولهم في شق بطن الحامل) + الشيخ محمد بخيت المطيعي + الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي

القول الثاني	**جواز** إجراء التجارب الطبية على الموتى	الحنفية والشافعية والظاهرية + عامة المعاصرين من الأفراد والهيئات

تفصيل القول الأول: قرر الحنابلة أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حيّ، **فلا يجوز شق بطنها لإخراجه**.

يقول **ابن قدامة**: «والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل».

تفصيل القول الثاني: ذهب إليه عامة المعاصرين سواء على المستوى **الفردي** أو المستوى **الجماعي**:

على المستوى الفردي

الشيخ **حسنين مخلوف**، والشيخ **إبراهيم اليعقوبي**، والدكتور **محمد سعيد رمضان البوطي**، وغيرهم.

على المستوى الجماعي (الهيئات)

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، و**دار الإفتاء المصرية**، و**المجمع الفقهي** التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، و**لجنة الفتوى** في المملكة الأردنية الهاشمية.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

سبب الخلاف

يرجع سبب الخلاف في مسألة إجراء التجارب على الأموات إلى **التعارض** بين **حق الميت في التكريم** المقرر له من قِبَل الله عز وجل، و**حق المجتمع** في الحصول على المنفعة المتحصلة من التجربة. فمن نظر إلى تكريم الميت **مَنَعَ** إجراء التجارب عليه لما فيه من اعتداء على الجثة، ومن نظر إلى حق المجتمع في الحصول على المنافع التي تنتج عن التجربة، **أجاز** إجراء التجارب على الموتى.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

أدلة القول الأول – القائلون بالمنع

استدل القائلون بعدم جواز إجراء التجارب على الموتى بالأدلة الآتية:

الدليل الأول – آية الإسراء

١

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

[الإسراء: 70]

وجه الدلالة: دلت الآية على **تكريم الله للإنسان**، وخَلْقِه على أحسن الهيئات وأكملها، وهذا التكريم يقتضي **تحريم إهانته**، وفي إجراء التجارب على الموتى **إهانة للإنسان بعد موته**.

ويناقش هذا الاستدلال بأن إجراء التجارب على الموتى **لا يتنافى** مع التكريم الذي أقره الإسلام للإنسان؛ لأن التصرفات التي تدل على عدم التكريم هي تلك التي يكون القصد منها **التشفي والعبث** بأجساد الموتى دون مصلحة مبتغاة. أما التجارب الطبية فإن هناك **مصلحة لمجموع الناس** من ورائها؛ فمن خلال نتائجها يتمكن الأطباء من علاج الكثير من المرضى ممن لا يُجدي معهم العلاج بالطرق القائمة، وبالتالي يمكن اعتبار هذا العمل من باب **التعاون على البر والتقوى**.

الدليل الثاني – حديث بريدة (النهي عن المثلة) ٢

ما رُوي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أَمَّر أميراً على جيشٍ أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمْثِلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» [صحيح مسلم]

وجه الدلالة: نهى النبي ﷺ في الحديث عن **المثلة**، والمثلة في اللغة هي: العقوبة والتنكيل، وتجمع على مثلات. وفي الاصطلاح عرَّفها **الزركشي** بأنها **تشويه خلقة القتيل**، ومن صور المثلة تسميل عين، أو فقئها، أو بقر بطن، أو قطع عضو.

والتجارب الطبية التي تتم على الموتى يتم فيها ذلك، فكانت **ممنوعة شرعًا** لدخولها في نهي النبي ﷺ عن المثلة. أضف إلى ذلك أن نهي النبي ﷺ إنما جاء في الحديث عن التمثيل **بجثث الأعداء**، وهم غير مسلمين، فكان التمثيل **بجثة المسلم** منهي عنه من باب أولى. أيضًا فإن النهي ورد عن التمثيل بالجثث **حالة الحرب**، وبالتالي فالنهي عن التمثيل بالميت **في حالة السلم** أولى وأكد.

المناقشة الأولى: لا نُسلِّم أن في إجراء التجارب **تمثيل بجثة الميت**؛ لأن التمثيل هو ذلك الفعل الذي يكون **غرضه غير مشروع أو غير إنساني**، كالتشفي والانتقام، وهو ما لا يوجد في التجارب التي يمكن أن تُجرى على الجثة.

المناقشة الثانية: إن التجارب الطبية على الميت وإن حدث فيها تسميل عين، أو فقئها، أو قطع عضو، أو نزع جلد وما إلى ذلك، فلا يمكن أن يطلق على ذلك أنه **تمثيل بالجثة**؛ **لانتفاء الغرض** من ناحية، و**لوجود المبرر الداعي** إلى ذلك من ناحية أخرى.

المناقشة الثالثة: على فرض التسليم أن التجارب تعتبر من باب التمثيل، فإن الأدلة التي تنهي عن التمثيل **لا تشملها**؛ إذ الأدلة عامةً وَرَدَ ما يخصصها، فلكل واقعة سبب. فالتمثيل بالعرنيين — مثلاً — إنما كان **زجرًا لغيرهم** ممن قد تُسوِّل لهم أنفسهم فعل ذلك، وكذلك ما يفعل بالمحاربين. وبالتالي فالنهي لا يشمل التجارب التي تتم على أجساد الموتى.

الدليل الثالث – حديث كسر عظم الميت ٣

ما رُوي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [سنن أبي داود]

وجه الدلالة: أثبت الحديث **حرمة جسد الإنسان بعد الموت** كاحترامه حال الحياة. والحديث دليل صريح على بيان **المثلية في الإثم** المترتب على الاعتداء على كل منهما. والتجارب الطبية قد تشتمل على **كسر لعظم الميت**، وكذلك تقطيع له، وبالتالي فكما لا يجوز إجراؤها على الأحياء، فكذلك لا يجوز على الموتى، للإثم الوارد في كلٍّ منهما، ولِمَا يتضمنه من إيذاء وهتك لحرماتهم.

ويناقش هذا الاستدلال: بأنّا نُسلّم لكم أن للميت حرمة كحرمة الحي، فلا يُعتدَى عليه بكسر أو شق، وأن حرمته باقية بعد موته. **إلا أنا لا نُسلّم لكم** الأخذ بعموم النص؛ فالاعتداء على الميت غير جائز شرعًا، **إلا إذا دعت إليه ضرورة** تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت؛ لأن قواعد الدين الحنيف مبنية على **رعاية المصالح الراجحة**، وتحمل **الضرر الأخف** لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر.

الدليل الرابع – احترام الميت معنوياً ٤

إن الشريعة الإسلامية **بالغت في احترام الموتى**، حيث قررت حمايتهم من **الإيذاء المعنوي**، فنهت عن سَبّ الأموات، وأمرت بذكر محاسنهم ومزاياهم، وتَرْكِ مساوئهم وعيوبهم. فقال النبي ﷺ:

«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» [صحيح البخاري]

«اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ» [سنن أبي داود]

وإذا كان الإسلام نهى عن **إيذاء الميت معنوياً** مع عدم تأذيه، فإن النهي عن التجارب التي تطول جسده وأعضائه وفيها **ألم جسدي** يكون **أولى وأكد**.

الدليل الخامس – القواعد الفقهية ٥

استدلوا بالعديد من **القواعد الفقهية** التي تفيد بمضمونها حرمة التجارب على الموتى، ومنها:

١ قاعدة «الضرر لا يُزَالُ بالضرر»

٢ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

حيث ثبت من خلال هاتين القاعدتين أن **الضرر لا ينبغي أن يُزَالَ بضرر مثله**. وإذا كان المرضى يصيبهم ضرر من جَرَّاءِ مرضهم، فلا ينبغي أن نزيل هذا الضرر بتجارب على الموتى تَضُرُّ هي بهم؛ فإزالة الضرر الذي ينادي به الأطباء لا يتم إلا بإلحاق ضرر بجسم الميت، وهو ما دَلَّتْ القواعد الفقهية على عدم جوازه.

المناقشة الأولى: سلمنا لكم بصحة ما تدل عليه القواعد السابقة، وأن الضرر لا ينبغي أن يُزَالَ بضررٍ مثله، إلا أن هذا التسليم **مشروط بشرطين**:

١ أن نكون في الظروف العادية	٢ أن يكون الضرر الذي تتم به الإزالة مساوياً أو أشد من الضرر المراد إزالته، أما إذا كان أخف فلا شيء في ذلك

والتجارب التي تقع على أجساد الموتى يكون **ضررها أخف** من تلك الأضرار التي يعاني منها المرضى.

المناقشة الثانية: إن القواعد التي تم الاستدلال بها **مُعَارَضَةٌ بقواعد أخرى** أوضح وأصرح في الدلالة على مسألتنا، وهي:

١ قاعدة «يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام»	٢ قاعدة «يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد»

وَلَمَّا كانت هذه القواعد **صريحة في الموضوع**، كان إجراء التجارب على الموتى جائز ولا شيء فيه.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

أدلة القول الثاني – القائلون بالجواز

منارة الشريعة والقانون 01105405478

استدل القائلون بجواز إجراء التجارب الطبية على أجساد الموتى بما يلي:

الدليل الأول – آية المائدة ١

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]

وجه الدلالة: عَظَّمَ الله تعالى **ثواب إحياء النفس** واعتبر إحياء نفس واحدة بمثابة الإحياء لجميع الناس، ولم يحدد رب العزة **الطريقة التي يتم بها الإحياء** لتكون عامة تشمل ما هو موجود، وما يفرزه التطور.

قال **الحسن**: «من إحيائها أن يُنَجِّيها من القود، فيعفو عنها، أو يفاديها من العدوان، وينجيها من الغرق، ومن الحرق، ومن السبع، وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالها».

وإجراء التجارب على الموتى فيه **إحياءً للآخرين**، بل إن نتائج هذه التجارب يكون لها أثرها البالغ في **وقاية الأفراد** من براثن بعض الأمراض التي تفتك ببني الإنسان. وقد جاء في تفسير معنى الإحياء في قوله تعالى «ومن أحياها» ما يؤيد ذلك: فقد ذكر **ابن الجوزي** في تفسيره أن المفسرين أوردوا في معنى الإحياء **خمسة أقوال** أحدها يعني: **استنقذها من هلكة**.

ولا شك أن إجراء التجارب على الأموات فيه **استنقاذ حياة الكثيرين**، بعلاجهم من الأمراض المميتة وفقًا لنتائج تلك التجارب، فكان إجراؤها جائز شرعاً.

الدليل الثاني – الفوائد العظيمة ٢

للتجارب الطبية **فوائد عظيمة**، سواءً على المستوى **الفردي** أو على المستوى **الجماعي**، حيث يترتب عليها تحقيق **النفع للبشرية**. وإذا كان إجراؤها على الأحياء يثير بعض الإشكالات نظرًا للأضرار التي قد يُصَابُ بها الشخص الخاضع للتجربة، لذا فإن إجراؤها على الموتى **لا شيء فيه**.

فمن المسلم به شرعًا وعقلاً أن الشريعة الإسلامية **راعت مصالح العباد**، وقرر الفقهاء أنه **يُرتَكَبُ الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد**، وإذا تعارضت مفسدتان **قُدّمت أخفهما**، لذا كان إجراء التجارب على الموتى جائز شرعًا.

الدليل الثالث – القياس على استخدام أعضاء الميت ٣

يُسْتَدَلُّ على جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى **بالقياس على استخدام بعض أعضاء الميت في علاج الحي**، حيث قرر العلماء جواز استخدام أعضاء الميت في حال الحاجة إليها من قِبل الأحياء:

دار الإفتاء المصرية

أفتت بجواز **سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء**، وألا يتعدى الأموات الذين **ليس لهم أهل**. أما الأموات الذين لهم أهل، فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون **بيدهم وبإذنهم وحدهم**، فإذا أذِنُوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم وموافقتهم.

هيئة كبار العلماء السعودية

أجازت **نقل قرنية عين** من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، ما لم يمنع أولياؤه ذلك.

تعليل ذلك: بناءً على قاعدة **تحقيق أعلى المصلحتين** و**ارتكاب أخف الضررين**، و**إيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت**؛ فإنه يُرْجَى للحي **الإبصار بعد عدمه**، والانتفاع به في نفسه ونفع الأمة به. ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء؛ فإن عينه إلى **الدمار والتحول إلى رفات**، وليس في أخذ قرنية عينه **مثلة ظاهرة**؛ فإن عينه قد أغمضت وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.

MANARA 01054054178

وبالتالي فإذا كان يجوز استخدام بعض أعضاء الميت **لإحياء شخص آخر**، فمن باب أولى يجوز إجراء التجارب عليه، لما في ذلك من **إحياء أمة**، أو مرضى كثيرين، وتخفيف آلامهم، لاسيما وأن الميت **لا يلحقه ضرر** من جراء تلك التجارب.

الدليل الرابع – الأكل من الميت في الضرورة ٤

إن الفقهاء أجازوا **الأكل من الميت في حالة الضرورة**، استبقاءً للحياة. وفي إجراء التجارب على الميت **استبقاء لأحياء** بإتلاف أجزاء من الميت، فكان إجراء التجارب على الميت جائزاً ولا شيء فيه.

الدليل الخامس – ترجيح المصالح على المفاسد ٥

إن في إجراء التجارب على الموتى بغرض التقدم الطبي يشتمل على **مفاسد**، إلا أن ذلك يحتوي على **مصالح تترجح عليها**؛ لأن المصلحة المترتبة على إجراء التجارب تعتبر من **المصالح العامة** التي تعود بالنفع على مجموع الأمة، حيث تؤدي إلى **دفع الأضرار عن الأمة**، كما تؤدي إلى **التخفيف من آلام المرضى**. ويقابل ذلك كله مفسدة **عدم الحفاظ على كرامة الميت**. وبالتالي فالمصالح التي تنتج من إجراء التجارب تؤدي إلى **حفظ النفوس**، لذا وجب **تقديم مصلحة الأحياء على مصلحة الحفاظ على الميت**، نظرًا للمنافع التي تتحصل من ورائها.

أضف إلى ذلك أن **مصلحة الميت خاصة**، و**مصلحة المرضى عامة**، وعند التعارض يجب **تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة**، كما هو مقرر لدى العلماء.

الدليل السادس – قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ٦

يُسْتَدَلُ على جواز إجراء التجارب على الموتى بالقاعدة الفقهية: **«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»**.

وقد ذهب أغلب العلماء إلى **وجوب التداوي** من الأمراض، لورود الأحاديث الصريحة الموجبة للتداوي، ومنها قوله ﷺ:

> «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» [صحيح ابن حبان]

وإذا كان **التداوي من الأمراض واجبًا**، وكان التداوي **لا يتم إلا بإيجاد الأدوية**، كانت الوسائل التي تؤدي إلى اكتشافها **جائزة شرعًا**. والتجارب الطبية هي أحد **العوامل الرئيسة** التي تساعد على إيجاد العلاجات الناجحة الفعالة، لذا كان إجراؤها على الموتى **جائزاً من الوجهة الشرعية**.

وبما أن **تعلم الطب واجب على الكفاية**، لما يحققه من منافع يستفيد منها مجموع الأمة، ولا يتم ذلك إلا بالتجارب، فتكون مشروعة من هذا الوجه.

الدليل السابع – القياس على شق بطن الحامل ٧

القياس على **شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وجنينها حي**، حيث ذهب **الجمهور** إلى جواز شق بطنها لإخراج جنينها. فإذا كان ذلك **يباح لإحياء نفس واحدة**، فمن باب أولى يجوز إجراء التجارب الطبية على الموتى، لما فيها من **نفع للإنسانية**.

الدليل الثامن – حكم الوسائل متعلق بحكم المقاصد ٨

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن **حكم الوسائل متعلق بحكم المقاصد**، وإذا كان الهدف من إجراء التجارب على الأموات هو **تحقيق النفع للبشرية**، فيكون الحكم هو **الجواز**، لاسيما وقد **غابت النصوص الصريحة** التي تحرم هذا الفعل.

يقول **الغزالي** رحمه الله: «وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ».

منارة الشريعة والقانون 01105405478

القول الراجح في التجارب على الموتى

منارة الشريعة والقانون 01105405478

الراجح – جواز إجراء التجارب الطبية على الموتى

بعد عرض القولين، وما اعتمدا عليه من أدلة، ومناقشة ما أمكن منها، **يترجح عندي — والله أعلم — قول من قال بجواز إجراء التجارب الطبية على الموتى**، وذلك لما يلي:

1 السبب الأول – قوة الأدلة

قوة أدلة هذا الرأي وسلامتها من المناقشة.

2 السبب الثاني – الموازنة بين المصالح والمفاسد

الموازنة بين المصالح والمفاسد توجب ترجيح الجواز؛ حيث إن **مصلحة الحي برعايته وإنقاذ حياته** أعظم من مصلحة الحفاظ على حرمة جسد الميت وعدم امتهانه، لاسيما وأنه صار **جسدًا بلا روح**، فتكون التجارب على الموتى من باب **إحياء النفوس**.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

المطلب الثالث: حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة

إذا كان **الإنجاب الصناعي** يُستخدم في المقام الأول كعلاج لحالات **العقم** لدى الزوجين أو أحدهما، وبما أن الأطباء **يتوقعون فشل المحاولة**، فإنهم يعمدون إلى **تنشيط المبيض** لدى الزوجة حتى يتمكن من إفراز عدد من البويضات، ثم القيام بـ**تلقيح هذه البويضات** بالحيوانات المنوية المأخوذة من الزوج وحفظها؛ بحيث إذا فشلت تلك المحاولة يكون بإمكان الأطباء القيام بزرع إحدى البويضات الملقحة في رحم الزوجة **دون إعادة الكرة مرةً أخرى**.

فيقوم الأطباء بتلقيح عدد من البويضات **والاحتفاظ بالبعض الآخر**؛ فإذا ما كُتِبَ للعملية الفشل يقوم الأطباء بإعادة الكرة باستخدام البويضات الملقحة المحفوظة مرةً أخرى دون عناء. أما إذا نجحت العملية وتم زرع الجنين في رحم الزوجة، وبدأت **دورة الحمل الطبيعية**، فإننا نكون أمام **بويضات ملقحة قابلة للزرع في الرحم**.

مراحل البويضات الملقحة

منارة الشريعة والقانون 01105405478

1 مرحلة ما قبل الجنين

وهي مرحلة **الأسبوع الأول** من الحياة، وبعد الأسبوع الأول من الحياة، وبعد أن يصل عدد الخلايا داخل الجنين إلى **٣٢ خلية** تأخذ الكتلة البشرية في التشكيل، وتظهر داخله **فراغات وتكتلات في الخلايا**، ويصبح لتلك الخلايا **خصائص وتخصصات**، وتتكرر هذه المرحلة في الأسبوع الثاني من الحياة. وفي هذه المرحلة يُطلق على الناتج اسم **الجنين**، وهذه التسمية هي السائدة في العرف الطبي.

وبالتالي فالأجنة الفائضة إما أن تكون:

2 مرحلة ما قبل الجنين

وهي عبارة عن **مجموعة من الخلايا** تصل إلى ٨ **أو ١٦ خلية**، ولكل خلية **قدرة على مواصلة الحياة**، وأن تكون شخصاً كاملاً.

3 مرحلة الجنين

وبها حوالي **٣٢ خلية أو أكثر**، وهذه المرحلة هي ما تُسمى بـ**الجنين**.

والسؤال المطروح: هل يجوز إجراء التجارب الطبية على هذه البويضات الفائضة؟

الإجابة عن ذلك تطرح تساؤلات عدة تدور حول **مدى اعتبار البويضة الملقحة جنينًا أم لا**، وما هو **الوقت الذي تُنفخ فيه الروح**، ووفقًا لذلك يظهر حكم إجراء التجارب عليها.

مدى اعتبار البويضة الملقحة جنينًا

منارة الشريعة والقانون 01105405478

١ الجنين في اللغة

مأخوذ من **الجن**، وهو **الستر**، ومنه قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ [الأنعام: 76]

أي: **ستره**. ومنه سُمِيَ الجنين لاستتاره في بطن أمه. والجنين: **المقبور**، والجنين: **الولد في بطن أمه** لاستتاره فيه. ويُجمع على **أجنة وأجنن**. جاء في **المصباح المنير**: «الجنين وصف له ما دام في بطن أمه، والجمع أجنة، مثل دليل وأدلة. قيل: سمي بذلك لاستتاره، فإذا وُلِدَ له وَلَدٌ فهو منفوس، والجن والجنة خلاف الإنس».

٢ الجنين في الاصطلاح – أقوال الفقهاء

اختلف الفقهاء في تعريف الجنين تبعاً لاختلافهم في **الأحكام المترتبة عليه**:

الحنفية

ما استبان من خَلْقِهِ شيء، فإن لم يَسْتَبِنْ شيء من خلقه فليس بجنين.

المالكية

كُلّ ما حملته المرأة مما يُعْرَفُ أنه ولد.

الشافعية – الغزالي

الجنين هو **النطفة إذا وقعت في رحم المرأة** واختلطت بمائها. وزاد الغزالي أن المُعَوَّل عليه في الحكم بكون ما في الرحم جنيناً من عدمه أن **يستبين شيء من خلقه**، وإلا فلا بد من شهادة **أربع نسوة** من القوابل الثقات، أو **عالمين في الطب الشرعي** أو علم الأجنة أن المضغة التي سقطت فيها **تخطيط لآدمي**.

الحنابلة

الجنين **ما كان فيه صورة آدمي**، وقبل ذلك لا يُعْلَمُ يقيناً أنه جنين.

ابن رجب الحنبلي وابن حزم الظاهري

بَدء اعتبار ما في الرحم جنيناً هو كونه **علقة**، فالعلقة بداية الجنين، وما قبل ذلك لا يُعد جنيناً.

الأطباء

يطلق بعض الأطباء لفظ الجنين على الولد في بطن أمه عندما **يظهر عليه الطابع الإنساني** بتكوُّن الأجهزة المعروفة للإنسان، ويكون ذلك فيما بين **الشهر الثالث** من الحمل إلى حين الولادة. وَيُقْصِرُهُ بعضهم على الولد في بطن أمه إذا **اكتملت بنيته**، وكان بإمكانه أن يعيش إذا نزل حيًّا من بطن أمه، ويكون هذا في الفترة الواقعة بين **بداية الشهر السابع** إلى وقت الولادة.

ومن علماء الأجنة من يطلق الجنين على الفترة الواقعة بين **انغراس البويضة الملقحة في جدار الرحم ونهاية الأسبوع الثامن**، ثم يطلقون عليه بعد ذلك اسم «**حميل**» إلى أن يولد.

ويفرق أهل الطب بين الجنين في **مراحله الأولى**، والجنين في **المراحل التالية**: فالجنين في مراحله الأولى يراد به **انقسامات البويضة** خلال الشهور الأولى، وفي المراحل التالية يراد به **الطفل الذي لم يولد**.

الانقسام الفقهي حول اعتبار البويضة الملقحة جنينًا

منارة الشريعة والقانون 01105405478

وبمطالعة ما ورد عن الفقهاء يبدو للوهلة الأولى أنهم **منقسمون** بشأن هذا الأمر:

الاتجاه الأول

بعضهم **يعتبرها جنينًا له مقومات الحياة**، حيث إنهم اعتبروا البويضة من وقت **تخصيبها بالحيوان المنوي** تتمتع بالحماية الشرعية، ورتبوا على ذلك حكمهم **بعدم جواز إجهاضها والاعتداء عليها**.

الاتجاه الثاني

البعض الآخر **لم يعطها المقومات** التي يحيا بها الجنين، وأجاز صراحة **الاعتداء عليها وإسقاطها** في المراحل الأولى من الحمل.

الحنفية

البويضة المُخَصَّبَة قبل نفخ الروح **لا حياة لها ولا تعتبر جنيناً**. يقول **ابن عابدين**: «إنما يباح للمرأة استنزال الجنين قبل نفخ الروح؛ لأنه ليس بآدمي».

الشافعية

ذهبوا إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية فقالوا: إنه **لا يعتبر جنيناً قبل أربعة أشهر**، ولذلك **لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه**. نقل ذلك **الشوكاني** في نيل الأوطار وقال بعده: وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا.

ابن قدامة

اعتبر الجنين قبل نفخ الروح **لا حياة فيه**، بل هو **الجماد والدم**.

ابن حزم

يرى أن الجنين قبل نفخ الروح فيه **لا شيء ولا حياة له**؛ حيث إن من مذهبه أن الجنين الذي لم تُنفخ فيه الروح **لا غرة له**.

لماذا لم يعتبر الفقهاء البويضة المخصبة جنينًا قبل نفخ الروح؟

منارة الشريعة والقانون 01105405478

ومن خلال ما سبق يتضح أن الفقهاء لم يعتبروا البويضة المخصبة جنينًا قبل نفخ الروح **لعدة أسباب**:

1 السبب الأول – الحياة لم تدب فيه

إن **الحياة لم تدب فيه حقيقة**؛ إذ الحي ما هو إلا **جسد وروح**، والجنين قبل الأربعة أشهر **جَسَدٌ بلا روح** فلا تتوافر فيه **صفة الإنسانية**.

2 السبب الثاني – تركيب الجنين

إن الجنين **يتكون من الحيوان المنوي والبويضة**، ويؤيد ذلك معنى كلمة جنين، حيث إنها في اللغة مأخوذة من **الاستتار**؛ لأنه مستور في بطن الأم داخل **ظلمات ثلاث**. ولذلك يقول **القرطبي**: «الجنين هو الولد ما دام في بطن أمه». ويمكن القول: إن **حرمة البويضة الملقحة يرتبط بمكان وجودها**؛ فقيمتها وحرمتها تكون إذا كانت في الرحم؛ لأنها عندئذ تسمى جنينًا، أما البويضة الملقحة **خارج الرحم لا تعتبر جنينًا** لعدم وجودها في بطن الأم.

3 السبب الثالث – تأييد العلم الحديث

إن القول بعدم اعتبار البويضة الملقحة جنينًا قول **مُؤَيَّد بنظريات العلم الحديث**؛ لأن البويضة **لا تعتبر حملًا إلا إذا اندمجت في أنسجة الرحم**، أما قبل ذلك لا تعد جنينًا.

4 السبب الرابع – الروح سر الحياة

إن **خروج الروح من الجسد** هو السبب الحقيقي الذي سببه الله تعالى لإنهاء حياة الإنسان، وإذا كان خروج الروح هو سبب خروج الإنسان من الدنيا، فإن **وجود الروح هو سبب وجوده فيها**؛ فالحياة الإنسانية لا تدب في الجنين إلا بعد نفخ الروح، أما قبل ذلك فهي **حياة نباتية** من أهم آثارها **الحركة غير الإرادية والنمو**.

5 السبب الخامس – خَلْق آخر

إن الحياة الإنسانية **لا تبدأ إلا من وقت نفخ الروح في الجنين**؛ إذ يصبح الجنين بعد نفخ الروح **خَلْقًا آخر مبايناً عن الخلق الأول**، وهو ما قبل نفخ الروح. وهذا الخلق بعد نفخ الروح فيه **قوى الوعي والإدراك والتمييز** وغير ذلك من جميع الأجهزة المعوقة للإنسانية، وهذا بخلاف الأطوار السابقة على نفخ الروح.

موقف ندوة «رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية»

منارة الشريعة والقانون 01105405478

وهذا القول هو ما انتهت إليه **ندوة رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية**، حيث قررت:

توصيات الندوة

إن **الوضع الأمثل** في موضوع مصير البويضات الملقحة هو **ألا يكون هناك فائض منها**؛ وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد **الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة** مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على **التلقيح السوي** فيما بعد. وتوصي الندوة **ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضًا**.

أما إذا حصل فائض فترى **الأكثرية** أن البويضات الملقحة **ليس لها حرمة شرعية**.

وقت نفخ الروح في الجنين

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تعتبر مسألة **تحديد الوقت الذي تُنْفَخُ فيه الروح** في الجنين من **أدق المسائل** التي يمكن بحثها في أحكام الجنين وما يتعلق به؛ إذ إن تحديدها يؤدى إلى **بناء الأحكام الشرعية عليها**.

وبمطالعة النصوص الواردة في هذه المسألة يمكن القول: إن هذه المسألة **يتنازعها أربعة اتجاهات**:

❶ الاتجاه الأول: بعد الشهور الأربعة الأولى

مؤدى الاتجاه

أن الروح **لا تُنفَخ إلا بعد الشهور الأربعة الأولى**، أي: **بعد مائة وعشرين يوماً**.

واستند هذا الاتجاه إلى ما يلي:

ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدَّثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ» [صحيح البخاري]

وجه الدلالة: في هذا الحديث **تحديد صريح لا يقبل الجدل** بأن الروح لا تُنفَخُ إلا بعد مائة وعشرين يوماً، بل نقل بعض العلماء ممن تعرض لشرح هذا الحديث **الإجماع** على ذلك:

قال **القرطبي**: «لم يختلف العلماء أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس — كما بيناه بالأحاديث — وعليه يُعَوَّلُ فيما يحتاج إليه من الأحكام».

وقال **ابن عابدين**: «نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها... ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق».

وقال **النووي** في شرحه لصحيح مسلم: «واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر».

وقال **ابن رجب**: «فأما نفخ الروح فقد روي صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود».

ونقل **ابن حجر** في الفتح القول باتفاق العلماء على ذلك، فنقل عن الفاضل **علي بن المهذب** قوله: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يقع إلا بعد أربعة أشهر».

وقال **ابن حجر**: «وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار، كل طور منها في أربعين، ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح... ثم يكون للملك فيه تصور آخر، وهو في وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة أشهر كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر».

ونقل **ابن حجر** عن **القاضي عياض** أنه قال: «اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع، ولم يختلف في أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك بعد تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس، وهذا موجود بالمشاهدة، وعليه يُعَوَّلُ فيما يحتاج إليه من الأحكام».

٢ الاتجاه الثاني: بعد الأربعين يوماً الأولى

مؤدى الاتجاه

أن الروح **تنفخ في غضون خمسة أيام** بعد الأربعين يوماً الأولى.

وسند هذا الاتجاه ما يلي:

ما رواه حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ» [صحيح مسلم]

وقد جنح بعض المعاصرين إلى هذا الرأي وَدَلَّلَ على ذلك بقوله:

إن صح حمل **الحديث الأول** — حديث ابن مسعود — على الأحاديث الأخرى؛ حيث إن هذا الحديث **ليس فيه تصريح بأربعة أشهر**، أو بأن مرحلة النطفة تكون أربعين يوماً وحدها؛ بل إن قوله: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» يُفْهَمُ منه أن **كل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة يتم في الأربعين يوماً**، ولذلك لم تَرِدْ كلمة نطفة بعد هذه الجملة في أي من الروايات الصحيحة.

أما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك» **فليس صريحاً في أن المقصود المدة**، وهي أربعون يوماً؛ بل يحتمل غيره، كأن تقول مثلاً: إن العلقة والمضغة مثل النطفة في **كَوْنِ الجنين لا روح فيه**، وكونه لم يكتب قدره. يشير إلى ذلك قوله بعد ذلك: «ثم يرسل إليه الملك...».

ومما يؤكد أن المقصود في قوله «مثل ذلك» **ليس الوقت** رواية الإمام مسلم لحديث ابن مسعود؛ فلا شك أن قوله «في ذلك» أي: في ذلك الوقت، وهو الأربعون الأولى لا غير. فينبغي تفسير قوله «مثل ذلك» تفسيراً آخر غير الوقت، فيصبح معناه: ثم يكون في ذلك الوقت مثل الجمع. فهناك شبه بين العلقة والمضغة، وبين الجمع الأول وهو النطفة، قد يكون **عدم وجود الروح** أو **عدم كتابة قدر**.

بل زعم البعض أن رواية مسلم **تفيد ذلك**، إذ إن الإشارة الأولى تعود إلى الأربعين يوماً الأولى، ولا تعود إلى بطن الأم فيكون علقةً ومضغةً في الأربعين الأولى، فرتب على ذلك أن يكون **نفخ الروح بعد أربعين يوماً، وليس بعد مائة وعشرين يوماً**.

تقييم هذا الاتجاه

بال نظر إلى هذا الاتجاه نجد أن ما ذهب إليه من **تأويل في الأحاديث الصحيحة** — أي حديث ابن مسعود — فيه **تكلف وتشدد لا مبرر له**. ولعل تأويلهم هذا مردود بما يلي:

١ — إن جميع الروايات التي ذُكِرَ فيها نفخ الروح **ليس فيها أي نوع من التعارض**؛ بل إنها اتفقت على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً. وأما التعارض الذي يتوهمه البعض فقد جاء في الأحاديث التي **لم تتعرض لذكر الروح**، وإنما تعرضت لبيان **القَدَرِ المكتوب** على الإنسان، فاختلفت في **وقت كتابة القدر**، ولم تختلف في **وقت نفخ الروح**. لذلك وُجِدَ من العلماء القدامى — كابن القيم — من تعرض للجمع بين الروايات المتعارضة في الظاهر من حيث وقت كتابة القدر **دون المساس بما ورد في حديث ابن مسعود في وقت نفخ الروح**.

٢ — إن كل من تعرض لشرح حديث ابن مسعود من العلماء والفقهاء **لم يشكك في هذه المدة**؛ بل نقل عنهم ما يشبه **الإجماع** على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مائة وعشرين يوماً. وبالتالي **فلا يجوز نقض هذا الإجماع** بدعوى تعارض قد تكون موهومة لعدم ابتنائها على أساس قويم. بل كل ما تبنى عليه مترادفات وأدوات لغوية لم تتعرض لهذه المسألة، وبالتالي تعتبر كل التأويلات التي وردت في حديث ابن مسعود **خارجة عن محل النزاع**.

٣ — أكد الأطباء أن وقت نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً، حيث ذكروا أنه إذا كانت مرحلة الأربعين تمثل مرحلة هامة، فإن مرحلة المائة وعشرين يوماً **أشد أهمية**؛ حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن **المناطق العليا في المخ** تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها في هذه الفترة. لذلك يقرر الأطباء أن للجنين **مستويين في غاية الأهمية**:

١ عند بلوغه الأربعين، وفيها يتم تكون الأعضاء التناسلية وجذع المخ	٢ عند بلوغه أربعة أشهر، وفيها يتم تكون الدماغ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها، وبالتالي تبدأ في أداء مهام عملها

٣ الاتجاه الثالث: بعد مائة وثلاثين يوماً

مؤدى الاتجاه

أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد **مائة وثلاثين يوماً**، وهو قول **ابن عباس** و**سعيد بن المسيب**. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراً، ثم ينفخ فيه الروح».

وأخرج **الطبري** عن ابن المسيب أنه سُئِلَ عن عدة الوفاة فقيل له: ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر؟ قال: **تنفخ فيها الروح**.

تقييم هذا الاتجاه

بالنظر إلى هذا الاتجاه نجد أنه **اتجاه غير مقبول** لما يلي:

١ — إن هذا التحديد **لم يقل به أحد** مع كثرة ما نقل عن العلماء من أقوال في هذه المسألة، وبالتالي جاء مخالفاً لما عليه **جماهير علماء المسلمين**.

٢ — من الأمور التي هي محل اتفاق بين العلماء أن **قول النبي ﷺ مقدم على قول غيره** من الصحابة والتابعين. وهنا تعارض قول النبي في حديث ابن مسعود مع قول ابن عباس وابن المسيب، وقولهما **لا يقوى على معارضة قول النبي**، وبالتالي قدم قول النبي على قولهما ولا يُعَوَّلُ على ما ذهبا إليه.

٤ الاتجاه الرابع: من لحظة التلقيح (الزيجوت)

مؤدى الاتجاه

يرى هذا الاتجاه أن حياة الجنين **تبدأ من اللحظة التي تلتقي فيها النطفة بالبويضة** ليصبحا خلية واحدة تسمى **«الزيجوت»**، ومن هذه اللحظة هو **كائن حي**، يجب احترامه من أول التلقيح وحتى آخر أطواره.

وهو ما ذهب إليه **الإمام الغزالي** حيث قال: «أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإذا نفخ فيه الروح...».

ومفاد هذا الاتجاه: أن الحياة **سابقة على نفخ الروح**، وما استقبالها في الروح إلا **حدثًا في حياة الجنين**، وليس بداية له. فالحياة الإنسانية تبدأ بعد التلقيح، وما يتم بعد ذلك هو **نمو وتطور**، والنمو يكون **جسمانياً وعقلياً وروحياً**. ونفخ الروح — سواءً أكان بعد أربعين يوماً، أم كان بعد مائة وعشرين يوماً — ما هو إلا **طَوْرٌ من أطوار النمو**، فالحياة تبدأ بدايتها بالتلقيح، تمر بعد ذلك بأطوار مختلفة منها نفخ الروح.

الرأي الراجح في وقت نفخ الروح

منارة الشريعة والقانون 01105405478

الراجح – نفخ الروح بعد أربعة أشهر

بعد عرض الاتجاهات التي وردت في وقت نفخ الروح، أرى أن نفخ الروح **لا يكون إلا بعد أربعة أشهر**، وذلك **لوضوح دلالة حديث ابن مسعود** على ذلك. ويمكن الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة على النحو التالي:

١ وجه الجمع الأول – تعدد إرسال الملك

إن التوفيق بين هذه الأحاديث يكون **بحمل إرسال الملك على التعدد**، أي أن إرساله **لا يكون مرةً واحدة**؛ بل **مرات متعددة**: مرةً في **بداية الأربعين الثانية**، وأخرى في **نهاية الأربعين الثالثة** لنفخ الروح.

٢ وجه الجمع الثاني – كلا التقديرين حق

إن **كلا التقديرين حق** لصدورهما عن النبي ﷺ، فالأول: تقدير عند **انتقال النطفة إلى أطوار التخليق** التي هي أول مراتب الإنسان، والتقدير الثاني: يكون عند **كمال الخلق ونفخ الروح**.

٣ وجه الجمع الثالث – التوقيت

إن الكتابة تكون **بعد الأربعين الأولى**، والتصوير والنفخ يكون **بعد الأربعين الثالثة**، وقد يخلق في الأربعين الثانية بناءً على ما قيل من أن الجنين يخلق بعد الأربعين وأن **الذكر يخلق قبل الأنثى**.

٤ وجه الجمع الرابع – حديث ابن مسعود مُفَسِّر

إن حديث ابن مسعود **مُفَسِّرٌ للأحاديث الأخرى**؛ فإن فيه: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح». فهذه **أربعة أشهر**، وفي العشر ينفخ الملك الروح، وهذه **عدة المتوفى عنها زوجها** — كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب — ولم يختلف العلماء في أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً.

٥ وجه الجمع الخامس – معنى جمع الخلق

إن معنى **جمع الخلق** الوارد في الحديث مختلف في تفسيره على **معنيين**:

→ **المعنى الأول – تفسير ابن مسعود**

ما ورد عن **ابن مسعود** من تفسيره للحديث بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا **طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر**، ثم تمكث أربعين يوماً، ثم تنزل دمًا في الرحم فذلك جمعها. **إلا أن هذا التفسير مردود** بأنه ليس لابن مسعود؛ وإنما هو لأحد **رواة الحديث** نقله عنه بعضهم، وأدرجه في الحديث حتى وُهِمَ أنه من كلام ابن مسعود.

→ **المعنى الثاني – تفسير ابن القيم**

هو تفسير **ابن القيم**، وهو أن المراد بالجمع: **تخطيط أعضاء الجنين وتصويرها تصويراً خفيفًا**. وَصَرَّحَ ابن القيم بأن الجمع إنما يحدث **في الأربعين الأولى**، ولم يدخل فيه مرحلة العلقة ومرحلة المضغة، وإنما يتم كل طور من هذين الطورين بمضي **أربعين يوماً على نهاية المرحلة التي قبلها**، ثم يكون نفخ الروح في **بداية الأربعين الرابعة**.

٦ وجه الجمع السادس – الفهم القديم

إن العلماء المسلمين قديماً كانوا **يدركون تمام الإدراك** ويعرفون حق المعرفة أن الجنين **يكتمل نموه وخلقه وتصويره قبل تمام الأربعة أشهر**، وكان هذا أمرًا معروفًا لديهم في **الشرع والطب**:

ففي الشرع: ما دلت عليه **الأحاديث الصحيحة**.

وفي الطب: فقد نقل عن أطباء مسلمون قديماً بواسطة فقهاء عصرهم أن الجنين **يستكمل أعضاؤه قبل تمام الأربعة أشهر**، وأنه لا يوجد أدنى تعارض مع ما قرره الشرع من أن **نفخ الروح لا يتم إلا بعد الأربعة أشهر**. ولذلك يقول **النووي**: «... لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته».

مما لا شك فيه أن إجراء التجارب والأبحاث على الأجنة الإنسانية **أمر قديم** عرفته البشرية منذ عهود طويلة. وقد فحص **جالينوس** و**أبقراط** مجموعة من الأجنة المجهضة، وقام **ليوناردو دافنشي** (الإيطالي الطبيب العالم الموسيقي الرسام الفلكي الرياضي) في **القرن الخامس عشر** بدراسة بعض الأجنة.

وكانت الدراسة تتمثل في معرفة **تشريح الجنين**، وكيفية بنيته وتطورها مع تقدم الحمل، حتى تمكن العلماء من معرفة هذه المراحل المتطورة بدقة. وكانت هذه المعرفة **نبراسًا لمعرفة منشأ مختلف الشذوذات** في التكوين التي يلاحظها الأطباء للأطفال عند الولادة وما بعدها. كما أن هذه الدراسات أدت إلى معرفة وثيقة لـ**تشريح جسم الإنسان** وكيفية تكون أنسجته وأعضائه مرحلة بعد مرحلة، وكيف يمكن أن **تتوقف عملية النمو عند مرحلة معينة** مؤدية إلى عيوب خلقية خطيرة أو يسيرة.

الحكم الشرعي – يقتضي التفريق بين أمرين

منارة الشريعة والقانون 01105405478

1 الأمر الأول: تلقيح بويضات لغرض إجراء التجارب عليها

إذا تم تلقيح بويضات **لا بهدف التوالد والتكاثر**، وإنما بهدف إجراء التجارب الطبية والحيوية عليها، فأرى أن هذا الأمر **لا يجوز من الناحية الشرعية**، وذلك للأسباب الآتية:

السبب الأول: إن التلقيح الصناعي في هذه الفرضية قد **حَادَ عن هدفه** الذي أُجيز من أجله؛ فمعلوم أن الهدف من التلقيح الصناعي **معالجة العقم** الذي قد يكون لدى الزوجين أو أحدهما، بهدف **إشباع غريزة الأبوة والأمومة**. وقد قَرَّر الفقهاء أن التلقيح الصناعي يكتسب صفة الجواز الشرعي ما دام يسير وفق القواعد الموضوعة سلفًا من قبل الفقهاء **مع التزام البعد عن الشبهات**، مسترشدين في ذلك بقول النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير:

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» [صحيح البخاري]

السبب الثاني: إن تلقيح بويضات لغرض إجراء التجارب خاصةً **يتنافى مع التكريم** الذي أولاه الله للإنسان، لاسيما وأن بعض الفقهاء يرى أن **حرمة الجنين تتقرر من وقت التلقيح لا من وقت نفخ الروح**. وقد ثبت هذا التكريم بقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]

2 الأمر الثاني: البويضات الفائضة من عمليات الزرع

هذا النوع من البويضات هو الذي **يثير الإشكال**، بمعنى: هل هذا النوع من البويضات **يجوز إجراء التجارب عليه أم لا؟**

قبل الإجابة على هذا التساؤل هناك تساؤل **أكثر إفادة** في بيان الحكم في هذه النازلة، وهو: هل يمكن أن نعتبر هذه الأجنة **أجنة مجهضة**، وبالتالي تسري عليها حكمها؟

والإجهاض في أبسط صوره هو **طرد الرحم للولد أو للجنين**، يستوي في ذلك أن يكون هذا الإجهاض له ما يبرره أم لا. وقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الإجهاض إذا **لم يكن له ما يبرره شرعًا فهو جريمة منكرة**، أما إذا كان له **مسوغ معتبر** فقد اتفقت كلمتهم على جوازه، عملاً بحالة الضرورة.

تقسيم الأجنة المجهضة – ثلاثة أقسام

منارة الشريعة والقانون 01105405478

وقد اتفقت اللجان المختلفة — كما ذكر الدكتور البار — على تقسيم الأجنة المجهضة إلى **ثلاثة أقسام**:

1 القسم الأول – أجنة غير قابلة للحياة (Non-Viable)

وهي **ما قبل الأسبوع العشرين**. وهذه الأجنة **يُسْمَحُ باستخدامها للأبحاث ولنقل الأعضاء أو الأنسجة** بشرط **موافقة الأبوين** على ذلك، حتى لو كانت حية.

2 القسم الثاني – أجنة قابلة للحياة

وهي الأجنة التي وصلت **الأسبوع الرابع والعشرين وما بعد**، ووزنها يتراوح ما بين **٤٠٠ — ٥٠٠ جم**. وهذه الأجنة **قابلة للحياة المستقلة خارج الرحم** ويمكن إنقاذها. وهذه الأجنة **لا يُسْمَحُ باستخدامها**، أو أخذ أنسجة منها **إلا بعد وفاتها**. وفي هذه الحالة لا بد أن تكون الوفاة **طبيعية**، وينبغي أن تُقدَّم لهذه الأجنة **وسائل الإنعاش المتاحة**.

3 القسم الثالث – أجنة تنزل حية غير قابلة للحياة المستقلة

التي يتراوح عمرها ما بين **عشرين أسبوعاً وأربعة وعشرين أسبوعًا**. وهذه الأجنة **معضلة بالنسبة لرجال القانون**، وقد اتخذت **اللجنة الأسترالية** وبعض اللجان الأخرى قرارها **بالسماح باستخدام الأجنة التي تزن ٣٠٠ جرام فما دونها**، وعدم السماح باستخدام الأجنة التي تزن أكثر من ثلاثمائة جرام حتى تتبين وفاتها.

وأرى أنه **لا يمكن اعتبار هذه الأجنة أجنة مجهضة**؛ لأن الأجنة المجهضة تكون **ميتة غير قابلة للحياة**، أما البويضات الملقحة الفائضة فهي بويضات **قابلة للحياة** إذا ما تهيأت لها الظروف والأجواء المناسبة.

وينبغي التقرير أن **الأجنة الميتة** أو **البويضات غير القابلة للحياة** لا فائدة منها، وبالتالي فإجراء التجارب عليها أمر **غير مجد من الناحية العلمية**. ومدار الكلام يدور حول **البويضات الملقحة القابلة للحياة**.

الضوابط القانونية الدولية للتعامل مع اللقائح

وفي بريطانيا: صدر **قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشرية** عام **١٩٩٠م**. وكذلك **قانون أخلاقيات العلوم الإحيائية الفرنسي** تحت رقمي **٦٥٣ و٦٥٤ لسنة ١٩٩٤م**. وقد قاما بوضع مجموعة من **الضوابط القانونية والأخلاقية** التي تحكم عمليات المساس باللقائح والأمشاج الآدمية، ومنها:

١ ضرورة الحصول على رخصة مزاولة النشاطات التي تمس الأمشاج الآدمية	٢ احترام ضمانات حفظ واستخدام هذه الأمشاج، سواء للأغراض العلاجية أو بهدف البحث والتجريب
٣ يمنع منعاً باتاً استخدام هذه اللقائح والأمشاج لأغراض البيع والشراء والاتجار غير الأخلاقي	٤ تحريم القيام بممارسات الاستنساخ البشري تحت طائلة المتابعات المدنية والجزائية

الضوابط العامة للبحوث على الجنين

وفي جميع الأحوال يجب أن **لا تخرج البحوث العلمية** التي تجرى على الجنين عن **الحدود الشرعية والأخلاقية والقانونية والإنسانية** التي تحكم التجارب الطبية على الإنسان.

فلا يكون استخدامها بهدف:

- **الحصول على أعضاء** تستخدم للنقل.
- أن يكون الغرض هو مجرد **إشباع شهوة علمية** أو **العبث** أو التجارب التي تتم **لتغيير البنية الأساسية** لها.
- **الأبحاث المتعلقة بتغيير الجنس البشري** عن طريق التحكم في الكروموسومات.
- **تجارب التحكم في جنس الجنين**.
- **التجارب التي يكون هدفها محاولة تحقيق حمل كامل في الأنبوب** للتجريب عليه.
- **محاولات الإخصاب بين الإنسان والحيوان** بما يتعارض مع النصوص الشرعية والمواثيق الدولية والقواعد التي تفرض **الاحترام الكامل للجنس الإنساني**.

MIARA 01105405478

عرضنا فيما سبق للحكم الشرعي لإجراء التجارب الطبية على البشر — الأحياء منهم والأموات — وقررنا **الجواز الشرعي**، نظراً للمصالح التي تحققها تلك التجارب.

وأرى أن **القول بالجواز على إطلاقه دون ضوابط أو قيود** قد يؤدي إلى **التلاعب والحيدة عن الغرض** التي أُجيزت من أجله. لذا فإن هناك جملة من **القيود** التي ينبغي توافرها للقول بالجواز، وبدونها يعتبر إجراء التجارب على البشر **محرماً**.

تصنيف القيود – ثلاثة أنواع

المنارة 01105405478

١ قيود تتعلق بالتجربة ذاتها

٢ قيود تتعلق بالشخص الخاضع لها

٣ قيود تتعلق بحماية المجتمع

← ويدخل تحت كل نوع جملة من القيود التفصيلية

المطلب الأول: القيود الخاصة بالتجربة

المنارة 01105405478

١ أن يكون الهدف من التجربة هو العلاج

من القيود التي ينبغي مراعاتها أن يكون الغرض من إجراء التجربة هو **إيجاد العلاج الفعال** لمرض من الأمراض التي تصيب الإنسان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى **الرقي بمستوى الطب**، مما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

فالتجارب العلاجية من المفترض أن تكون لها **نتائج إيجابية ملموسة**، يستوي في ذلك أن تكون هذه التجارب متعلقة بـ:

١ تصنيع الدواء

٢ ابتكار وسائل جديدة يمكن العلاج على أساسها

٣ رفع كفاءة وتحسين الطرق الموجودة بالفعل

! ولعل هذا الأمر يجد ضرورته في العصر الحاضر مع ظهور الأمراض المعدية الفتاكة

إذا حادت التجربة عن هذا الهدف

فإنها تكون **غير مشروعة**، ولا يجوز إجراؤها أو الإقدام عليها، كأن تتخذ وسيلة لـ:

- تحقيق **شهرة للفريق الطبي**.
- مجرد **الحصول على كشف علمي** مما يستتبع معه مكاسب مادية.
- إشباع الرغبة في **الفضول العلمي فقط** دون أن يكون لها تأثير في علاج المرضى.

ففي هذه الحالات ومثيلاتها تكون التجربة قد **حادت عن الهدف** الذي وُضِعَتْ من أجله.

وهذا يفترض بالضرورة أن يكون الهدف من التجربة هو **مصلحة المريض**، وتطوير العلاج الخاص بمشكلة مرضية معينة، كما يجب الالتزام بـ**القواعد الأساسية** من حيث:

١ التصميم الجيد للبحث	٢ حماية سرية المشاركين والعدل في معاملتهم
٣ اعتبارات الأخطاء والمزايا	٤ مراقبة جميع المعلومات مضافاً إلى ذلك الإقرار الحر

ولا يكفي مجرد استهداف العلاج؛ بل ينبغي أن يكون هذا الهدف **حقيقياً وليس وهمياً**، بمعنى أن يكون معتمداً على **حقائق ثابتة**، لا على أوهام علمية لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها على أرض الواقع.

الموقف الفقهي والقضائي

المنارة 01105405478

وقد استقر **الفقه والقضاء في فرنسا** على تقرير مسئولية الطبيب إذا لم يكن القصد من إجراء التجربة هو **علاج المريض أو تحسين حالته**، وإنما تحقيق أهداف أخرى، حتى ولو كان يُرجى منها **تقدم العلوم الطبية**، أو كشف علاجات لأمراض أخرى خطيرة، ولو تم إجراؤها بناءً على **الرضا**؛ إذ الرضا في هذه الحالة **لم يصادف محله**.

ويقرر الفقيه الفرنسي «**سافاتيه**» أن إجراء التجارب على كائن بشري دون وجود **ضرورة تبررها** يعد **خَرْقاً من الطبيب** لواجب احترام سلامة الإنسان، وهذا الواجب مستمد من **النظام العام**، ولا يستطيع الطبيب التحلل منه إلا **لمصلحة المريض**. لذا لا يباح له إجراء تجارب خطيرة لا فائدة منها لصحة المريض بزعم أنها ترمي إلى بحث علمي يهدف إلى تطوير العلاج.

وهو ما أقرته **محكمة ليون الفرنسية** في حكم لها صدر عام **١٩٣١م**.

وتجدر الإشارة إلى أنه من **الصعوبة بمكان وضع قاعدة** يمكن بمقتضاها تحقيق القدر المأمول من التوازن؛ حيث إن المسألة في غالب الأحوال **مسألة فردية**، فالأخطار المتوقعة من تجربة علاجية معينة **تختلف من شخص لآخر**، لاختلاف:

١ الظروف التي يتعرض لها كل منهما	٢ حالته الصحية
٣ مدى قدرته على تحمل أخطار التجربة	← وخروجاً من هذا المأزق يمكن النظر لظروف كل حالة على حدة

وبمقتضى هذا القيد ينبغي أن **لا يكون أمام الطبيب وسيلة أخرى** لعلاج الأمراض التي يجري تجارب علمية لاكتشاف علاج آخر لها، وأن يحرص كل الحرص على **التأني** في إجرائها متى كان من المحتمل أن يترتب عليها **أضرار جسيمة** بمن يخضع لها.

وبما أن الأضرار **متوقعة للتجربة الطبية** فإنه يتعين أن تكون **النتائج الإيجابية المتوقع الوصول إليها** من خلالها أكثر بكثير من **المخاطر المتوقع حدوثها** بسبب هذه التجربة.

٢ أن تتم التجربة وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها

يشترط للاعتراف بشرعية التجارب الطبية والسماح بإجرائها على البشر أن تتم وفقاً **للأسس العلمية المتعارف عليها** في المجال الطبي، وأن تبتعد كل البعد عن **الأهواء الشخصية** و**الخيالات العلمية** و**محاولات الإبداع غير المنطقي**.

سبب اشتراط هذا القيد

أن **محل هذه التجارب هو الإنسان**، وبالتالي فإن قيام هذه التجارب على أسس غير صحيحة **يُعَرِّضُ حياته للخطر المحقق**، الأمر الذي يُحوّلُ هذه التجربة من **عمل مشروع** له هدفه النبيل إلى **فعل يمثل تعدياً على الجسم** مما يُدْرِجُه في دائرة الحرمة، إضافةً إلى **المسئولية القانونية** التي من الممكن ترتيبها بناءً على ذلك.

أضف إلى ذلك أن التجربة الطبية تقوم على **افتراض مبدئي** هو **مفترض البحث العلمي**؛ فالتجربة بحث هادف علمياً يسعى إلى **الكشف عن جديد في العلوم الطبية**، لذلك كان منطقياً وبديهياً اشتراط هذا الشرط.

ويترتب على ذلك أن يكون الطبيب القائم بالتجربة على **قدر وافر من الكفاءة العلمية**، بمعنى أن يكون على علم بـ**آخر ما توصل إليه العلم** من بحوث في مجال التجربة التي يقوم بها، وهو ما يلتقي **بالمبادئ العامة في المسئولية الطبية**.

المقصود بالأسس العلمية

هي **القواعد التي وضعها المختصون في المجال الطبي**، والتي تحدد المسار الذي يتوجب على الباحثين سلوكه أثناء إجراء التجارب؛ حيث يُراعى في هذه الأسس **أسلم الطرق والمناهج** للوصول إلى الهدف المنشود **بأقل قدر ممكن من الأضرار**، يستوي في ذلك الأضرار التي من الممكن أن تعود على القائم بالتجربة، أو تلك التي قد تعود على الشخص الخاضع لها.

ويقرر البعض أن من بين الأسس المتبعة في هذا الخصوص أن **تُجرَى التجارب أولاً على الحيوانات** قبل إجرائها على الإنسان، حتى تكون الفحوص المخبرية جميعها قد تمت على الحيوان، وبالتالي معرفة آثارها، وظهور فرص الشفاء واحتمالاته.

إلا أن البعض عارض وبشدة اشتراط هذا الشرط، حيث قال: «قد يُقال إن بإمكان الطبيب إجراء هذه التجارب الطبية على الحيوانات وليس على الإنسان، ونقول إن هذا **صحيح في جملته، غير صحيح على إطلاق**؛ إذ ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن هناك **بعض الأمراض التي تصيب الحيوان ولا تصيب الإنسان**، كما أن هناك **العديد من الأمراض تقتصر على الإنسان دون الحيوان** — هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن العلماء لاحظوا أن **الدواء الواحد قد يُحدِثُ على الحيوان آثاراً أو مضاعفات** تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الآثار التي يُحدِثُها في الإنسان».

موقف إعلان هلسنكي

وقد أشار إعلان «**هلسنكي**» ضمن مبادئه الأساسية إلى **ضرورة توافر هذا القيد**، حيث نص في **المبدأ الأول** على أن: «التجارب الطبية التي تجري على البشر يجب أن تتفق مع المبادئ العلمية المقبولة بوجه عام، وينبغي أن تقوم على **كفاءة أداء التجارب المختبرة على الحيوانات**، وعلى **معرفة وافية بالبحوث العلمية السابق تنفيذها**».

المراحل والإجراءات الواجبة قبل التجربة

المنارة 01105405478

ويقرر البعض أن التجربة التي يتم إجراؤها على الإنسان لا بد وأن **تَمُرَّ بعدة مراحل** أو إجراءات أهمها:

١. إجراء التجربة على **حيوانات تتشابه مع الإنسان في صفاتها البيولوجية**

٢. **تسجيل جميع الملاحظات والآثار والنتائج**

٣. **إخضاع النتائج للدراسات والمناقشات المستفيضة، لضمان سلامة المتطوعين من البشر، مع الأخذ في الاعتبار وضع الضمانات الكافية**

٤. **وضع تقرير مفصل قبل البدء في التجربة تبين فيه مراحل التجربة، وكذلك الخطوات المتعلقة بها**

٥. **الحصول على موافقة مسبقة على إجراء التجربة من قبل الهيئة الطبية والشرعية المختصة، وذلك منعاً لاستغلال التجارب في أغراض مخالفة للشرع، ومنافية للأعراف العلمية المعتبرة**

وقد تعرض الفقهاء صراحةً لهذا الأمر، حيث أوجبوا على الطبيب **مراعاة القواعد المتعارف عليها في مهنة الطب** وأوجبوا عليه **الضمان** حالة مخالفته لتلك القواعد.

قال **الشافعي**: «وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَ غُلَامَهُ أَوْ يُبَيْطِرَ دَابَّتَهُ فَتَلِفُوا مِنْ فِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مِمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتِلْكَ الصَّنَاعَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ وَكَانَ عَالِمًا بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ».

٣ انعدام الخطر في التجربة

مقتضى هذا القيد **ألا يكون في إجراء التجربة تعريض حياة الخاضع لها للخطر**، أو إصابته **بضرر مستديم**، وأن تكون **الآلام التي يتعرض لها تتناسب** مع ما قد ينتج عنها من علاج يخفف آلام المرضى.

ويقترح البعض أن تتم هذه التجارب **تحت إشراف نقابة الأطباء**؛ إذ هي الجهة الوحيدة التي تملك المقدرة على **اختيار الأطباء ذوي الكفاءة** للقيام بمثل هذه التجارب.

سبب اشتراط هذا القيد

أن **الشريعة الإسلامية قررت أن إيقاع الضرر بالغير محرم شرعاً**، حيث قرر الفقهاء تلك **القاعدة الذهبية** التي تقضي بأنه:

«لا ضرر ولا ضرار»

وهذه القاعدة **أصل عظيم من أصول الشريعة**، وهي كذلك **أصل في تحريم التجارب الطبية** التي تؤدي إلى إلحاق أضرار، سواءً وقعت هذه الأضرار على **الخاضع للتجربة**، أو على **غيره**.

ومع تقرير الفقهاء لذلك، إلا أنهم قرروا أنه **يُغتفى عن الضرر اليسير غير المؤثر**؛ حيث إن **المفاسد إذا تعارضت رُوعِيَ أعظمها ضرراً بارتكاب أدناهما**.

٤ توافر الكفاءة العلمية في القائم بالتجربة

ينبغي أن تتوافر في **الشخص أو الفريق القائم بالتجربة الطبية الكفاءة العلمية**؛ وإنما تم اشتراط هذا الشرط حتى يمكن **التقليل من المخاطر** التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة.

تعريف الطبيب

والطبيب بالمفهوم العام هو **العارف بتركيب البدن** وجراح الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها، وعلاماتها، والأدوية النافعة لها، والاعتياض عمَّا لم يوجد منها، والوجد في استخراجها، وطريق مداواتها. **ومن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى**، ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له فيه.

MARA 01105405478

وقد أشار الطبيب **أبو بكر الرازي** إلى هذا الأمر بقوله: «إن الطبيب يجب أن **يرجع إلى الأصول الثابتة في علم الطب**، وخواص الأشياء المستعملة في العلاج، **ولا ينظر إلى ما يهذي به الجهال** أن فلاناً قد وقعت له التجربة في غير علم يرجع إليه، فإن ذلك لا يكون ولو كان أطول الناس عمراً، ونفع له من علاج موفق فهو من **حسن الإتقان**. وهؤلاء ليسوا يرجعون إلى علم أصول الصنعة، إنهم ينظرون في الكتب فيستعملون منها العلاجات، وليسوا يعلمون أن الأشياء الموجودة فيها ليست هي الأشياء التي تستعمل بأعيانها».

والكفاءة العلمية والمهنية التي ينبغي توافرها **تُوجِبُ على القائم بالتجربة متابعة المستجدات والتطورات** على الساحة الطبية؛ نظراً لأن التجربة تستهدف تحقيق آمال البشرية في **القضاء على العديد من الأمراض** التي باتت عائقاً أمام التقدم والازدهار، الأمر الذي استتبع بدوره أن أصبح **الطب علماً أكثر من كونه فناً تجريبياً**، وليس مجرد ملاحظة، مما أدى في نهاية المطاف إلى **ازدواج دور الطبيب**.

وقد جاء في كلام الفقهاء المسلمين صراحةً ما يدل على اشتراط كون الطبيب — عموماً — **ذو كفاءة وخبرة**، بل عبروا عن الطبيب الكفء بـ**الطبيب الحاذق**.

واشتراط الكفاءة العلمية في القائم بالتجربة من الأمور **المنطقية المسلم بها**؛ لأن إقدامه على ذلك مع عدم الكفاءة يُرَتِّبُ **المسئولية في حقه**. وقد صرح الفقهاء بوجوب **الضمان على الطبيب غير الكفء**، وسقوطه عن الكفء.

قال **ابن رشد**: «وَأَمَّا الطَّبِيبُ وَمَا أَشْبَهَهُ إذَا أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ، وَكَانَ **مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ** فِي النَّفْسِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ وَفِي مَالِهِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، **وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ، وَالسَّجْنُ، وَالدِّيَةُ**، قِيلَ: فِي مَالِهِ، وَقِيلَ: عَلَى الْعَاقِلَةِ».

وقال **ابن مفلح**: «وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا خَتَّانٍ وَلَا طَبِيبٍ وَلَا بَيْطَارٍ **عُرِفَ حِذْقُهُمْ** وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ».

ولعل وضع هذا القيد يأتي من منطلق **الطبيعة المهنية للطبيب**؛ حيث يتوجب على الطبيب القائم بالتجربة أن يكون عالماً **بجانبين من العلوم**:

1 الجانب الأول – العلوم الطبية الثابتة

وهي التي أقرها علماء الطب قديماً وحديثاً، كالمواد العلمية المقررة في الجامعات والمعاهد الطبية، والتي تعتبر من المسلمات في مجال التجارب الطبية، كالقواعد الخاصة بالفحوصات التي تجرى قبل التجربة والاحتياطات والتدابير التي يتوجب على الطبيب اتخاذها، حيث تعتبر هذه الأمور من الأمور **الثابتة والتي لا تتغير بتغير الزمان**.

2 الجانب الثاني – العلوم الطبية المستجدة

وهي العلوم والمعارف التي **يطرأ اكتشافها**، أي: القواعد التي يفرزها العلم الحديث والتطورات التي يفرزها **الواقع الطبي**.

وبناءً على ذلك لو كان الطبيب القائم بالتجربة **غير كفء**، ولا تتوافر فيه المقومات العلمية اللازمة، ومع ذلك باشر التجربة وترتب عليها إضرار بالخاضع لها، كما لو أدَّى ذلك إلى:

١ فَقْدِ عضو من الأعضاء

٢ التأثير على حاسة من الحواس — كحاسة الشم أو السمع أو البصر

٣ أو أصيب بضررٍ يؤثر على مباشرته لحياته

← فإن الضمان يجب على القائم بالتجربة

وقد اعتبر **القضاء الفرنسي** الكفاءة العلمية للقائم على التجربة من الشروط المعتبرة عند إجراء التجربة، حيث قضت **محكمة ليون الفرنسية** بمسئولية **طالب بكلية الطب** قام بإجراء تجربة طبية تحت إشراف أحد الأطباء لصبي في العاشرة من عمره كان مصاباً بقراع، وأدى ذلك إلى حدوث أضرار للصبي، فقامت المحكمة **بمعاقبته لافتقاره إلى الكفاءة العلمية**.

والكفاءة المطلوبة في الطبيب الذي يجري التجربة **تتطلب توافر أمرين**:

١ الأمر الأول – الترخيص

أن يكون من **الأشخاص المصرح لهم بمزاولة المهنة** وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

٢ الأمر الثاني – اللياقة والنزاهة

أن يكون **متمتعاً باللياقة والنزاهة** في تعامله مع مرضاه الذين يخضعون لإجراء التجارب عليهم. ومن المظاهر الأساسية في هذا الخصوص: **التسوية بين المرضى في الرعاية** و**عدم التمييز بينهم** لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز التمييز بسبب **المركز الأدبي أو الاجتماعي أو المالي**؛ بل يجب عليه أن **يقدم المساعدة في كل الظروف**، وأن يلتزم **موقفاً لائقاً واعياً** تجاه أي شخص يقوم بإجراء التجربة عليه.

٥ ازدياد احتمالات نجاح التجربة

من القيود التي يمكن إيرادها على مشروعية التجارب الطبية على البشر أن تكون **احتمالات نجاح التجربة متزايدة** وفقاً للقوانين العلمية المعترف بها، وهو ما يعني أن تكون **الأخطار** التي من الممكن أن يتعرض لها الخاضع للتجربة **مقبولة** إذا ما قورنت **بالمنفعة المتوخاة** منها.

وهذا الأمر يعني بدوره تحقيق **قدر معقول من التوازن** بين نتائج التجربة وأعراض المرض وعواقبه؛ بحيث **لا يُقْدِمُ الطبيب على إجرائها إذا كانت احتمالات فشلها تزيد على احتمالات نجاحها**.

NADA 01105405478

ولعل أبرز تطبيق لهذا القيد ما ورد في **الفقه الإسلامي** متعلقاً بالموازنة **بين المصالح والمفاسد**، و**ارتكاب أخف الضررين**؛ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر هذه التجارب دون أن تشتمل على **مخاطر محتملة**، ومنها ما قد يقع بالفعل، وفي الوقت ذاته هناك **مصالح يُرْجَى تحقيقها** عند نجاح هذه التجربة، لذا كان لا بد من تحقيق **الموازنة بين المصالح والمفاسد**.

يقول **العز بن عبد السلام**: «لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَنَّ تَحْصِيلَ الْمَصَالِحِ الْمَحْضَةِ، وَدَرْءَ الْمَفَاسِدِ الْمَحْضَةِ عَنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَعَنْ غَيْرِهِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ أَرْجَحِ الْمَصَالِحِ فَأَرْجَحِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ دَرْءَ أَفْسَدِ الْمَفَاسِدِ فَأَفْسَدِهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَصَالِحِ الرَّاجِحَةِ عَلَى الْمَرْجُوحَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ الرَّاجِحَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَرْجُوحَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَاتَّفَقَ الْحُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ، وَعَلَى تَحْصِيلِ الْأَفْضَلِ فَالْأَفْضَلِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ».

ميثاق هلسنكي وتطوره — 1964م

وقد تضمن ميثاق «**هلسنكي**» الصادر سنة **١٩٦٤م** والمعدل سنة **١٩٧٥م** ثم في سنة **٢٠٠٠م** — والذي ينظم كيفية إجراء التجارب الطبية والدوائية على الإنسان — **هذا القيد**، حيث أعطى للطبيب أثناء علاج المريض **الحق في استعمال الطرق المستحدثة** في التشخيص والعلاج، والموازنة بينها في سياق العلاج الطبي الناجح، وفقاً لـ**الفوائد المرجوة** و**المخاطر المحتملة** الكامنة في هذه الطرق العلاجية المستجدة.

وبناءً على ذلك: ففي التجارب الطبية ينبغي **المقارنة بين الخطر** الذي تتضمنه التجربة **وبين الفوائد المتوقعة** منها، ويدخل في المقارنة كذلك الموازنة بين هذه الفائدة وبين **عجز الطرق التقليدية** عن تقديم العلاج، الأمر الذي يسمح بقبول **درجةٍ أكبر من المخاطر**.

وهذه القاعدة تعتبر **جوهرية وأساسية** عند البحث عن حكم التجارب الطبية، إلا أنها تتسم **بالصعوبة نوعاً ما**؛ حيث إن الالتزام به يحتاج إلى **اتخاذ القرار السليم**، وهو ما يختلف في كل حالة عن الأخرى، أي أنه **قرار يتعلق بحالة فردية**. والمألوف في نطاق التجارب الطبية **قبول خطر قد يكون كبيراً** في بعض الحالات، لكن يتعين في جميع الأحوال أن يظل **متناسباً مع الفائدة المرجوة** على وجه صحيح للشخص الخاضع للتجربة، وتبقى **المصلحة العامة** التي يحققها البحث العلمي من هذا الفرض **غير ذات وزن كبير** في المقارنة؛ لأن الغرض هو **تحقيق المصلحة الفردية أولاً**.

٦ إجراء التجربة على الحيوانات مسبقاً

يشترط البعض لإجراء التجارب الطبية على الإنسان أن يكون قد تمَّ **إجراؤها مسبقاً على الحيوانات** القريبة من الإنسان من حيث التكوين، وأن تكون **نتائجها إيجابية**، بحيث تشجع لإجرائها على الإنسان.

والهدف من هذا الشرط هو **الحد من الأضرار** التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة؛ فمما لا شك فيه أن إجراء التجربة أولاً على الحيوان — بعد اختبارها معملياً — من شأنه **تجنب المضار** التي ظهرت على الحيوان عند تجريبها عليه.

المنارة 01105405478

المطلب الثاني: القيود الخاصة بالأشخاص الخاضعين للتجارب

المنارة 01105405478

1 الرضا بإجراء التجربة

تثير مسألة الرضا بإجراء التجارب الطبية على الإنسان **إشكالية وقوع الاعتداء على جسم الإنسان** وتعريضه للخطر، وفي المقابل هناك **ضرورة طبية ومجتمعية** لإجرائها. وخروجاً من هذا المأزق اشترط القائلون بالجواز **الرضا** من قِبَل الشخص الخاضع للتجربة.

وقد جاء اشتراط الرضا في التجارب الطبية **ليتوافق مع طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض** أدبياً وأخلاقياً، وتعارضها مع ضرورة إيجاد علاج فعال. وقد اشترط الفقهاء الرضا في **عقد العلاج الطبي** — وهو عمل مألوف — فمن باب أولى ينبغي اشتراطه عند إجراء **التجارب**، الذي يعد عملاً غير مألوف.

شروط الرضا المؤثر في إجراء التجارب

المنارة 01105405478

وقد اشترط الفقهاء فيمن يصدر منه الرضا المؤثر في إجراء التجارب **جملة شروط**، منها:

1 الشرط الأول – التكليف

فالمكلف هو المحكوم عليه، وهو **الشخص الذي تعلق خطاب الله بفعله**، ولا يكون الشخص مكلفاً إلا إذا توافرت فيه **الأهلية اللازمة**، وقد قرر العلماء أن أهلية الشخص تتحقق بتوافر **البلوغ والعقل**.

وبناءً على ذلك، فـ**الصبي ومن لا عقل له** — كالمجنون والنائم — **لا يمكن تحصيل الموافقة منهما** على إجراء التجارب الطبية؛ حيث إن كلاً منهما لا يفهم ما يوافق عليه، ولا يُدرِكُ مدى الخطورة التي من الممكن أن يتعرض لها. وقد رفع الإسلام القلم عنهم، فقد روت عائشة عن النبي ﷺ قال:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

[السنن الكبرى للبيهقي]

يقول **الآمدي**: المجنون «والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيضاً إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يُطَاقُ؛ لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله. وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، غير أنه أيضاً غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل».

٢ الشرط الثاني – إرادة حرة غير متأثرة

فيجب أن تكون إرادة الشخص **خالية من عيوب الإرادة**، فلا ينعقد الرضا صحيحاً إذا وقع تحت **إكراه** أو **غش** أو **تدليس** أو أي سبب آخر من شأنه أن يعيب الإرادة.

ويمكن اعتبار الرضا **بمثابة الإذن**؛ فالرضا يعني في جوهره إذن المريض للطبيب في القيام بإجراء التجربة عليه.

صور الإذن في التجارب الطبية

المنارة 01105405478

١ الصورة الأولى – الإذن المطلق

وهو أن **يأذن المريض للطبيب بإجراء التجربة المتفق عليها**، مع السماح له بالقيام بأي عمل طبي آخر قد يرى الطبيب أنه مفيد للمريض. وفي هذه الحالة يكون للطبيب الحق في القيام بأي عمل يستدعي الأمر القيام به.

٢ الصورة الثانية – الإذن المقيد

وهو **تقييد المريض الطبيب في القيام بالتجربة فقط** دون ما سواها من الأعمال.

وحتى يكون **الإذن المقيد منتجاً لآثاره** ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١. أن يصدر ممن يملك الحق في إصداره مع توافر الأهلية اللازمة للإصدار، ويتمثل ذلك في الشخص الخاضع للتجربة نفسه، أو من يقوم مقامه — سواءً كان ولياً خاصاً أو ولياً عاماً كالحاكم

٢. أن تكون صيغة الإذن دالة على إجازة مباشرة الطبيب للتجربة صراحةً. وفي تقديري أن الإذن الضمني لا يعتد به في مسألة التجارب الطبية نظراً لخطورة المسألة وتعلقها بحياة الإنسان

٣. أن تكون التجربة محل الإذن مشروعة، فإذا كان الفعل محل التجربة محرماً كان الإذن غير معتبر ولا قيمة له؛ لأن الأعمال الطبية — ومنها التجارب — ما أُبيحت إلا لغرض جلب المصالح ودرء المفاسد

٤. أن يتم الحصول على الإذن قبل مباشرة العلاج؛ إذ القاعدة أنه لا يجوز لإنسان أن يتصرف في جسم إنسان آخر إلا بإذن منه

وقد أكد **ابن القيم** ذلك بقوله: «لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، **ولا يسقط الإثم عنه بالإذن**».

واشتراط الرضا يوجب على الطبيب **التزاماً رئيساً** يتمثل في **تبصير المريض**؛ إذ يجب على الطبيب تبصير المريض بـ:

١ **طبيعة التجربة**

٢ **نوعية العلاج المقترح**

٣ **المخاطر التي من الممكن أن تتحقق**

← وبناءً على ذلك فإن أي كذب أو إخفاء أي معلومات تتعلق بالتجربة يعد من باب الخطأ الذي يستوجب المسؤولية

حيث إن المريض **لا يستطيع أن يقبل أو يرفض** تحمل المخاطر الناجمة عن إجراء التجربة إلا إذا تم تبصيره، حتى يصدر الرضا عن **بينة وعلم كامل بحقيقة الأمر**.

ومع ضرورة هذا الالتزام، إلا أنه وُجد **اتجاه في الفقه القانوني** يرى أنه **يجوز للطبيب أن يكذب على مريضه في حدود معينة**.

ولكن أنصار هذا الاتجاه — وإن كانوا يرون أنه يجوز للطبيب الكذب على المريض في حدود معينة — إلا أن هذا الكذب **يجب أن لا يصل إلى جعل الرضا بالتجربة في حد ذاته معيباً**. لذا **مَيَّزَ** أنصار هذا الاتجاه بين **نوعين من الكذب** في هذا الخصوص:

الكذب الممنوع (المتشائم)

وهو الكذب الذي ينطوي على **إخفاء العلامات أو النتائج الحسنة** عن المريض، وحمله على الاعتقاد بأن هناك **علامات أو عواقب أكثر خطورة** مما أظهرته الفحوص والتحاليل الطبية. وهذا الكذب **لا يوجد ما يبرره**؛ لأنه ليس في مصلحة المريض.

الكذب المتفائل (المسموح)

ويعني قيام الطبيب **بإخفاء حقيقة المرض وعواقبه الوخيمة** على المريض، ما دام ذكر الحقيقة لن يكون له إلا **أثراً سلبياً على حالته النفسية**، ولن يفيد في علاجه.

ووفقاً لهذا الاتجاه فإنه يجب النظر إلى **الهدف من وراء هذا الكذب**؛ فالكذب لا يكون من قبيل الخطأ إلا إذا **لم يكن في مصلحة المريض**.

رأي المؤلف في مسألة الكذب

وأرى أن ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه وإن كان **مقبولاً في العلاج الطبي بشكل عام** إلا أنه **يصعب قبوله في مجال التجارب الطبية**. ففي تقديري أن **الكذب بكل أنواعه ممنوع في نطاق التجارب الطبية**؛ فيجب أن يتم تبصير المريض بالتجربة واحتمالاتها والأخطار التي من الممكن تحققها **بصدق وشفافية**، ولا يجوز الكذب على المريض بحجة استدراجه للموافقة على خضوعه للتجربة. وإن حدث ذلك فإنه **يستوجب المسؤولية القانونية**.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: في أي مرحلة من المراحل ينبغي توافر الرضا؟ في هذا الصدد ينبغي **التمييز بين نوعين من الفحوصات**:

1 النوع الأول – الفحوصات التشخيصية

وهي **الفحوصات المبدئية** التي يجريها الطبيب على المريض محل التجربة بقصد تحديد **مدى صلاحيته لإجراء التجربة عليه**. ويطلق على هذه الفحوصات اسم **الفحوصات النظرية**، ويراد بها **إصغاء الطبيب لأقوال المريض** فيما يتعلق ببياناته الشخصية، كالسن والجنس وتاريخ المراجعات السابقة، والمرض الذي يعاني منه وأعراضه.

2 النوع الثاني – الفحوصات التطبيقية

وهي **الإجراءات الفنية** التي يجريها الطبيب على جسد المريض بقصد التشخيص، كالكشف عليه بالوسائل الطبية وما إلى ذلك.

وهذا التشخيص التطبيقي **يعتمد غالباً على التشخيص النظري** لتحديد مدى حاجة المريض إلى معرفة حقيقة مرضه عن طريق الفحوصات، وذلك لتحديد **مدى صلاحيته لإجراء التجربة عليه**.

إشكاليات الرضا في إجراء التجارب الطبية

المنارة 01105405478

لا خلاف في سهولة التعرف على الرضا من الشخص **المكلف** الذي يستطيع التعبير عن إرادته، إلا أن **الصعوبة تكمن** في الأشخاص الخاضعين للتجربة والذين يصعب التعرف على إرادتهم، إما **لعجزهم الجزئي** كالقاصر والأسير والمحكوم عليهم بالإعدام، أو **لعجزهم الكلي** كالموتى.

أ الرضا من القاصر

تعريف القاصر

القاصر **خلاف المكلف**، أي: الشخص الذي يرفع عنه حكم التكليف، ويطلق على **الصغير دون البلوغ**.

حكم رضاء القاصر بالتجربة: اتفق الفقهاء على أن **الأعمال الطبية لا يجوز ممارستها على جسد القاصر**؛ لأن إذن القاصر **كعدمه** ولا يعتد به شرعاً، **ويضمن الطبيب الأضرار** التي يحدثها في جسد القاصر.

جاء في **المغني**: «وَإِنْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ قَطَعَ سِلْعَةً مِنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ مِنْ صَبِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَسَرَتْ جِنَايَتُهُ، **ضَمِنَ**؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ فَعَلَهُ مَنْ أَذِنَا لَهُ، **لَمْ يَضْمَنْ**؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا».

وقال **الشافعي**: «وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبِيٍّ لَيْسَ بِابْنِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ وَلَيْسَ لَهُ بِوَلِيٍّ إلَى خَتَّانٍ أَوْ طَبِيبٍ فَقَالَ: اخْتِنْ هَذَا أَوْ بُطَّ هَذَا الْجُرْحَ لَهُ أَوْ اقْطَعْ هَذَا الطَّرَفَ لَهُ مِنْ قُرْحَةٍ بِهِ فَتَلِفَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ وَالْخَتَّانِ **دِيَتُهُ** وَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَلَا يَرْجِعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ وَهُوَ كَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ».

ومضمون ما سبق أن الأعمال الطبية التي تجري على جسد القاصر **يلزم فيها إذن الولي**، إلا أن الولي فيما يتعلق بالإذن في هذه الحالة **مقيد بما فيه مصلحة القاصر**.

المنارة 01105405478

تقسيم الأعمال الطبية على جسد القاصر

وفي تقديري أنه يمكن تقسيم الأعمال الطبية التي من الممكن إجراؤها على جسد القاصر إلى **ثلاثة أقسام**:

القسم الأول – الأعمال الطبية العاجلة

وهي التي تتطلب **تدخلاً سريعاً**، حفاظاً على حياة القاصر، والتي يؤدي التأخر في التدخل فيها إلى إصابة القاصر **بأضرار بالغة**، كما في حالات الحوادث والأمراض المفاجئة. ففي هذه الحالات **لا يتوجب الانتظار لحين إذن الولي**، وعلى الطبيب **التدخل السريع**، شريطة أن يكون تدخله وفق **الأصول الطبية المتعارف عليها**، فإن لم يكن كذلك كان **ضامناً** لما أتلفه من جسد القاصر.

وقد أشار **ابن القيم** رحمه الله إلى هذه الحالة حيث قال عند ذكره لأقسام الأطباء: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، فقطع صبي من رجل أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبياً بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا: **يضمن**؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه. وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون **لم يضمن**، ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً؛ لأنه **محسن، وما على المحسنين من سبيل**.

القسم الثاني – الأعمال الطبية غير العاجلة

وهي الأعمال التي **لا تتطلب سرعةً في إجرائها** ويمكن تأخيرها، كالعمليات التي تتم على جسد القاصر من غير أن تتطلب سرعة، ولا يضر تأخيرها. فهذه الأعمال **لا يجوز الإقدام عليها إلا بإذن الولي**، وإن قام بها الطبيب من غير إذنه وتلف منه شيء كان **ضامناً**.

القسم الثالث – الأعمال الطبية الخطيرة وغير المحتاج إليها

ويمثل لها بـ**التجارب الطبية على جسد القاصر**، فإنه يجب **التفريق بين نوعين من التجارب** في هذا القسم:

النوع الأول – التجارب الخطيرة

وهي التجارب التي تؤدي إلى **آثار خطيرة على القاصر**، كأن يحتمل فيها هلاكه أو يصاب بأضرار خطيرة، كالعاهات والتشوهات أو احتمال فقدان أحد أعضائه، أو أحد مقومات جسده. وهذا النوع من التجارب **يحرم الإقدام عليه شرعاً**، ولا عبرة بالموافقة الصادرة من الولي؛ لأن الإذن في مثل هذه الحالات **خارج عن حدود الولاية**، ولا يملكه الولي، وإن أذن الولي بذلك **صار ضامناً**.

النوع الثاني – التجارب العادية

وهي التجارب التي **لا تحمل خطراً على القاصر** من أي وجه كان. وهذه التجارب إن كان فيها **مصلحة للقاصر** — كأن تساهم في علاجه من مرض أصيب به، أو غير ذلك مما يحقق له فائدة — فلا حاجة إلى إذن الولي في القيام بها، لأن فيها النفع للقاصر. أما إذا لم تكن للقاصر فيها مصلحة، وكان الغرض هو **إيجاد علاج لمرض** أو غير ذلك مما يحقق تقدماً في الطب، فأرى أنه **لا يجوز في هذه الحالة إجراء التجارب على جسد القاصر**، حتى ولو أذن الولي؛ لأن هذه التجارب تنطوي على بعض التصرفات التي تؤدي إلى **آثار نفسية سيئة على القاصر**.

قرار مجمع الفقه الإسلامي 67/5/7

والقول بضرورة **الرضا الصريح والمستنير** هو ما ذهب إليه **مجمع الفقه الإسلامي** في قراره رقم **٦٧(٥/٧)**، حيث نص على أنه: «لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من **موافقة الشخص التام الأهلية**، بصورة خالية من الإكراه — كالمساجين — أو لأغراض مادية — كالمساكين — ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر. **ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء**».

ب الرضا من الأسرى والمسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام

تعتبر مشكلة الرضا الصادر من الأسرى والمسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام من **المشاكل بالغة الأهمية** في هذا الخصوص؛ لاسيما وأن الأسرى وكذلك المحكوم عليهم **يفقدون جزءً من إرادتهم نوعاً ما**، ويكون ذلك في بعض الأحيان **سبباً لإجراء التجارب عليهم** دون اعتبار لرضاهم.

فعلى سبيل المثال:

١ يُستخدم بعض السجناء في التبرع بالدم قسراً في بعض الأحيان

٢ أو يتبرعون مقابل تخفيف قيود السجن

٣ وفي بعض البلدان يُستخدم السجناء لإجراء التجارب الطبية عليهم رغماً عنهم

٤ ويتم تجريب العقاقير عليهم قبل نزولها للأسواق

فهذه الفئة **لا تتمتع بالحرية الكاملة** في التعبير عن رضاها؛ فتقييد حريتهم من شأنه أن **يدفعهم للخضوع والموافقة** من أجل الحصول على مكافأة، أو الخفض من العقوبة المقررة عليهم. وفي أحيان كثيرة قد **يُنتَزَعُ الرضا تحت الضغط أو الإكراه**.

وذهب البعض إلى **وجوب حظر** التجارب الطبية التي تُجْرَى على السجناء، **حتى ولو صدر منهم الرضا** بإجرائها على أجسادهم؛ لأنهم يجدون أنفسهم في حالة **تبعية أو ارتباط** يرجع إلى حالتهم ذاتها. ولعل المناداة بذلك ليست إلا نتيجةً لما حدث في **العديد من الولايات الأمريكية** من إخضاع المسجونين لإجراء التجارب عليهم قسراً.

إلا أن هذه الأمر كان محل نقد من قبل الكثيرين، على أساس أن مشاركة المسجونين في التجارب الطبية والعلمية **يُضفي عليهم قيمة**، وليس من العدل استبعادهم منذ البداية، ففي ذلك **تفرقة لا مبرر لها**. ولكن كل ما يحتاجه الأمر مجرد **تدابير خاصة تؤدي إلى حمايتهم** دون اللجوء إلى الحظر العام.

موقف مجمع الفقه الإسلامي 67/5/7

وأجاز **مجمع الفقه الإسلامي** إجراء التجارب على المساجين والمحكوم عليهم بالإعدام، **شريطة توافر الرضا التام الخالي من العيوب** التي من الممكن أن تشوب الإرادة، حيث ورد في قراره رقم **٦٧(٥/٧)** أن: «لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من **موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه** — كالمساجين — أو لأغراض مادية — كالمساكين — ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر».

وقد منع **الدستور المصري** الصادر عام **١٩٧١م** في **المادة ٤٣** إجراء التجارب على المساجين، فنصت على أنه **تحظر إساءة معاملة المسجونين المعتقلين بدنياً ومعنوياً**. فهذا النص — كما يرى فقهاء القانون — **يجرم إجراء التجارب على المساجين**، حيث يعتبر ذلك من باب الإساءة.

رأي المؤلف في هذا التفسير

وفي تقديري أن هذا الأمر **مخالف للواقع تماماً**؛ فالنص يمنع التجارب التي **تتضمن إساءة**، وبإعمال **مفهوم المخالفة** فإن التجارب التي **لا تشتمل على إيذاء أو إساءة للمسجون جائزة ومشروعة** — هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالتجارب التي تُجرَي على المسجونين **بموافقتهم الصريحة ورضاهم المستنير** مع توفير كافة الضمانات لهم **لا تعتبر من قبيل الإساءة**، قياساً على غيرهم من الأحياء. أي أن **جواز إجراء التجارب عليهم هو الأصل** باعتبارهم أشخاصاً عاديين، ويستثنى من ذلك ما إذا **وافق المسجون على ذلك بإرادته الحرة**.

حكم الأسرى

أما بالنسبة **للأسرى** — وهم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بِأَسْرِهم واعتقالهم — **فالأسير لا يمكن الحكم عليه بأنه ذو إرادة حرة**، نظراً للمؤثرات التي تقع عليه، وهي بلا شك مؤثرة على رضاه. والحكم في الأسرى هو **عين الحكم في المساجين**، غاية ما في الأمر أن تصرف الإمام في الأسرى **منوط بما يحقق مصلحة الجماعة**، حيث قرر الفقهاء أن الإمام **مخير في الأسرى بين خمسة أمور**.

١ القتل
٢ المن (العفو)
٣ الفداء
٤ الاسترقاق

٥ عقد الذمة	← ولكنه مُقَيَّدٌ في اختياره هذا بما يحقق مصلحة جماعة المسلمين

ومع تحقيق الإمام لمصلحة الجماعة، إلا أنه **لا يغفل أيضاً مصلحة الأسرى**. وبالتالي **فيجوز إجراء التجارب على الأسرى** شريطة:

١ ألا تكون مضرةً بهم	٢ ولا تؤثر على أجسادهم
٣ مع ضرورة توافر الرضا التام المستنير	٤ وصدوره عن إرادة لا تشوبها شوائب أو يعيبها عيب من عيوب الإرادة

حال رفض الأسير إجراء التجارب عليه **فليس من الجائز شرعاً إجباره** على ذلك؛ لعدم إدراج هذا الأمر ضمن الأمور التي وضع الإسلام فيها الخيار في التعامل مع الأسرى.

ج الرضا في التجارب على الموتى

مبدأ الرضا في التجارب الطبية كما يسري على **الأحياء**، يسري أيضاً على **الأموات**. فينبغي أن يكون الرضا بقبول إجراء التجربة الطبية **صريحاً**، وهذا الرضا يصدر من **الميت قبل وفاته** شريطة توافر الشروط السابقة، أي لا يقع تحت ضغط أو إكراه.

وإذا لم يصدر منه قبل وفاته ما يدل على الرضا، **فيجوز لذوي الشأن** — أي الأقارب — الموافقة على ذلك، شريطة أن تكون هناك **حاجة ماسة لهذه التجربة**. أما إذا وُجِدَتْ طرق أخرى يمكن الاستعاضة بها عن إجراء التجربة على الميت، فالأمر والحالة هذه أنه **لا يجوز إجراء التجربة على الميت**.

موقف المشرع المصري — 1941م

وأجاز **المشرع المصري** استخدام الجثة لأغراض علمية، شريطة **موافقة ذوي الشأن**؛ حيث نصت **المادة ٢٦** من **القانون رقم ١٣٠ الصادر عام ١٩٤١م** على أنه: «يجوز لمفتش الصحة أن يأذن بعدم دفن الجثة بناءً على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها لأغراض علمية، وذلك **بعد موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفى**».

٢ التبصير بطبيعة التجربة ومدى خطورتها

إذا كان الفقهاء وكذلك القانونيون اشترطوا في إجراء التجارب الطبية على البشر ضرورة الحصول على **رضاء الشخص الخاضع للتجربة**، إلا أنهم **لم يكتفوا بمجرد الرضا فقط**؛ بل أوجبوا أن يكون الرضا صادراً عن **إرادة مستنيرة**، بحيث يتم فيها تبصير الشخص الخاضع للتجربة بكل الأمور المحيطة بها.

فيجب أن **يُبَصَّر** بجوانب التجربة الطبية التي يخضع لها؛ لأن الطبيب بالنسبة للمريض — وفي أغلب الأحيان — **عالم يواجه جاهلاً** في العلوم الطبية. ومن هنا يتميز الطبيب بحيازته **لكم هائل من المعلومات الطبية** والإمكانات التي تجعل الشخص الخاضع للتجربة معه في **مركز غير متعادل**.

وإذا كان **إعلام الخاضع للتجربة وتبصيره ضرورياً** لإجراء التجربة، فإن ما أثار الجدل هو **طريقة الإعلام**، لاسيما ما يتعلق بالضمانة التي يحققها الإعلام المباشر للشخص من قبل الطبيب. إلا أن طريقة الإعلام تعتمد في غالب الأحيان على **إطلاع المعالج أو المتطوع** بكل ما يتعلق بالعلاج الذي يجب أن يخضع له، أو بالتجربة التي يُقْدِمُ على التطوع من أجلها. وعادةً ما تبدو مثل هذه المستندات في الواقع كما لو كانت **محررة حماية للطبيب، وتفادياً للمنازعات** التي قد تثور فيما بعد.

المخاطر – المقبولة وغير المقبولة

المنارة 01105405478

وتجدر الإشارة إلى أن أي تجربة **لا تخلو من مخاطر** تحيط بها، إلا أن الفقه القانوني **قسم المخاطر** إلى:

مخاطر مقبولة

يمكن **مع وجودها إجراء التجربة**.

مخاطر غير مقبولة

لا يمكن عقلاً أن تتم التجارب معها.

وبناءً على ذلك اشترطوا في التجربة أن تكون **المخاطر المترتبة عليها مقبولة**؛ واشتراط ذلك إنما كان **لمصلحة الشخص الخاضع للتجربة**، حتى تتوافر **الجدية العلمية** و**الالتزام الأخلاقي** للبحث العلمي قبل الالتزام القانوني.

وإضافة إلى ذلك يشترط وجود **التناسب بين المخاطر المتوقعة** من التجربة، **وبين النتائج** التي من الممكن تحصيلها من وراء إجرائها.

قانون الصحة العامة الفرنسي — **م 20/209**

حيث نصت **المادة ٢/٢٠٩** من قانون الصحة العامة الفرنسي على أنه: «**لا يجوز إجراء التجربة إذا تجاوزت المخاطر المتوقعة** بالنسبة للخاضع للتجربة **حد التناسب مع الفوائد** التي تعود عليه، أو المصلحة من وراء البحث».

الضوابط الأمريكية والأوربية

المنارة 01105405478

وقد نصت **مبادئ القانون الطبي الأمريكي** على الضوابط المتعلقة بإجراء التجارب العلمية والفنية المحضة على الإنسان، ومنها:

١. **الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص الخاضع للتجربة العلمية**

٢. **حماية الحياة الخاصة للأشخاص الخاضعين للتجارب العلمية**

٣ الحرص على حياة وصحة الشخص الخاضع للتجربة العلمية	٤ العمل على تقليل الأخطار والمخاطر المرتبطة بالتجارب العلمية

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 1997م

كما وضعت **الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان** الصادرة في **فرنسا سنة ١٩٩٧م** مجموعة من الشروط في هذا الخصوص، هي:

١ **الرضا المستنير** للشخص الذي سيخضع للتجارب الطبية	٢ ألا تتضمن التجربة أي خطر على حياة وصحة الخاضع لها
٣ لا يجوز إخضاع الأشخاص إلى **تجارب متعددة في نفس الوقت**	٤ لا يجوز مباشرة التجارب الطبية إلا تحت **إشراف** أطباء ذوي كفاءات ومؤهلات علمية عالية يتولون الإشراف على إجراء التجارب العلمية، والتحقق من إجرائها وفقاً للأصول العلمية
٥ ألا توجد بدائل أخرى لتحقيق نفس النتائج المتوقعة من هذه التجربة إلا بإجرائها على الإنسان	٦ لا يجوز مباشرة التجارب الطبية العلمية إلا بعد **الحصول على موافقة الجهة الإدارية** المختصة، وأن تجرى في المراكز التي تتوافر فيها الإمكانات المادية والنفسية اللازمة
٧ التزام الشخص أو الأشخاص القائمين بالتجربة الطبية **بالتأمين من المسؤولية**	

المنارة 01105405478

المطلب الثالث: القيود الخاصة بحماية المجتمع

المنارة 01105405478

١ اتفاق التجارب الطبية مع قواعد النظام العام

ينبغي — حتى توصف التجارب الطبية على البشر بالمشروعية — **ألا تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع**، وهذا الأمر يتطلب أن تكون تلك التجارب **متفقة مع النظام العام**. وبالتالي يجب من حيث المبدأ **تحريم التجارب** التي تؤدي إلى **العبث**، أو تؤدي إلى **نتائج مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية**.

من ذلك: تحريم التجارب بغرض تغيير الجنس

لمخالفة ذلك **لأمر الله تعالى** واعتباره من **فعل الشيطان**، قال تعالى:

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: 119]

كذلك **تحريم التجارب** التي يكون هدفها **تحقيق نتائج علمية ليس لها تأثير من الناحية العملية**.

واتفاق التجربة مع النظام العام يعني **الجواز الشرعي**؛ فالتجارب المحرمة **لا أثر لها**، **ولا يعتد بالموافقة** الصادرة بموجبها.

يقول **ابن القيم**: «... كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، **ولا يسقط الإثم عنه بالإذن**».

٢ الالتزام بالأحكام الشرعية

ينبغي على الطبيب **الالتزام بالأحكام الشرعية المقررة** في هذا الخصوص، ومنها:

تجنب النظر للعورات والاطلاع عليها

المنارة 01105405478

معلوم أن إجراء التجارب يُعدّ من باب **المداواة**، وقد قرر الفقهاء أن **النظر إلى العورات لا يجوز من حيث الأصل**. أما إذا كان النظر **أمراً محتوماً لا بد منه**، فقد أوجب الفقهاء أن يكون النظر إلى **موضع الحاجة فقط**؛ لأن النظر في هذه الحالة من قبيل **الضرورة**، و**الضرورة تقدر بقدرها** كما هو مقرر عند الفقهاء.

يقول **الكاساني**: «الْقَابِلَةَ، وَالطَّبِيبَ يَنْظُرَانِ إلَى الْفَرْجِ، وَيَمَسُّ الطَّبِيبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ **بِغَيْرِ شَهْوَةٍ**».

وقال **الأزهري** في الثمر الداني: «فيجوز للطبيب والجرائحي النظر إلى **موضع العلة** وإن كانت في العورة».

وقال **الشربيني**: «الضرب الخامس: النظر للمداواة، كفصد، وحجامة، وعلاج، ولو في فرج فيجوز **إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط**».

وقال **ابن مفلح**: «وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرِهِ، وَلَمْسِهِ **حَتَّى دَاخِلِ الْفَرْجِ**».

وقد ورد في **السنة** ما يدل على جواز النظر إلى العورة عند الحاجة، وهو ما حدث مع **بني قريظة**، فقد رُوي عن عطية القرظي قال:

«كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ»

ويقول **ابن القيم** رحمه الله: «وَقَدْ كَانَ الْأَسْرَى مِنْ قُرَيْظَةَ يَدَّعُونَ عَدَمَ الْبُلُوغِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ **يَكْشِفُونَ عَنْ مَآزِرِهِمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ** ﷺ فَيَعْلَمُونَ بِذَلِكَ الْبَالِغَ مِنْ غَيْرِهِ».

عدم إفشاء الأسرار الخاصة بالخاضع للتجربة

المنارة 01105405478

أقرّ الإسلام **المحافظة على الأسرار** على سبيل العموم، حيث قال ﷺ فيما رواه أبو سعيد الخدري:

«إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» [صحيح مسلم]

قال **النووي** في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث **تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته** من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه».

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية — وكذلك القوانين الوضعية — **المحافظة على أسرار المرضى**، وهو **التزام أخلاقي** تمليه قواعد الشرف وعادات وأعراف المهنة. ولم يقتصر هذا الالتزام على **العصر الحديث** وفقط؛ بل **عُرِفَ هذا الالتزام في العصور الفرعونية**، وفي **الهند** عُرِفَ في الكتابين القديمين «الرجفية – الأجير فيدا»، وعرفه **الإغريق**، وكان يمثل هذا الالتزام **الضمير المهني للأطباء**. واهتمت **الامبراطورية الرومانية** بموضوع الأسرار الطبية **اهتماماً بالغاً**.

ووفقاً لمضمون هذا الالتزام يجب على الطبيب أو الفريق القائم بالتجربة **المحافظة على أسرار الشخص الخاضع للتجربة**. ولعل هذا الالتزام يستمد أساسه من **العقد** الذي يعد أساساً لمسئولية الطبيب في مواجهة مريضه.

فعلى الطبيب وفقاً لذلك **الحفاظ على كل ما يتعلق بالتجربة** مما يخص الخاضع لها، **وليس للطبيب أو الفريق القائم على التجربة إفشاء** أية أسرار أو معلومات متعلقة بها. وقد ورد في **التراث الطبي الإسلامي** ما يؤكد التزام الطبيب بذلك.

قال **ابن الحاج**: «ينبغي أن يكون — يعني الطبيب — **أميناً على أسرار المريض**، فلا يُطْلِعُ أحداً على ما ذكره المريض؛ إذ إنه **لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك**».

⚠ **الاستثناء – يجوز إفشاء الأسرار للمصلحة العامة**

ومع التزام الطبيب بالمحافظة على عدم إفشاء ما يتعلق بالتجربة، إلا أنه **يجوز له على سبيل الاستثناء إفشاء هذه الأسرار** إذا كان له ما يبرره، كأن يجد هذا الشخص **مصاباً بمرض خطير يؤدي إلى الإضرار بالآخرين**، وذلك تطبيقاً لقاعدة **«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»**.

MNAPA 01105405478

المبحث الرابع: المسؤولية عن إجراء التجارب الطبية

يجمع العلماء من أهل القانون على أن **المسؤولية إما مدنية وإما جنائية**؛ لذا فإن التجارب الطبية من الممكن أن تتحقق فيها المسؤوليتين، وهو ما أتناوله في المطلبين التاليين:

١ **المسؤولية المدنية** عن التجارب الطبية

٢ **المسؤولية الجنائية** عن التجارب الطبية

المطلب الأول: المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

المسؤولية المدنية في عمومها **نظام يهدف إلى جبر الضرر** الذي يحدث للشخص نتيجة فعل ارتكبه شخص آخر، وينحصر هدفها في **إزالة آثار الفعل الضار** عن طريق التعويض **دون التعرض لشخص المتسبب** في إحداث الضرر؛ فهدفها **جبر الضرر وليس عقاب** من ارتكبه.

أنواع المسؤولية المدنية – عقدية أم تقصيرية

المنارة القانونية 01105405478

والمتفق عليه فقهاً وقضاءً أن المسؤولية المدنية **إما عقدية أو تقصيرية**:

المسؤولية العقدية

هي المسؤولية التي **تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام عقدي**، أي أنها تفترض **وجود عقد** يقوم أحد أطرافه بالإخلال بالالتزامات المفروضة عليه.

المسؤولية التقصيرية

فلا تترتب على الإخلال بالتزام عقدي؛ بل مدارها **الإخلال بالتزام قانوني** هو الالتزام **بعدم الإضرار بالغير**.

ويُجْمِعُ شراح القانون المدني على **عدم جواز الجمع** بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؛ بمعنى أنه إذا توافرت في الفعل الواحد شروط كل منهما **فلا يجوز الجمع بين المسؤوليتين**. ولا يجوز له أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ويستحق التعويض، ثم بعد ذلك يتقاضى **تعويضاً آخر** بموجب المسؤولية التقصيرية؛ حيث **لا يجوز استحقاق تعويضين عن ضرر واحد**.

ولكن **لا يوجد مثل هذا الإجماع الفقهي** على جواز أو عدم جواز التمييز بين المسؤوليتين. فيذهب **رأي في الفقه** إلى أنه إذا توافرت شروط كل من المسؤوليتين كان للمضرور أن **يختار أحدهما**، ويرفع المسؤولية استناداً لهما. بينما يذهب **رأي ثانٍ** إلى أنه إذا توافرت شروطهما فللمضرور أو الدائن أن يرجع على أساس دعوى **المسؤولية العقدية وليس التقصيرية**؛ لأن العلاقة الأصلية التي تربط بينه وبين المدين المسؤول هي **علاقة تعاقدية أساسها العقد**.

والمستقرئ للأحكام التي أوردها الفقهاء — سواء فقهاء الشريعة أو فقهاء القانون — يلحظ أن المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية **قد تكون عقدية، وقد تكون تقصيرية**، وهو ما نعرض له تفصيلاً في الفرعين الآتيين:

المسؤولية العقدية **قوامها العقد**؛ حيث إنها تتقرر بناءً على **مخالفة أحد أطراف العقد** للالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد.

والقاعدة العامة في الأعمال الطبية أن المريض **يرتبط مع الطبيب بعقد**، غاية ما في الأمر هي **تحديد الطريقة** التي يظهر بها العقد. وقد يكون هذا العقد **مكتوباً**، إلا أن أغلب تلك العقود تكون **شفوية**، أي تُعقد بطريقة **ضمنية**. لذلك ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن **مجرد فتح الطبيب لعيادته وتعليقه لافتةً** تدل على ذلك، فإنه بذلك يضع نفسه في موضع **الشخص الذي يعرض الإيجاب**، ويُعدّ توجه المريض **قبولاً** يلاقي هذا الإيجاب، وبهذا يتم توافق القبول مع الإيجاب وينعقد العقد صحيحاً فيما بين الطبيب والمريض.

الفرق بين العقود العادية وعقود التجارب

إلا أن الوضع في عمليات **التجارب الطبية يختلف عن ذلك تماماً**؛ فإذا كانت القاعدة العامة في العقود **الاكتفاء بالرضا** لانعقادها، فإن عقود التجارب الطبية **يشترط فيها أن تكون مكتوبة**.

إعلان هلسنكي – المادة 3 — إلزامي

حيث إن ذلك هو ما نصت عليه **المادة رقم ٣** من إعلان «**هلسنكي**»، إذ ورد فيها **ضرورة أن يكون عقد التجربة الطبية مكتوباً**. وهو ما تطلبه **الفقه الفرنسي** الذي يرى أن الكتابة تُعدّ أمراً ضرورياً، وأن وجود **الشهود يمكن أن يكون مفيداً أيضاً**.

قانون الصحة العامة الفرنسي — L 209

وهو ما يتماشى مع ما تبناه **المشرع الفرنسي**، حيث نص في **المادة ٢٠٩ L** من قانون الصحة العامة الفرنسي، على أن: «**يصدر رضاء الشخص الخاضع للتجربة في الشكل المكتوب**».

شروط تحقق المسؤولية العقدية في التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

إذا كانت المسؤولية العقدية هي **الأصل في المسؤولية المدنية**، فإنه يشترط لتحققها في التجارب الطبية توافر **الشرطين** الآتيين:

1 وجود عقد بين الطبيب والمريض الخاضع للتجربة

من الشروط البديهية لوجود المسؤولية العقدية في مسألة التجارب الطبية **وجود عقد** بين الطبيب القائم بالتجربة والشخص الخاضع لها. وتجدر الإشارة إلى أن العقد المبرم بينهما في المقام الأول هو **عقد رضائي**، أي يكفي لانعقاده **توافر الرضا**. وهذا الرضا **لا يقلل منه** أن يشترط القانون **شكلاً معيناً لإثبات العقد**؛ حيث يجب التمييز بين **وجود العقد وطريقة إثباته**؛ وبالتالي يظل العقد **رضائياً** حتى ولو اشترط القانون شروطاً شكلية لإثباته.

٢ استيفاء العقد للأركان والشروط

يجب أن يكون العقد **مستوفياً للأركان والشروط** حتى يكون **محققاً للأثر** الذي يترتب عليه. وإذا **تخلف أحد هذه الأركان** فإن العقد يكون **باطلاً**، وتتحول المسؤولية من **عقدية إلى تقصيرية**.

نتيجة مهمة – ما يخرج عن إطار العقد

وبناءً على ذلك فـ**كل عمل يخرج عن إطار العقد** أو إطار الأعمال التي تم الاتفاق عليها تكون مسؤولية المجرِّب عنها **مسؤولية تقصيرية**، حتى ولو كان لهذه الأعمال الجديدة **علاقة أو اتصال** بينها وبين الأعمال الأولى التي تم الاتفاق عليها.

ويمثل لذلك **باستعمال الطبيب المجرب النطف الفائضة** عن عملية التلقيح الصناعي، أو **العلاج الطبي في أغراض علمية** مثل: **الأبحاث الخاصة بالاستنساخ البشري** دون علم أو موافقة صاحب النطف.

الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية عن التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

تعريف المسؤولية التقصيرية

تُعرَّف المسؤولية التقصيرية في نطاق الأعمال الطبية بأنها: **الجزاء المترتب على عمل الطبيب** نتيجة **إخلاله بالتزام قانوني**، وهو التزام يفرض عليه **عدم الإضرار بالآخرين**، ويُعبَّر عنه بـ**الخطأ غير المشروع**.

ومعياره: **انحراف الطبيب في سلوكه وتصرفاته** عن جانب الحيطة والحذر والتبصر، وعن **بذل العناية اللازمة** للمريض.

القاعدة العامة في مسؤولية الطبيب كما أقرتها **محكمة النقض المصرية**: أن الطبيب **مسؤول عن تعويض الضرر** المترتب على خطئه في المعالجة، ومسؤوليته هذه **تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية**، فقاضي الموضوع **يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى** من غير رقابة عليه.

الأطباء من حيث تحملهم للضمان – خمسة أقسام

المنارة القانونية 01105405478

١ طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبُّهُ تَلَفُ الْعُضْوِ أَوِ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، **فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا**.

٢ مُطَبِّبٌ جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِبُّهُ، فَتَلِفَ بِهِ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طِبِّهِ لَمْ يَضْمَنْ.

٣ طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَذِنَ لَهُ وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَتْ يَدُهُ، فَأَتْلَفَهُ، مِثْلَ أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الْخَاتِنِ إِلَى الْكَمَرَةِ، وَتَعَدَّتْ إِلَى عُضْوٍ صَحِيحٍ، فَهَذَا يَضْمَنُ.

٤ الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ، اجْتَهَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضِ دَوَاءً فَأَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ، فَقَتَلَهُ، فَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

٥ طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَقَطَعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَتَلِفَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ.

ويجمع **الفقه الشرعي والقانوني** على أن المسؤولية التقصيرية لها **ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية.**

الركن الأول: الخطأ الطبي في عمليات التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

يُعدّ الخطأ **أول أركان المسؤولية التقصيرية** في عمليات التجارب الطبية إن لم يكن **أهمها على الإطلاق**، وهذا الخطأ **يندرج تحت المفهوم العام للخطأ الطبي.**

تعريف الخطأ الطبي – أولاً

الخطأ الطبي هو **تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ** وُجِدَ في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

تعريف الخطأ الطبي – ثانياً

وعُرِّف أيضاً بأنه: **إخلال الطبيب بواجبه** — سواء القانوني أو العقدي — حيث يُرتِّب كل خطأ طبي مسؤولية الطبيب، كما في حالة الخطأ عند **عدم اتخاذ جانب الحذر والحيطة اللازمة.**

وينتج الخطأ الطبي عند **إخلال الطبيب بالالتزامات الخاصة** التي تفرضها عليه أصول مهنته، وليس عن إخلاله بالالتزامات التي يفرضها **الواجب القانوني العام** الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير. وبالتالي فإن قياس مسلك الطبيب عند تحديد الخطأ **يُقاس بمسلك الطبيب المعتاد** الذي يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

تعريف الخطأ الطبي في مجال التجارب

ويمكن تعريف الخطأ الطبي في مجال التجارب الطبية بأنه: **كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية** التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها **نظرياً وعلمياً وقت تنفيذ التجربة**، أو **إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة** التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله أضراراً جسيمة، وكان بإمكانه تفاديها.

عنصرا الخطأ التقصيري في التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

وهذا الخطأ **لا يوصف بأنه تقصيري** إلا إذا توافر فيه **عنصران:**

١ العنصر الأول – التعدي

حيث يُعتبر الطبيب **متعدياً وفقاً لمعيارين: معيار شخصي** يُبنى على أساس حرص الطبيب وفطنته ومدى صلاحيته للقيام بالتجربة الطبية، **ومعيار موضوعي** يُنظرُ فيه إلى الانحراف الذي صدر من الطبيب دون ما نظر إلى الأمور الشخصية الخاصة بالطبيب القائم بالتجربة. ويُستثنى من ذلك **الحالات التي تتطلب فيها قواعد المهنة من الطبيب التدخل السريع** دون حاجة إلى إذن أو موافقة، كما في حالات **الحوادث التي لا تحتمل التأخير**.

٢ العنصر الثاني – العنصر المعنوي

ويعني في مجال التجارب الطبية: **إدراك الطبيب لما وقع منه**؛ إذ **لا يكفي الانحراف عن السلوك**؛ بل يجب **إدراكه له، وعِلْمِهِ بأن فعله يشكل جريمة** أو فعل لا تجيزه قواعد المهنة.

والخطأ في مجال التجارب الطبية هو في المقام الأول **خطأ مهني بالدرجة الأولى**؛ لأنه يتعلق بمهنة الطب.

صور الخطأ في مجال التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

ويمكن القول: إن الخطأ في مجال التجارب الطبية **يكتنفه شيء من الغموض**، نظراً لتعدد الصور التي يمكن أن يتوافر بها، ومن صوره:

١ خطأ الطبيب في **إجراء فحوصات ما قبل التجربة**، مما أدى إلى خطأ في إجرائها.

٢ خطأ الطبيب في **عدم مسايرة التطورات العلمية** في المجال الذي يجري فيه التجربة؛ إذ يقع على عاتقه الالتزام باتباع الأصول العلمية والمستجدات المهنية في المجال الذي ينوي إجراء التجربة فيه. وبالتالي يسأل الطبيب عن الخطأ في إجراء التجربة إذا كانت القواعد التي استخدمها قواعد قديمة؛ لأن من الواجبات الأساسية للطبيب أن يستخدم وسائل علمية حديثة حتى يكون ما عنده من العلم مسايراً للعلوم الحديثة وقت إجراء التجربة.

٣ **عدم كفاءة الطبيب** للقيام بالتجربة، وذلك يقتضي توافر الخبرة التي تؤهله لأداء مثل هذه التجربة. إذ الأصل أن يكون الطبيب القائم بالتجربة مؤهلاً تأهيلاً كافياً. فشهادة الطب **لا تكفي** لجعل الطبيب أهلاً للقيام بالتجربة؛ لأنها تتطلب دقةً وعناية خاصة. لذا فإن **الممارس العام لا يجوز له إجراء تجربة طبية** على جسم إنسان حتى ولو كان الهدف منها العلاج.

٤ **تقصير الطبيب في بذل العناية المطلوبة**، لاسيما إذا كانت التجربة من قبيل التجارب العلاجية؛ حيث يلتزم الطبيب بفحص المريض فحصاً دقيقاً دون تسرع أو إهمال، وهذا يفرض عليه أن يقدم للمريض كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق استفادة المريض من التجربة. ويقع عليه أيضاً التزام بأن **يسمع شكوى المريض**، وأن يحصل منه على كافة المعلومات المتعلقة بالمرض — سواءً منه شخصياً أو من أهله.

اعتبر الفقهاء — على اختلاف مذاهبهم — الخطأ في التجربة **سبباً من أسباب وجوب الضمان** على الطبيب؛ إلا أن الخلاف وقع بينهم في **المعايير** التي يتم على أساسها نسبة الخطأ للطبيب، أو المعيار الذي يمكن بناءً عليه وصف فعل الطبيب بأنه خطأ يستوجب الضمان:

موقف الحنفية

عند **الحنفية: لا يضمن الطبيب** الفعل الذي وقع منه إلا في **حالتين: الأولى:** حالة كون الطبيب **غير حاذق** — أي غير متقن لمهنة الطب، أو على أقل تقدير ليس بارعاً في الفرع الطبي الذي تُؤدَّى فيه التجربة — كأن تكون التجربة مثلاً في مجال **أمراض القلب** واختصاص الطبيب هو مجال **أمراض العظام** أو **أمراض الجهاز الهضمي**؛ أي ليس بين التخصصين ارتباط. ومَرَدُّ ذلك أن التجربة غالباً ما تتسم بالدقة، وبالتالي يتوجب أن يكون الطبيب **له اختصاص أصيل فيه** حتى لا يؤدي إلى إهلاك النفوس. **الثانية:** أن يكون الفعل الذي وقع فيه الطبيب — والذي كان سبباً مباشراً — **غير معتاد**؛ بمعنى لا يُفعل مثله في هذا الظرف.

موقف المالكية

أما **المالكية** فقد **فرقوا بين عدم المعرفة وبين الخطأ**: فإذا أعطى الطبيب المريض دواءً فمات بعدما شربه، أو قطع منه شيئاً فمات من القطع، **فلا ضمان عليه** ما لم يثبت وقوع الخطأ. أما إذا **أخطأ الطبيب** بأن أعطاه دواءً لا يصلح لمرضه فمات، أو **تجاوز في العلاج** فقطع ما لا ينبغي أن يقطع، فإن كان **حاذقاً ولم يتعمد، فالضمان على العاقلة**، وإن كان **غير حاذق فعليه العقوبة**.

موقف الشافعية والحنابلة

والمعيار عند الشافعية أن يؤدي الطبيب **عمله بدقة**، وهو كذلك ما ذهب إليه **الحنابلة**.

يقول **الشافعي** في الأم: «وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَ غُلَامَهُ أَوْ يُبَيْطِرَ دَابَّتَهُ فَتَلِفُوا مِنْ فِعْلِهِ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مِمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتِلْكَ الصَّنَاعَةِ، **فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ**، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ، وَكَانَ عَالِمًا بِهِ **فَهُوَ ضَامِنٌ**».

⚠ حالات ضمان الطبيب القائم بالتجربة

وبناءً على ذلك فالطبيب القائم بالتجربة **يكون ضامناً في الأحوال الآتية:**

١ إذا كان **غير ماهرٍ** في المجال الذي يُجري فيه التجربة.

٢ إذا **لم يتبع الأصول المهنية والقواعد** التي يتوجب مراعاتها عند القيام بمثل هذه التجارب.

٣ إذا **اتبع قواعد عادية** في إجراء التجربة في الوقت الذي توجد فيه **قواعد جديدة** أفرزها التطور العلمي الحديث.

كيفية إثبات الخطأ في التجارب الطبية

القاعدة العامة أن **عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي**، وهو ما أقرَّهُ النبي ﷺ بقوله:

«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» [صحيح البخاري]

وفي مجال التجارب الطبية: فإن الخطأ الذي يقع من الطبيب القائم بالتجربة **يقع عبء إثباته على المريض**؛ فيقع عليه عبء إثبات **أن الطبيب أخطأ خطأً مهنياً** عند قيامه بالتجربة، وأنه **لم يراع الأصول المهنية**، ولم يقم باتباع **المستجدات في المجال الطبي** فيما يتعلق بموضوع التجربة، أو أنه **قصَّر في اتخاذ إجراءات السلامة والأمان** التي كان يتوجب عليه اتباعها. وهذا كله أمور **إيجابية** يمكن للمريض إثباتها.

الإشكالات التي تقف عائقاً أمام الإثبات

المنارة القانونية 01105405478

ومع أن عبء إثبات الخطأ في مجال التجربة يقع على عاتق المريض، إلا أن هناك **العديد من الإشكالات** التي تقف عائقاً أمام الإثبات، ومنها:

١. الحالة التي يُكلَّف فيها المريض بإثبات **واقعة سلبية**، وذلك كما إذا طُولب المريض بإثبات **انحراف الطبيب عن اتباع الأصول المستقرة** في الفن الطبي.

٢. صعوبة إثبات عدم قيام الطبيب **ببذل العناية** باعتباره **واقعة سلبية لا يمكن إنكارها**. وهنا يلجأ **القاضي إلى الخبرة** لاستظهار الحقيقة — كما هو الحال في كل واقعة سلبية — يمكن توصل المريض إلى ذلك من خلال إثبات أنه **غير مباشر لها**، أي من خلال إثبات **واقعة إيجابية عكسية**. ويكتفي القضاء هنا **بالأدلة المقدمة من المريض** على حصول الطبيب على موافقته من العمل الطبي.

الركن الثاني: الضرر في التجارب الطبية

المنارة القانونية 01105405478

الضرر في اللغة

الضرر في اللغة **ضد النفع**، والضرُّ المصدر، والضَّرُّ: الاسم. وقيل: هما لغتان، فإذا جمعت بين الضر والنفع **فتحت الضاد**، وإذا أفردت الضر **ضممت الضاد** إذا لم تجعله مصدراً، كقولك: **ضررت ضرًّا**.

الضرر على سبيل العموم

والضرر على سبيل العموم هو **ما يستوجب التعويض**، أو هو **مساس بحق من حقوق الإنسان** أو **مصلحة مشروعة له**، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة **بسلامة جسده وحقه في الحياة**، أو في **ماله** أو **عاطفته** أو **شرفه** أو غير ذلك.

وقيل: الضرر هو **الأذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه**.

الضرر الطبي الناشئ عن التجربة

ويُعتبر الضرر **أحد الأركان الرئيسة** للمسؤولية التقصيرية في التجارب الطبية. ويمكن تعريف **الضرر الطبي** الناشئ عن التجربة الطبية بأنه: **أذى ألحقه الطبيب القائم بالتجربة بالمريض محل التجربة** أدى إلى **أضرار مادية أو معنوية**.

وبناءً على ذلك فوجود الضرر **شرط في تحقق المسؤولية التقصيرية**، يستوي في ذلك أن يكون الضرر **مادياً أو معنوياً**.

صور الضرر في مجال التجارب الطبية

١ الضرر المادي في مجال التجربة الطبية

يتمثل الضرر المادي في **الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية**. فالأذى الذي يلحق بالشخص من جراء التجربة الطبية قد يؤدي إلى:

١ **عدم قدرته على الكسب.**

٢ أو **يُكبِّده نفقات علاج عالية** تفوق قدراته، مما يُعدّ ضرراً مادياً كبيراً.

٣ ويشمل هذا الضرر ما لَحِقَ المريض من خسارة، كـ**مصاريف العلاج والأدوية والإقامة** في المستشفى، ونفقات إصلاح الخطأ.

٤ ويدخل في الضرر المادي كذلك **الأضرار الجسدية**، وهي التي تصيب الإنسان في جسمه نتيجة الاعتداء عليه من الغير.

والضرر المادي في المجال الطبي يراد به **الخسارة التي تصيب الذمة المالية للمضرور**. والأضرار الجسدية سواء اقتصرت على مجرد **المساس بحق الإنسان في سلامة جسمه** أو حياته، أو تعدت ذلك وترتبت عليها **أضرار أخرى**.

٢ الضرر المعنوي في التجارب الطبية

تعريف الضرر المعنوي

هو ما يصيب الشخص **خارج نطاق المال**، أي يصيبه في **كرامته أو شعوره**.

والضرر المعنوي في التجارب الطبية يتمثل في **عدة صور**، منها:

١ الخطأ في التجربة الذي يترتب عليه **إصابة الشخص محل التجربة بعجزٍ دائم**.

٢ أو **تعطيل منفعة عضو** من أعضاء الجسد، بحيث تتولد لدى الإنسان **مشاعر الأسى والحزن**.

٣ أو **إصابة المريض محل التجربة بتشوهات** من غير الممكن علاجها، مما يُشعِرُه بأنه **إنسان غير سوي داخل المجتمع**.

وإذا كان الأصل أن الضرر في التجارب الطبية **ينبغي أن يلحق الشخص محل التجربة مباشرةً**، فإن التساؤل الذي يثور: **هل يجوز لغيره** — كالورثة مثلاً — **المطالبة بالتعويض؟** الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التفريق بين **حالتين**:

1 الحالة الأولى – موت الشخص الخاضع للتجربة

إذا قام الطبيب بإجراء التجربة، وترتب على ذلك **موت الشخص محل التجربة**، فالأمر والحالة هذه أنه **يجوز للورثة المطالبة بالتعويض** بناءً على قواعد **المسؤولية العقدية**. ولعل إخضاع هذه الحالة لقواعد **المسؤولية العقدية** يرجع إلى أن الخطأ الذي وقع من الطبيب هنا يستند إلى **تقصيره في التزامه** الذي أوجبه العقد، والذي تم إبرامه بين الطبيب ومورِّثهم.

2 الحالة الثانية – مطالبة غير الورثة بالتعويض

يجوز لغير الورثة المطالبة بالتعويض في حالة وفاة الشخص الخاضع للتجربة، كأن يكون الميت هو **الذي يعولهم ويتكفل بهم**، ولا عائل لهم سواه. فيحق لهؤلاء **الرجوع شخصياً على الطبيب** الذي قام بالتجربة؛ لأنه **أخَلَّ بالتزامه العقدي** إذا كان هذا التقصير هو الذي أدى إلى وفاة الشخص محل التجربة، مما ألحق بهم **أضراراً مادية** — فقد تتمثل في فقد من يعولهم — و**أضراراً معنوية** تتمثل في **الحزن والأسى على فقد عزيز**، وفقاً لأحكام **المسؤولية التقصيرية**؛ لأن من قام برفع الدعوى يُعتبر **من الغير بالنسبة للعقد** الذي أبرمه الخاضع للتجربة مع الطبيب المجرِّب.

الركن الثالث: علاقة السببية

المنارة القانونية 01105405478

علاقة السببية هي **الركن الثالث**، ويعني **ضرورة أن يكون بين الخطأ** الذي وقع من الطبيب المجرِّب **والضرر** الذي أصاب الشخص محل التجربة **علاقة سببية**، أي أن **الخطأ هو السبب في حدوث الضرر** الذي لحق الشخص محل التجربة.

والأصل أن **تحديد رابطة السببية** في المجال الطبي من الأمور **العسيرة نوعاً ما** بسبب **تعقد الجسم الإنساني وتغير حالاته**؛ فقد ترجع أسباب الضرر إلى **عوامل خفية** مردها **طبيعة تركيب جسم الخاضع للتجربة واستعداده**، مما يصعب معه تبينها.

إلا أن هذا **لا يعني عدم البحث** في مسؤولية الطبيب المجرِّب وخطئه. لذلك **يقع على عاتق الطبيب المجرِّب التزاماً بالتأكد من حالة المريض واستعداده** وما لديه من **حساسية خاصة** قبل التدخل.

ما يُعفي الطبيب المجرِّب من المسؤولية

ولا يُعفي الطبيب المجرِّب من المسؤولية **إلا إذا أثبت أن نتائج تدخله تُعدّ غير متوقعة وضعيفة الاحتمال** طبقاً للمجرى العادي للأمور.

قرينة السببية – لمصلحة المضرور

وإذا أثبت المضرور **الخطأ والضرر**، وكان من شأن ذلك الخطأ أن **يحدث عادةً مثل هذا الضرر**، فإن **القرينة على توافر علاقة السببية** بينهما **تقوم لصالح المضرور**. وللمسؤول **نفي هذه القرينة** بإثبات أن الضرر قد نشأ عن **سبب أجنبي لا يد له فيه**، وهو:

١ القوة القاهرة.

٢ الحادث المفاجئ.

٣ خطأ المضرور.

٤ خطأ الغير.

أما إذا صدر **خطأ من المريض**، وكان لهذا الخطأ أثره في إحداث الضرر، فإن **مسؤولية الطبيب المجرِّب تنتفي** ولا يمكن مساءلته. ومن تلك الحالات:

١ انتحار المريض.

٢ أو **تناوله لأشياء حرمها الطبيب صراحة**، لما لها من تأثير ضار على المريض خلال فترة إجراء التجربة؛ إذ الضرر هنا يكون مرده **خطأ المريض** وليس الطبيب.

ويمثل لها أيضاً **بكذب المريض على الطبيب** بإعطائه معلومات خاطئة لها تأثيرها على نجاح التجربة، **كتعاطيه أدوية معينة لم يصرح بها للطبيب**، وكذلك بالنسبة للأضرار التي **لا يمكن للطبيب توقعها**.

تدريبات على الوحدة الأولى

المنارة القانونية 01105405478

١ تناول **تعريف التجارب الطبية** موضحاً أهميتها.

٢ قسّم العلماء التجارب الطبية إلى نوعين، اذكرهما، مبيناً **خصائص كل منها**.

٣ من الضوابط التي وضعها المجيزون لإجراء التجارب الطبية **ألا يكون فيها خطر**، اشرح ذلك.

٤ بيّن **حكم إجراء التجارب الطبية على الأجنة**.

٥ صارت التجارب الطبية في الواقع المعاصر **ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها**، اشرح ذلك.

٦ بيّن **صور الضرر** في مجال التجارب الطبية.

تأجير الأرحام وإشكالية ثبوت النسب

١ التعريف بتأجير الأرحام
٢ الحكم الشرعي لتأجير الأرحام
٣ نسب طفل تأجير الأرحام
٤ الدوافع الطبية والاجتماعية للجوء إليه

تمهيد: الوقائع التاريخية والتطورات المعاصرة

المنارة القانونية 01105405478

قبل البدء في تكييف القضية وبحث أحكامها، دعونا نطّلع أولاً على بعض **الوقائع التاريخية والتطورات** التي تُجلي صورة المسألة وتوضح أبعادها لفهمها بشكل أعمق.

إن **الثورات العلمية المعاصرة** قد أفرزت **اكتشافات مذهلة**، توزعت بين تحقيق الرفاهية وعلاج معضلات أزلية كالعقم وعدم القدرة على الإنجاب.

وقد بيّن الإسلام أن **الولد منحة من الله**، قال تعالى:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50]

لكن الإسلام **لم يقف عاجزاً أمام المرض**، بل حث على **التداوي منه**؛ قال النبي محمد ﷺ:

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ» [صحيح ابن حبان]

ومع تقدم الطب — بعد أن كانت الوسائل بدائية لقصور الإمكانات — ظهر **التلقيح الاصطناعي بنوعيه: الداخلي** للحالات السهلة، **والخارجي** للحالات الصعبة بعد فشل الداخلي.

صور التلقيح الخارجي – بين الزوجين وطرف ثالث

وهذا التلقيح الخارجي قد **يقتصر على الزوجين**، وقد يمتد **لطرف ثالث أجنبي** كما في «**تأجير الأرحام**»؛ كأن تُؤجِّر امرأة (غريبة أو قريبة أو زوجة ثانية) **رحمها لنطفة الزوج وبويضة الزوجة**، أو **تمنح بويضتها** لتُلقَّح بماء الزوج وتُنقل لرحم الزوجة عند عجز مبيضها.

وهذه المسألة **وافدة من الغرب**، وأحدثت **انقساماً بين علماء المسلمين** بين **مانع ومجيز** استناداً لأدلتهم وظروف الواقع، مما دفع إلى جمعها وبحثها عبر تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

أول طفلة أنبوب – بريطانيا (10 نوفمبر 1977م)

وقد تفجرت هذه النوازل عالمياً بولادة **أول طفلة أنبوب في بريطانيا** بتاريخ **10 نوفمبر 1977م** على يد الطبيبين «**ستيتو وإدوارد**»، ونالت **اهتماماً إعلامياً واسعاً**، وفتحت قضايا **بنوك المني**، و**تجميد الأجنة**، و**زراعة الخصية والرحم والمبيض**، و**مواليد الكتالوج**، و**حمل الزوجة بعد وفاة زوجها**.

قضية ماري وايتهد – نيوجيرسي الأمريكية

ثم شاعت القضية بعد امتناع **الأم المستعارة «ماري وايتهد»** عن تسليم الطفلة للمتعاقدين «**وليام وإليزابيث شيرن**»؛ فقضت **محكمة الأسرة في نيوجيرسي** بحق «وايتهد» في **استعادة الوصاية المؤقتة** على الطفلة ابنة الخمسة أشهر، مع زيارة الأب مرتين أسبوعياً ورضاه بالحكم. وقد أقرت المحكمة بصحة العقد لدى مكتب المحامي «**نويل كوين**» الذي كشف عن امتناع أربع أمهات قبلها، وولادة **65 طفلاً بالعقود نفسها** وتوافر **12 مركزاً** بأمريكا.

قضية مصر – الزوجان السكندريان (يسري وسماح)

وفي مصر، بدأت جذور المسألة بـ**زوجين سكندريين** («**يسري**» و«**سماح**») فقدا الجنين والرحم جراء **نزيف في الشهر التاسع**، فأفتاهما الدكتور **عبد المعطي بيومي** — عميد أصول الدين — **بجواز استئجار رحم** لتلبية حاجة الإنسان.

تطورات القضية المصرية – بين الإفتاء والمجمع

وشجعهما طبيب النساء والتوليد **إسماعيل برادة** موضحاً سابقتها في أمريكا **بتكلفة تفوق 25 ألف جنيه** عدا أجر البديلة، فتعاقدا رسمياً عند محامٍ مع قريبة الزوجة المطلقة «**نجلاء**» لمساعدتهما كأم بديلة **لسبق إنجابها**. لكن الزوجين توجها لشيخ الأزهر الدكتور **محمد سيد طنطاوي** للاستيثاق، فأحال الأمر لـ**مجمع البحوث الإسلامية** الذي أفتى **بالتحريم** استناداً لرأي وزير الصحة الأسبق الدكتور **إبراهيم بدران** بشأن **تأثير بيئة الرحم في تشوه الأجنة** و**تنازع الأمهات**، فظل الخلاف مستمراً.

الموقف الدولي والمجامع الفقهية

ورغم **إباحة الاستئجار بالغرب** وتوثيقه تعاقدياً، ظلت **نزاعاته معقدة** بساحات المحاكم، وقابلته **المجامع الفقهية الإسلامية** بقرارات **تحريم قاطعة** لمنافاته الفطرة ومصادمة الشريعة، اعتماداً على الأدلة والمنظمات الطبية.

المبحث الأول: التعريف بتأجير الأرحام

المنارة القانونية 01105405478

تعريف الإجارة

الإجارة في اللغة

الإجارة في اللغة: **اسم للأجرة**، وهي **كراء الأجير**. وقد **أجره** إذا أعطاه أجرته، و**آجره الله** أجرًا من باب قتل، ومن باب ضرب لُغَةُ بني كعب، و**آجره بالمد** إذا أثابه. و**آجرت الدار** قال **الزمخشري**:

«وأجرت الدار على **أفعلت** فأنا **مؤجر**، ولا يقال: **مؤاجر**، فهو خطأ. ويقال: **أجرته مؤاجرة** مثل **عاملته معاملة وعاقدته معاقدة**؛ ولأن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة إنما يتعدى لمفعول واحد، ومؤاجرة الأجير من ذلك. فأجرت الدار والعبد من **أفعل** لا من **فاعل**. ومنهم من يقول: **آجرت الدار** على فاعل فيقول: أجرته مؤاجرة».

وتستعمل الإجارة في اللغة ويراد بها **الأجرة على العمل**، كما تستعمل في **العقد الذي يَرِدُ على المنافع بعوض**.

يقول **القرافي**: «إنه قد غلب على وضع **الفعالة بالكسر** للصنائع، نحو **الصناعة والخياطة**، **والفعالة بالفتح** لأخلاق النفوس الجليلة نحو **السماحة والشجاعة**، **وبالضم** للمحتقرات كـ**الكناسة والنخالة**».

كما تطلق ويراد بها **العوض**، ومنه قوله تعالى:

﴿لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 77]

ويطلق **الأجر** أيضًا بمعنى **الجبر**، قال **ابن فارس**: «الهمزة والجيم والراء **أصلان** يمكن الجمع بينهما بالمعنى: فالأول **الكراء على العمل**، والثاني **جبر العظم الكسير**. فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت اليد. فهذان الأصلان والمعنى الجامع بينهما أن **أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله** فيما لحقه من كد فيما عمله».

والإيجار مصدر **آجره يؤاجره مؤاجرة وإيجارًا**، أي **اكتراه منه**، وأصله من **أجر الشيء** أي **أكراه**، **وأجر فلانًا على كذا**: أي أعطاه أجرًا، والمضارع منه **يأجر**، ومنه قوله تعالى:

﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 27]

أي **تكون أجيرًا لي**. يقال: **آجر الله عبده** أي **أثابه**، **واستأجره** أي **اتخذه أجيرًا**، **والتأجر** أي **طلب الثواب** بصدقة ونحوها.

يقول **الرافعي**: «الإجارة وإن اشتهرت في العقد فهي في اللغة **اسم للأجرة**، وهي **كراء الأجير**».

اختلف الفقهاء في تعريف الإجارة، وجاءت تعاريفهم على النحو التالي:

١ **الحنفية**: عقد على **المنافع بعوض هو مال**، وقيل: هي **بيع منفعة معلومة بأجر معلوم**.

٢ **المالكية**: هي **تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض**.

٣ **الشافعية:** هي عقد على **منفعة مقصودة معلومة** قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وقيل: هي **تمليك منفعة بعوض بشروط**.

٤ **الحنابلة:** الإجارة عقد على **منفعة مباحة معلومة** تؤخذ شيئًا فشيئًا.

٢ تعريف الرحم في الإسلام

اهتم الإسلام **برحم المرأة اهتمامًا بالغًا**، فوضع له من الأحكام ما يؤدي في النهاية إلى **تقديسه وعدم امتهانه**؛ بعد أن كان الرحم **ممتهنًا في الجاهلية** لا قيمة له ولا حرمة. فالثابت أن **الأنكحة في الجاهلية كانت متعددة ومتنوعة**، فمنها ما يسمى **بنكاح الرهط، ونكاح الاستبضاع**، وغيرهما — وكلها أنكحة تجعل **رحم المرأة سلعة مباحة أمام الرجال**.

★ لماذا هذه الأهمية البالغة للرحم؟

وهذه الأهمية البالغة للرحم إنما تقررت لأنه يُعدّ **عضوًا أساسيًا وهامًا**، ففيه **ينبت الإنسان** وتمر به **أطوار التخليق المختلفة** وهو بداخله. فهو يُعتبر **منبتًا للبذرة الإنسانية** التي تتغذى بدم الرحم، ويعمل الرحم على **صيانتها من الأخطار** إلى أن يحين الموعد المقدر لخروجها. كما أن هذا العضو **له من اسمه نصيب**؛ حيث إنه **يرحم الجنين بالمحافظة عليه**، ويقوم كذلك بتوفير **الظروف الملائمة له**، فهو **قرار مكين ومسكن قوي راسخ متين**.

الرحم في اللغة

هو **موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن**.

الرحم في الاصطلاح

هو عبارة عن **حويصلة صغيرة الحجم** في أسفل التجويف البطني للمرأة، **يتسع ويكبر تبعًا لنمو الجنين** بداخله إلى أن يصل إلى قمة تمدده في نهاية فترة الحمل، ثم **يعود إلى حالته الأولى تدريجيًا** بعد خروج الجنين طفلًا.

الرحم في القرآن الكريم – معنيان

المنارة القانونية 01105405478

١ المعنى الأول – العضو التناسلي للمرأة

وهو **المهد والفراش، والمحضن للنطفة الإنسانية**؛ يحيطها ويغذيها ويرعاها حتى تبلغ **أوج نموها وكماله**، فيخرجها الله **بشرًا سويًا**.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 6]

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8]

﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ [الحج: 5]

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228]

2 المعنى الثاني – صلة القرب

وهو صلة القرب الناتجة عن الرحم وما يحمله، وهو الصلات الناتجة عن التزاوج؛ فالآباء والأبناء والأخوال والأعمام ومجموعة الأقارب وإن بَعُدوا يُطلق عليهم لفظ الرحم.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]

الرحم في السنة النبوية

المنارة القانونية 01105405478

قال النبي ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ» [سنن الترمذي]

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ» [صحيح البخاري]

الرحم تشريحيًا – التركيب والوظائف

المنارة القانونية 01105405478

ومما سبق يتبين أن الله عز وجل شَرَّفَ الرحم عن غيره من سائر أعضاء الجسم؛ وذلك لأن الرحم هو منبت البذرة الإنسانية، فيها تنمو وتترعرع، يغذيها بدمه ويحفظها من كل سوء، حتى إذا آن موعد خروجها إلى الدنيا انقبض الرحم انقباضات متتالية حتى يخرجها إلى الدنيا سليمةً دون أن يمسها بأذى.

وصف الرحم تشريحيًا

والرحم **موضوع في وسط حوض المرأة**، ويكون **محميًا ومصونًا من كل أذى**، وهو **عضو عضلي أجوف ذو جدار ثخين ومتين**، وهو **كمثري الشكل**، ويبلغ طوله **ثلاث بوصات** وعرضه **بوصتين**، وسمكه **بوصة واحدة** في الأنثى البالغة. أما حجم تجويف الرحم في الأنثى البالغة فلا يزيد عن **مليلترين**، وفي نهاية الحمل فإن حجم الرحم **يتسع لسبعة آلاف مليلتر** — أي أن حجمه **يتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة**. ووزن الرحم في غير أوقات الحمل لا يزيد عن **خمسين جرامًا**، فإذا كان في نهاية الحمل فإن وزنه يبلغ **ألف جرام أو يزيد**، أما محتوياته فتزن **خمسة آلاف جرام** — أي أن وزنه بمحتوياته **يزيد أكثر من مائة مرة**.

ويتكون الرحم من **جسم وعنق**، وكلاهما مكوَّن من **ثلاث طبقات**:

١ **طبقة البريتون:** تغطي جسم الرحم، وشيئًا من عنقه من الخلف.

٢ **الطبقة العضلية:** عضلات سميكة غير إرادية، وتشتمل على ثلاث طبقات من الألياف: **السطحية** (طولية)، و**المتوسطة** (مختلفة الاتجاهات)، و**الداخلية** (دائرية ترتكز حول عنق الرحم).

٣ **الطبقة المخاطية:** الغشاء المبطن للرحم — وهو **الغراس الوثير للنطفة الأمشاج** التي تتعلق به وعن طريقه تتغذى وتنمو.

توجد للرحم **قناتان على كل جانب واحدة**، وتنتهي القناة بـ**انتفاخ يُعرف باسم البوق** الذي يحيط بالمبيض بمجموعة من **الأهداب**. فإذا أفرز المبيض البويضة تلقفتها **أهداب البوق** وحملتها **حملًا رفيقًا** حتى تصل إلى **الثلث الأخير منه**.

لحظة التلقيح – النطفة الأمشاج

فإذا ما نجح **حيوان منوي** في تلقيح البويضة أصبحت البويضة الملقحة «**النطفة الأمشاج**» — أي **المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة** — عندئذ تبدأ هذه البويضة المخصبة في **الانقسام** حتى تصل إلى الرحم في **ستة أيام**. وهناك **يستقبل الرحم البويضة الملقحة**؛ إذ مهد لها **الفرش والبطائن**، وتنغرز فيه وتتعلق بجداره، وتُحاط **بالدم الغليظ** من كل جهة — فهي **علقة عالقة بجدار الرحم**.

وبما أن **العلقة لا تكاد تبين**، ولا يظهر منها إلا هذا **الدم الغليظ**، فقد **أجمع المفسرون القدامى** على أن العلقة هي **دم غليظ**، **وأصابوا من جهة وأخطأوا من أخرى**؛ فهي **محاطة بالدم الغليظ ولكنها ليست هي ذاتها الدم الغليظ**. وتُدعى قناة الرحم أيضًا **القناة المبيضية**، كما تُدعى **قناة فالوب** نسبة إلى **الطبيب الذي وصفها أول مرة**.

التعريف الأول

ومن خلال ما سبق فقد عرَّف البعض **إجارة الرحم** بأنه: **موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة لا تُنسب إليها لحساب امرأة أخرى**، وتُسلِّم المولود لها بعد ولادته.

وانتقد البعض هذا التعريف **من وجوه ثلاثة**:

١ **الوجه الأول — غير مانع:** إنه تعريف **غير مانع من دخول غير المعرَّف فيه**؛ حيث اقتصر في تعريفه على **موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة دون ذكر العوض**، وهذا يمنع من دخول **الإعارة** فيه.

٢ **الوجه الثاني — غير جامع:** إنه تعريف **غير جامع**؛ لأنه عرَّفه بأنه حمل بويضة ملقحة لامرأة أخرى على أن يُسلَّم المولود إليها بعد ولادته — وهذا **غير جامع لأفراد المعرَّف**؛ لأن المولود قد يُسلَّم إلى امرأة أخرى غير صاحبة البويضة — كما في **بعض صور استئجار الرحم**.

٣ **الوجه الثالث — فيه تكرار:** التعريف فيه **تكرار**؛ حيث كرر لفظ **المرأة**، ومن شرط التعريف **الإيجاز في الحد** ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

التعريف الثاني

وعرَّفه البعض الآخر بأنه: **عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيًا لزوجين استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجة.**

التعريف الثالث

وقيل في تعريفه أيضًا: هو **عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على ألا ينسب المولود إليها.**

٣ دواعي اللجوء لاستئجار الأرحام

هناك **عدة مبررات** تؤدي إلى اللجوء لاستئجار الأرحام، أهمها:

الدواعي الطبية

كأن يكون هناك **مانع طبي يمنع المرأة من استخدام رحمها** وقيامه بالوظيفة التي أُنيطت به؛ كأن تُولد المرأة **بدون أعضاء تناسلية**، أو **بدون رحم لها**، أو تكون مصابة بـ**تشوهات** أو **مرض يجعل الحمل بالنسبة لها مستحيلًا**. وأيضًا: ألا تكون لدى المرأة **القدرة على استكمال مدة الحمل حتى نهايته**، أو **تخشى حدوث مضاعفات شديدة تهدد حياتها** كالإصابة بـ**تسمم الحمل** وغيره.

الدواعي الاجتماعية

كأن تكون المرأة في **مركز مرموق** لا تستطيع مع الحمل القيام بواجباتها الوظيفية. وفي بعض الأحيان تريد المرأة الحصول على مولود **بعيدًا عن آلام الحمل والولادة والأوجاع المصاحبة لهما.**

المبحث الثاني: الحكم الشرعي في تأجير الأرحام

إن بيان الحكم الشرعي في مسألة تأجير الأرحام ليس بالأمر اليسير، فهو يقتضي بيان الصور التي قد يتم بها، وإعطاء الحكم الشرعي في كل حالة على حدة.

المطلب الأول: صور استئجار الأرحام

لم يقف التطور العلمي عند حد معين ولم يجد من الضوابط ما يمكن أن يوقفه، خاصة إذا كان في الأمر مصلحة على الأقل من وجهة نظر العلماء، وقد وُجِدَ التلقيح الصناعي وخاصة ما يتعلق منه بتأجير الأرحام تطوراً ملحوظاً، وأعمل الأطباء عقولهم في ابتكار طرق جديدة وصور متعددة يتم بها الوصول إلى نتائج أفضل ونسب أعلى، والمتتبع للتطور الطبي في هذا المضمار يجد أن هناك عدة صور لتأجير الأرحام، وهي:

١. **الصورة الأولى: الزرع في رحم امرأة أجنبية عن العلاقة الزوجية.** وذلك بعد أخذ الحيوان المنوي من الزوج والبييضة من الزوجة وتلقيحهما في الخارج، ثم يعاد زرعها في رحم تلك المرأة الأجنبية. وتعد هذه الصورة هي الأكثر شهرة في عالم تأجير الأرحام.

٢. **الصورة الثانية: الزرع في رحم الزوجة الثانية للرجل.** حيث تكون له زوجتان إحداهما سليمة المبيض معتلة الرحم، والأخرى عكسها، أو تكون الزوجة الثانية سليمة من الناحيتين، فتؤخذ البييضة من الزوجة معتلة الرحم، والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية.

٣. **الصورة الثالثة: التبرع بالبويضة من قبل امرأة أجنبية.** وهذه الصورة يلجأ إليها إذا كانت الزوجة عاقرًا بحيث لا يفرز مبيضها بييضات، إذ يتم أخذ البييضة من امرأة متبرعة والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة.

٤. **الصورة الرابعة: انعدام العلاقات بين أطراف العملية.** إذ إن كلاً منهما أجنبي عن الآخر، وفي هذه الصورة تؤخذ البييضة من امرأة أجنبية، والحيوان المنوي من رجل أجنبي، وتوضع بعد تلقيحها في رحم امرأة أجنبية، وبعد تمام الوضع يعطى الجنين لامرأة أخرى هي التي أنفقت على العملية، وهذه الصورة يلجأ إليها في حالة عدم قدرة الزوجين كلية عن الإنجاب.

٥. **الصورة الخامسة: الحمل بعد وفاة الزوجين.** تؤخذ البويضة من الزوجة ويؤخذ الحيوان المنوي من الزوج، ويتم تلقيحها خارجياً في طبق في المعمل، وبعد تلقيحها تُنْقَلُ اللقيحة إلى جسم متبرعة بالرحم على أن يكون هذا الأمر بعد وفاة الزوجين.

٦. **الصورة السادسة: تعدد مصادر اللقيحة.** تلقح بويضة الزوجة بماء رجل غريب ليس زوجها، ثم تُزرع اللقيحة أو الجنين المجمد في رحم امرأة أجنبية، وتستعمل هذه الصورة في حال كون الزوج عقيما، والزوجة عندها خلل في رحمها ولكن مبيضها سليم.

٧ **الصورة السابعة: استخدام رحم الحيوان.** تؤخذ بويضة من الزوجة وحيوان منوي من الزوج، ويتم تلقيح البويضة خارجيًا، ثم توضع اللقيحة في رحم أنثى حيوان يصلح لاحتضان البويضة الملقحة، فيحل رحمه محل رحم المرأة لفترة من الزمن ثم يعاد الجنين بعدها إلى رحم الزوجة.

وباستقراء الصور المستخدمة في الواقع العملي يتضح أن **الصورتين الأولى والثانية** هما الأكثر استعمالا، لذا أفصل القول في حكمهما الشرعي، أما باقي الصور فقد وقع الاتفاق على تحريمها.

المطلب الثاني: الزرع في رحم الزوجة الأخرى للزوج (الضرة)

تعد هذه الصورة إحدى صور التلقيح الصناعي الخارجي، وفيه يكون للرجل زوجتان أو أكثر فتؤخذ البويضة من إحداهن، والحيوان المنوي من الرجل ثم تزرع في رحم الزوجة الأخرى.

موقف مجمع الفقه الإسلامي من هذه الصورة:

الدورة السابعة – عام ١٤٠٤هـ: عُرضت هذه الصورة لأول مرة في الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، وأصدر المجلس قراراً **بجواز** هذه العملية.

الاستنكار الشديد: إلا أنه مع الاستنكار الشديد من العلماء اضطر المجمع لنظر القضية مرة أخرى في الدورة الثامنة.

الدورة الثامنة – عام ١٤٠٥هـ: أصدر المجلس قراره **بالتحريم القاطع** لهذه الصورة.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين:

١ **القول الأول:** يرى أنصاره أن الإخصاب مع استخدام رحم الزوجة الثانية للرجل أمر محرم ولا يجوز فعله، وهو ما ذهب إليه أغلب العلماء المعاصرين والمجامع والندوات الفقهية التي عقدت لبحث هذا الموضوع.

٢ **القول الثاني:** يرى جواز زرع اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل، وهو قول بعض المعاصرين كالدكتور عمر الأشقر، والشيخ محمد علي التسخيري.

أدلة القول الأول: القائلين بتحريم الزرع في رحم الزوجة الثانية

استدل القائلون بتحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية بما يلي:

١ الاستدلال بآيات قرآنية على أوصاف الأمومة:

استدلوا بآيات عديدة من القرآن الكريم:

MARA 01105405478

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤]

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر: ٦]

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٣]

وجه الدلالة: بينت هذه الآيات أوصاف الأمومة التي أُنيطت بها الأحكام الشرعية، ومفادها أن الأمومة لها وصفان: **وصف التكوين، ووصف الحمل والولادة**، فأصل التكوين هي البويضة، وأصل الحمل والولادة هو الرحم، وفي مسألتنا وُجدت الأولى يقينا، وانعدمت الثانية قطعا، الأمر الذي يجعل هذا الفعل محرمًا.

٢ الاستدلال باختلاط الأنساب من جهة الأم:

إن مثل هذا الفعل يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم، إذ قد تحمل الزوجة صاحبة الرحم من زوجها في ذات الوقت، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على هذه الحالة فقال:

«احتمال حمل الزوجة التي زرعت فيها اللقيحة قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين، ولا يُعْلَمُ ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج أو قد تموت علقة أحد الحملين، ولا يعلم أمه الحقيقية مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب من جهة الأم».

المناقشة:

المناقشة الأولى: إن احتمال حمل صاحب الرحم قبل انسداد الرحم وإن كان واردا من الناحية النظرية إلا أنه مستبعد من الناحية العملية؛ لأن صاحبة الرحم هذه تحتاج إلى فترة إعداد، وغالباً ما يمنع الاتصال الجنسي مع زوجها في هذه المرحلة، إذ إنها لا تخرج غالبًا من المستشفى إلا بعد أن توضع اللقيحة فيها.

المناقشة الثانية: من المعلوم بديهيًا أن نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية – الضرة – لا يكون إلا بعد التأكد من خلو رحمها من الحمل، وامتناع الجماع بينها وبين زوجها لحين التأكد من حصول الحمل، وبالتالي لا يترتب على ذلك أي اختلاط للأنساب، فيكون هذا النوع من التلقيح بناءً على ذلك مباحًا.

الجواب: يجاب عن هذه المناقشة بأن هذه الصورة مؤدية إلى اختلاط الأنساب حتى مع منع هذا الاحتمال؛ لأن هذه الطريقة في الإنجاب تؤدي إلى الاشتباه في تحديد الأم الحقيقية للمولود، وهل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم.

٣ الاستدلال بالقياس على السحاق:

استدلوا بالقياس على السحاق بجامع أن كلا منهما وَضْعٌ لماء امرأة أجنبية في رحم أخرى، وَلَمَّا كان السحاق محرمًا كان التلقيح بهذه الصورة هو الآخر محرمًا.

المناقشة:

نوقش قياس وضع النطفة في رحم الزوجة الأخرى للرجل على السحاق بأنه قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:

١. **اختلاف القصد والهدف:** فالقصد من السحاق هو الحصول على المتعة واللذة وقضاء الشهوة، بخلاف التلقيح، إذ الهدف منه الاستيلاد والحصول على الولد.

٢. **عدم نقل البييضات:** إن السحاق لا ينتج عنه نقل بييضات من طرف إلى الطرف الآخر، أما في التلقيح فيتم نقل بييضة عن طريق عملية جراحية.

٣. **عدم الإنزال في الفرج:** إن السحاق هو إتيان المرأة المرأة من أجل الحصول على اللذة، وهذا الفعل لا يتضمن الإنزال داخل الفرج، أما غرس اللقيحة فيتضمن نقل ماء المرأة إلى رحم امرأة أخرى.

٤ الاستدلال بقاعدة «الأصل في الفروج التحريم»:

استدلوا على التحريم بالقاعدة الفقهية التي تقضي «أن الأصل في الفروج التحريم» حيث أوضحت القاعدة أن كل أمر يتعلق بالفروج حرام إلا ما ورد الدليل بجوازه في قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

[المؤمنون: ٥-٦]

تفصيل القاعدة: وبناءً على ذلك فإن المني إذا كان من الزوج جاز استدخاله في رحم زوجته؛ لأنه لم يخرج عن نطاق الحياة الزوجية، فهو مما ورد الدليل بجوازه. أما اللقيحة التي تُزْرَعُ في رحم غير رحم المرأة المأخوذ منها فهي غير جائزة حتى ولو تم تلقيحها بماء الزوج؛ لأن الجائز والمباح هو ماء الزوج فقط، واللقيحة ليست من ماء الزوج فقط، بل هي خليط من ماء الزوج وماء الزوجة، فاللقيحة في هذه الحالة اجتمع فيها المحظور والمأذون فيه، والقاعدة أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قُدِّم جانب الحظر فيه على جانب الإباحة خاصةً إذا كان يتعلق بالفروج.

٥ الاستدلال بقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»:

قرر الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي التبرع بحمل اللقيحة مفاسد تفوق ما فيه من مصالح، إذ تؤدي إلى نزاعات وخلافات، وكل ما أدى إلى النزاع والشقاق كان حرامًا.

المناقشة:

يناقش هذا الدليل بأن هذه الخلافات والنزاعات يمكن التغلب عليها عن طريق العقد الذي يتم بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم والذي توضح فيه كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها والواجب اتباعها.

الجواب: نسلم لكم أن هذا العقد قد يحسم الخلافات والنزاعات، ولكن هذا من الناحية النظرية، أما من ناحية الواقع العملي فالأمر يخالف ذلك تمامًا؛ لأن غريزة الأمومة التي وضعها الله في المرأة كفيلة بجعل المرأة تضحي بكل شيء في سبيل الحصول عليها، وشعور المرأتين أن كل واحدة منهما شاركت في تكوين الطفل يجعلها تشعر أنها هي الأم الحقيقية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى النزاع والخلاف.

أدلة القول الثاني: القائلين بجواز الزرع في رحم الزوجة الثانية

استدل أصحاب القول الثاني على قولهم بإباحة وضع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج بما يلي:

١ عدم اختلاط الأنساب وانعدام مفسدة الزنا:

إن هذه العملية ليس فيها اختلاط للأنساب، ولا توجد فيها مفسدة من مفاسد الزنا.

المناقشة:

١ **المناقشة الأولى:** إن تعليل الجواز بعدم اختلاط الأنساب وعدم وجود مفسدة من مفاسد الزنا لا يكفي كدليل لإباحة هذه الحالة، بل لا بد من إقامة الدليل على الحل؛ لأن الزنا ليس هو الوحيد المحرم من بين الأشياء المتعلقة بالفروج، وإنما يوجد غيره، فهو ليس إلا أحد الأفراد التي شملها أصل التحريم.

٢ **المناقشة الثانية:** دعوى عدم اختلاط الأنساب في هذه الطريقة مردودة؛ لأن فيها اختلاط للأنساب من جهة عدم معرفة الأم الحقيقية للمولود هل هي صاحبة البييضة أو صاحبة الرحم.

MIARA 01105405478

٣ **المناقشة الثالثة:** إن الفقهاء اتفقوا على تحريم أشياء تتعلق بالفروج مع أنه لا يعد زنا كالسحاق، مما يدل على أن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما ورد الدليل بحله، ونقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى لم يرد دليل بجوازه.

٢ الاستدلال بأن كلتا الزوجتين حرث لصاحب النطفة:

إن القرآن الكريم حدد موضع الحرث في المرأة، وفي مسألتنا كلتا الزوجتين حرث لصاحب النطفة، وبالتالي فلا مانع من حمل إحداهن لقيحة الأخرى.

المناقشة:

المناقشة الأولى: ما سبق وأن أوضحناه من أن ذلك عرضة لاختلاط الأنساب.

المناقشة الثانية: إنه في حالة تعدد الزوجات يتم كل زواج بعقد مستقل بين رجل وامرأة، أي أنه عقد خالٍ عن التثليث، وبالتالي يجب أن يكون كل حمل هو ثمرة اثنين مزاوجة لا مثالثة، وتظل كلتا الزوجتين خارج نطاق عقد زواج الزوجة الأخرى، مع أن زوجهما واحد، فلا بد من اشتراك الزوجين يقينا في صلة التكوين والوراثة، ولا بد أيضًا أن يكون الحمل والولادة من الزوجة صاحبة البييضة؛ لأن الأبوة والأمومة هي مجموع الهيئة الحاصلة لمولود وقع لقاحه وتكوينه بماء أبويه على فراش الزوجية فحملته أمه في بطنها.

الرأي الراجح: تحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى

من خلال ما سبق عرضه من قولي الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها يظهر لي أن الراجح والأولى بالقبول هو القول **بتحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج**، وذلك لما يلي:

١ **عدم انطباق شروط الضرورة:** إن الصورة التي نحن بصددها لا تنطبق عليها شروط حالة الضرورة أو الحاجة؛ لأن الزوجة صاحبة الرحم إذا كانت سليمة المبيض فإن الزوج يمكنه الإنجاب منها مباشرة دون حاجة لبييضة زوجته الأخرى صاحبة الرحم المعطل، أما لو كانت صاحبة الرحم معتلة المبيض، وكلتاهما لا يمكنهما الإنجاب، فإن من البدائل المشروعة في هذه الحالة هو الزواج بأخرى.

٢ **الرغبة الجديرة بالاعتبار الشرعي:** إنه لا يجوز التذرع بتحقيق رغبة المرأة المعتلة المبيض في الإنجاب، لأن الرغبة الجديرة بالاعتبار الشرعي هي رغبة من يصلح لأداء دوره الإنجابي ولو بالعلاج أو التلقيح الصناعي دون حاجة لتدخل غيره لمساعدته أو القيام مقامه في هذا الدور، مع ملاحظة أن الرغبة إذا تعارضت مع محظور شرعي فإن اتباع الشرع أولى وآكد.

٣ **حفظ النسل من الكليات الخمس:** إن حفظ النسل وما يترتب عليه من صيانة للأنساب يعد أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وفي سبيل تحقيق هذه المصلحة حرمت الشريعة كل ما يمكن أن يؤدي من قريب أو بعيد لحفظها.

٤ **ما يترتب عليه من نزاعات:** إن القول بجواز هذه الصورة من صور التلقيح – كما سبق أن أوضحناه – يؤدي إلى نزاعات كثيرة، وهذه النزاعات تكون بين أفراد تربطهم علاقات أسرية، مما يؤدي إلى قطع أواصر الروابط فيما بينهم، وإذا تم حسم الخلاف بالقضاء - مثلا - فإن الآثار النفسية لن تزول، بل تبقى إلى مدى لا يعلمه إلا الله.

المطلب الثالث: استئجار رحم امرأة أجنبية

اختلف العلماء في حكم إجارة الأرحام أو ما يعرف بالرحم البديل، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول	مضمونه
القول الأول	إجارة الرحم لا تجوز مطلقًا، لا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا.
القول الثاني	إجارة الرحم جائزة على الإطلاق سواء أكانت صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل أم لا.
القول الثالث	التفريق بينما إذا كانت المرأة صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أو لا، فإذا كانت زوجة أخرى جازت إجارة رحمها وإلا فلا.

أولاً: أدلة القائلين بحرمة تأجير الأرحام

استدل القائلون بحرمة تأجير الأرحام بالأدلة الآتية:

١ الاستدلال بآية حفظ الفروج:

قال سبحانه وتعالى:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج: ٢٩-٣١]

وجه الدلالة: حث الله عز وجل في الآيات السابقة على حفظ الفروج، وبين أن الحفظ لا يكون إلا بقصرها على الزوجة وملك اليمين، وفي الآية استثناء في قوله تعالى «إلا على أزواجهم» وهو يعني أنه لا يجوز وضع أو إيصال أي شيء إلى امرأة إلا إذا كانت زوجة شرعية. ومن المعلوم أن نقل البويضة الملقحة إلى امرأة أخرى من متعلقات الجماع الذي حرمه الله على غير الأزواج، فكأن الرجل بذلك اتصل بغير زوجته. وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن وضع البويضة المخصبة من مني الزوج في رحم زوجة ثانية لنفس الشخص محرم شرعاً، فمن باب أولى يحرم هذا مع امرأة أجنبية.

٢ الاستدلال بآية «من أزواجكم بنين وحفدة»:

قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢]

وجه الدلالة: بين الله عز وجل أنه جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم أوضح أن الولد إنما يكون من الزوج والزوجة، بدليل قوله «من أزواجكم»، فهذا نص صريح في عدم جواز تأجير الأرحام، لأن الولد وفقاً للنص القرآني لا يكون إلا من زوجة شاركت في إعداده وصاحبة الرحم البديل ليست كذلك، فبطل القول بجواز تأجير الأرحام. أضف إلى ذلك أن الزوجية منتفية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة والمرأة المستأجرة، إذ يشترط في جواز الإنجاب بين رجل وامرأة أن يتم ذلك في ظل عقد زواج مستجمع للأركان والشروط التي بينها الشرع، وفي إجارة الأرحام لا توجد صلة بين الرجل والمرأة، وبالتالي يكون حملها غير مشروع.

٣ الاستدلال بآيات العقم والمشيئة:

قال تعالى:

﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠]

وجه الدلالة: أخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين أنه يهب بمشيئته الإناث لمن يريد والذكور لمن يريد، ويمنع الإنجاب عموما عمن أراد، فدل ذلك على أن هناك طائفة من الناس سيصابون بالعقم، فليس هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا العمل للمرأة العاقر أو العقيم أو من تعاني عجزاً، وبالتالي فليست هناك مصلحة في مخالفة شرع الله وسننه في كونه، فالمؤمن يرضى بأمر الله، ويصبر على ما قدره الله له، لأن الله هو الحكيم الخبير، ولا يجوز لنا أن نخالف أحكامه، كما لا يجوز أن نأتي بطرق ملتوية تكون مثارًا للشك في الأنساب. وهنا يثور التساؤل: هل بهذا الرحم البديل سنقضي على العقم، أم أننا نبيح هذه الوسيلة متوهمين أننا نقضي على العقم، بل أكثر من ذلك يمكن أن نختار جنس الطفل ونوعه.

٤ الاستدلال بأن الرحم ليس ملكًا للمرأة تتاجر به:

إن المرأة ليس لها الحق ولا تملك الصلاحية في أن تقوم بتأجير رحمها، لأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب محكومة بنصوص محكمة من قبل الشارع، كما أن استئجار الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، والله تعالى يقول:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج: ٢٩-٣١]

كما أن هذه العملية تحتوي على استقرار ماء الرجل وزوجته في رحم غريب، وهو غير جائز، لأن رحم الأجنبية محرم فكانت منفعته هي الأخرى محرمة.

يقول ابن رشد: «فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح والمغنيات».

٥ الاستدلال بأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب:

إن تأجير الأرحام يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم البديلة إذا كانت متزوجة، كما أنه يشتمل على صور من الزنا. ولعل تأجير الأرحام مرفوض للأسباب الآتية:

١ حيرة النسب: إن الجنين إذا انفصل عن الأم المستأجرة وَوُلِدَ، فإنه يعيش في هذه الحياة في حيرة من أمره، فإذا كان نسبه ثابتًا قطعا من جهة الأب، إذ هو صاحب النطفة، فالحيرة واقعة من ناحية الأم.

٢ عدم القطع بمصدر التكوين: إن الجنين الناشئ بهذه الطريقة لا يوجد علميا ما يقطع بأنه تم تكوينه من الماء والبويضة اللتين تم إدخالهما في الرحم البديل، أو من ماء الرجل وبويضة أنجبتها المرأة نفسها، فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فجاء تحريمه من هذه الناحية، وهو محرم في جميع الملل.

لذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي في بادئ الأمر عام ١٩٨٦م أباح عملية تأجير الرحم إذا كان الزوج متزوجًا من امرأتين، وتقوم إحداهما باستضافة لقيحة الأخرى، ثم عاد وحرم ذلك لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة، وقد رجع عن رأيه قائلا:

«إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة الزوجة الأولى قد تَحْمِلُ ثانيةً قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة بسبب معاشرة الزوج لها في فترةٍ متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر الذي لا يُعْلَمُ أيضًا أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، أو التباس ما يترتب على ذلك من أحكام».

إن النسب نظام اجتماعي وضعه الشارع الحكيم، وحدد طريقه وهو الزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه، وفي النسب الصحيح توجد أسس القاعدة التي يرتكز عليها التشريع ذو الصلة القوية في هذا الجانب من جوانب الإنسان الذي يوصف بأنه كائن اجتماعي، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي طبيعة علاقة الولد بأطراف العلاقة الثلاثة الزوجين والمتطوعة بالحمل، وماذا عن البيانات الرسمية.

إن مسألة تأجير الأرحام إذا أبيحت فما الذي يضمن أن تقتصر على ذوات الحاجة لها فقط، أي تقتصر على النساء اللواتي برحمهن علة، فقد تلجأ إليه كل من تريد أن تحافظ على جمالها ورشاقتها، فما أسهل عليها أن تستأجر من تحمل عنها كما تستأجر من ترضع عنها، ومعنى هذا أن تكون المرأة الغنية تستطيع أن تكون أما لستة وتسعين ولدًا في كل سنة، ما دامت الأمومة هينة لينة لا تكلف أكثر من إنتاج البويضات والباقي على الحاضنات أو المضيفات الفقيرات اللائي يقمن بدور الأمومة ومتاعبها لقاء دريهمات معدودة، ويستطيع الرجل الثري أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع حيث يمكن لكل واحدة منهنَّ أن تنجب بعدد البويضات التي خلقها الله لها والتي تبلغ حوالي أربعمائة بيضة من البنين والبنات.

٦ الاستدلال بأنه يولد معه جدل لا يموت:

إن المولود الجديد يولد معه جدل لا يموت إلا بموت صاحبه، فهذه الوسيلة تؤدي في ٩٠٪ من حالاتها إلى مشاكل كثيرة، وبالتالي حدوث نزاعات وخلافات بين الناس، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق بين الناس.

فاستخدام هذه الوسيلة سيلقي بنا في بحار من الظلمات لن نستطيع أن نخرج منها ولا بشق الأنفس، ولَمَّا كان هناك من المفاسد ما لا تحمد عقباه فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن هنا فمن الممكن أن يتفق الطرفان الأب والأم المؤجرين، وذات الرحم المؤجر، وقد يختلفان، وقد يوافق الاتفاق الشرع الإسلامي الحنيف وقد يخالفه، وعند الخلاف قد تعرض الحلول الشعبية وفي هذه الحالة يكون المال كفيلا بإسكات ذوي الحاجات.

أيضًا: فإن إباحة هذه الطريقة أو هذه الوسيلة يتعارض مع الناحية الأخلاقية والاجتماعية، إذ إن العلم مسخر للارتفاع بقيمته الإنسانية وليس العكس، وهناك العديد من الأسئلة تطرح نفسها، ومنها:

؟ هل يمكن أن تكون صاحبة الرحم البديل امرأة مطلقة أو أرملة توفي عنها زوجها؟ والجواب بالنفي؛ إذ كيف يمكن أن تعيش تلك المرأة بالحمل في بطنها وعليها كل مظاهر الحمل وهي بدون زوج؟ هل تعلق على صدرها لافتة تبين فيها أنها صاحبة رحم مؤجر، وأن الجنين الذي في بطنها ليس ابنها.

؟ هل يمكن أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة تعيش مع زوجها؟ والجواب أيضًا بالنفي، حتى ولو وافق الزوج كتابيًا على تأجير رحم زوجته، فهنا تظهر مشاكل دينية وأخرى طبية تمنع مثل هذا التأجير، فالمشكلة الدينية هي أن الإسلام يمنع مخالطة السائل المنوي للرجل الجنين في بطن من رجل آخر، وبالتالي شَرَعَ الدين الإسلامي شهور العدة للزوجة المطلقة قبل أن تتزوج من رجل آخر حتى يمنع هذا الاختلاط في حالة وجود جنين في رحمها من الزوج الأول.

٧ الاستدلال بأنه يؤدي إلى مشاكل مالية:

إن تأجير الأرحام يؤدي إلى مشاكل مالية، إذ إن كلمة التأجير لا يأتي من ورائها سوى الربح، وهو ما يؤدي بدوره إلى جعل ساقطات المجتمع وعاهراته أعلام هذه العملية أو أعلام لهذه التجارة، وهو أمر يدعو للاشمئزاز، فإذا كان من الممكن إجراء الحمل في رحم امرأة أخرى، إلا أن نسبة نجاح هذه العملية بخطواتها قليلة وتحتاج إلى إعادته أكثر من مرة حتى يحدث الحمل، أضف إلى ذلك: أن هناك آلاف الجنيهات مطلوبة لإجراء الأبحاث والتحاليل الطبية اللازمة إضافةً إلى أجر الأطباء الذين سيقومون بهذه العملية، بالإضافة إلى أجر المستشفى والعلاج، مضافًا إلى ذلك كله ما تحتاجه المرأة الحاضنة من مرتب مرتفع شهريًا، فالعملية مكلفة وليست مضمونة.

⚠ أهم المشكلات المترتبة على هذه العمليات:

١ **استغلال المرأة من قبل الشركات المتخصصة.** كما حدث في الغرب، الأمر الذي دفع لجنة الأخلاقيات الطبية في بريطانيا إلى اعتبار هذه العمليات نوعًا من الاستغلال، وتحريم دخول طرف ثالث في عمليات الإخصاب الخارجي.

٢ **استغلال المرأة لهذا الفعل.** فتقوم بتأجير رحمها، حيث إنها تجد فيه مخرجًا وطريقًا للحصول على الأموال الكثيرة تحت وطأة الحاجة الاقتصادية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يفتح الباب أمام النساء الأثرياء للحصول على الأطفال دون شعور بآلام الحمل ومعاناته، الأمر الذي يفقدهن الشعور الكامل بعاطفة الأمومة.

٣ **المشكلات بين صاحبة الرحم وصاحبة البويضة.** إذ قد ترفض صاحبة الرحم تسليم الطفل، لأن مشاعرها تتغير بالحمل والولادة، لأن الرحم عضو بشري له علاقة وثيقة الصلة بالمشاعر والعواطف، بخلاف أي عضو آخر.

منازعات واقعية وصلت إلى ساحات المحاكم:

قضية ريتا باركر وبولين تيلر: عندما وافقت امرأة تدعى «ريتا باركر» على أن تكون أماً بديلة تحمل طفلاً لزوجين هما «بولين وهاري تيلر» وذلك في مقابل أجر، وتم الحمل بالفعل من اللقيحة المكونة من بيضة بولين تيلر والمخصبة بحيوان منوي من زوجها هاري تيلر، وبدأ هاري تيلر يتردد على المرأة التي حملت له ولده، وبدأت المشاكل تظهر، فالأم البديلة وقعت في حبه وغرامه وزنا بها، والزوجة الأصلية شعرت بالغيرة من عملية الحمل التي تكون طرفها من الناحية البيولوجية فقط، وبدأ الشقاق في الأسرة التي كانت تتمتع بقدر من السعادة والاستقرار حتى ذلك الوقت، والأم البديلة رفضت تسليم الطفل بعد ولادته بحجة أن مشاعرها تغيرت بالحمل والولادة، وصارت تشعر بأنها أم الطفل، ولا تستطيع التفريط فيه وبالتالي امتنعت عن تسليمه إلى أمه، وتم رفع الأمر إلى القضاء الذي كان في حيرة من أمره.

قضية الطفل المعاق في أمريكا: حيث استأجر زوجان امرأة متزوجة لكي تقوم بدور البديلة مقابل مبلغ معين وتم شتل النطفة الأمشاج والمكونة من الزوجين في رحمها، وبعد الولادة تبين أن الطفل معاق ومصاب بنقص بالغ في حجم دماغه بحيث سيظل طيلة حياته متأخراً عقلياً، فرفض الزوج الاعتراف بالطفل، كما رفض دفع الأجر المتفق عليه للأم البديلة بدعوى أنه ليس هو الأب لذلك الطفل، وحكمت المحكمة بإلحاق الولد بالزوج المكتري بناءً على التحاليل الطبية، ولكن بالفعل رفض الزوجان أن يعيش الولد معهما وبقي في دار للحضانة تحملت مصاريفها شركة تأمين.

قضية أنجيلا – صحيفة الجارديان بلندن: نشرت صحيفة «الجارديان» في لندن أحدث فضائح تأجير الأرحام، حول السيدة «أنجيلا» التي أجرت رحمها للأسرة غير القادرة على الإنجاب، ولكن الغريب الذي حدث هو قيام الطبيب المختص بزرع جنين ثان إضافة إلى الجنين المتفق عليه لصالح أسرة أخرى، وكان ذلك في سبتمبر ١٩٩٦م، وكان الجنينان ينموان نموًا طبيعيًا في رحم المرأة رغم إنكار الأوساط الدينية لهذا السلوك الغريب، وقامت صاحبة الرحم المؤجر بالدفاع عن نفسها بأنها تقوم بإدخال السرور على الأسر العاجزة عن الإنجاب، ولكن الأكثر غرابة هو ما سيحدث عند الولادة فلمن يُعْطَى المولود الأول، ولمن يُعطى المولود الثاني، وهما المولودان اللذان سيولدان لحظة واحدة، وأجاب الطبيب المختص بأن فصيلة دم المولود هي التي ستحدد أبويه الحقيقيين، وبالتالي فلا حيرة إذاً ولا لبس في تحديد هوية المولودين بعد ولادتهما.

ثانياً: أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام

استدل القائلون بجواز تأجير الأرحام بما يلي:

١ الاستدلال بآيات الخلق من ماء مهين:

قال تعالى:

﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [المرسلات: ٢٠-٢٢]

وجه الدلالة: يرى المجيزون لإجارة الرحم أن هذه الآيات ما هي إلا دليل واضح وصريح على أن الجنين إنما هو نتاج عملية التقاء الحيوان المنوي - ماء الرجل - بالبويضة، ولا دخل للرحم في تكوينه، فالرحم هو الوعاء، وشبهوا دور الرحم بالنسبة للجنين بدور الأرض بالنسبة للنبات فدوره يقتصر على الحمل فقط دون أدنى تأثير في التركيب البيولوجي بدلالة اختلاف أنواع الزروع وطعمها مع أن الماء الذي تسقى به واحد.

المناقشة:

١ **التأثر بالبيئة الرحمية:** إن هذا التأثر مقبول من الناحية الطبية، فالدم وما يقدمه من الغذاء، وما يحمله من الإفرازات، وما يسبح فيه من هرمونات أو سموم، وهو يحيط دائما بخلايا الجسم والخلايا الجرثومية الأصلية لا بد أن يكون له أثره الكبير في هذه الخلايا، أضف إلى ذلك: أن التغيير الذي يصيب الخلايا الجرثومية الأصلية لا يزال مثار جدل في الحقل الطبي والاختبارات التي أجريت حول هذا الموضوع تميل إلى الاعتقاد بأن صفات بلازما الخلايا الجرثومية قد تتغير طبقًا للتأثيرات الخارجية.

٢ **الإنسان نتاج الوراثة والبيئة معاً:** إن الجنين ليس فقط نتاج الكروموزومات الوراثية؛ بل أصبح من المسلمات في المجال الطبي أن الإنسان هو نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة والظروف المحيطة بمراحل نشأته، وأشد هذه الظروف هي تلك التي يتعرض لها أثناء وجوده في الرحم، وبالتالي فمع التسليم الكامل بأن الكروموزومات هي التي تحمل الشفرة الوراثية، فإن ذلك لا يمنع على الإطلاق تأثر الإنسان بظروف أخرى.

وقد أكد **ابن رشد** هذه الحقيقة بقوله: «متى صادف المني الهواء فسد مزاجه، فعلى هذا ينبغي أن يفهم أن في الرحم قوة مغيرة.... ليس لقائل أن يقول إن مني الرجل ومني المرأة ليس لواحدٍ منهما هذا الفعل على الانفراد حتى يمتزجا ويختلطا ويصير لهما لون آخر..... لكن إن وضح هذا أيضًا فالمازج إذا لهذين المنيين والمعطي لهما هذه الصورة هو ضرورة المكون بالحقيقة.. وليس هاهنا شيء يفعل هذا الفعل، ويلزم أن يكون العضو الفاعل لذلك هو العضو الذي فيه القدرة المولدة بالحقيقة، فتكون على هذه القوة المولدة إنما هي في الرحم».

٢ الاستدلال بأن آيات الأمومة لا تعارض الإباحة:

إنه لا تعارض بين هذه الآيات وبين إباحة عملية تأجير الأرحام؛ لأن **الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة**، أما الأم صاحبة الرحم فهي كالأم من الرضاعة. والآيات هي:

﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢]

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤]

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]

٣ الاستدلال بأنه الطريق الوحيد للإنجاب:

إن إجارة الأرحام تجوز إذا كانت هي الطريق الوحيد للإنجاب وتحقيق رغبة الزوجين، حيث لا يوجد غيرها، شريطة أن لا تكون المرأة متزوجة ولا في حكم المتزوجة، وثبوت القدرة الصحية

على إتمام الحمل، وإخطار وليها بذلك، وهو متوافر في مسألتنا، فيكون بذلك تأجير الأرحام جائزا.

المناقشة:

المناقشة الأولى: إن القول بضرورة أن يكون التأجير للرحم هو الطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجين لا يصح؛ لأن هناك من البدائل الأخرى ما يحقق الرغبة لكل منهما وهي الزواج من شخص آخر، كما أن اللجوء إلى المحرمات لتحقيق رغبات مباحة ليس إلا نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل.

المناقشة الثانية: إن تقييد الإباحة بشروط محددة - كما ذكرها المجيزون - من وجهة نظري ليست إلا مرغبات تُرَغِّبُ في القيام بهذه العملية، أو محاولات لإضفاء الصفة الشرعية عليها وإقناع الأفراد بجوازها، ومعلوم أن للشروط في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة، فهي مضبوطة بضوابط الشرع، فليست كل الشروط مباحة.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا» [صحيح البخاري]

أضف إلى ذلك أن الشروط التي وضعها المجيزون من المسلمات، فاشتراط عدم كون المرأة متزوجة شرط بديهي، إذ لا يعقل أن تفعل هذا متزوجة، أو أن يوافق مسلم على استخدام رحم زوجته، كما أن القدرة الصحية على الحمل أمر طبيعي لأن الزوجين الراغبين في التأجير لا يستأجران إلا من تتوافر لديها تلك القدرة، أما شرط إخطار ولي المرأة المستأجرة فهو شرط منتقد؛ إذ لا علاقة للولي بتلك المسألة، فقد قرر الفقهاء أن الثيب أحق بنفسها، فإذا كان هذا في الزواج فيكون هنا من باب أولى، وذلك على فرض التسليم بصحة هذا الشرط.

٤ الاستدلال بإمكانية كتابة عقد يحسم النزاعات:

إذا كان من مبررات تحريم هذا الفعل ما يؤدي إليه من منازعات بين أطرافه فإنه يمكن التغلب على هذه النزاعات عن طريق كتابة عقد تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

٥ الاستدلال بالقياس على الأم من الرضاع:

استدلوا بالقياس من وجوه:

١ **الوجه الأول:** قياس الأم صاحبة الرحم على الأم من الرضاع، ووجه القياس: أن الله جَمَعَ بين الحمل والرضاع في المدة اللازمة لهما في قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف: ١٥].

٢ **الوجه الثاني:** إن كلا منهما يتغذى منه الطفل، والأصل المشترك بينهما الرحم والثدي؛ لأن التغذية تتم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء الأم، وهذه المواد في أصلها غير مستساغة المذاق، فتغذية الجنين بها عن طريق الحبل السري لا يحتاج إلى تغيير في الطعم، أما تغذية الطفل عن طريق الفم فإنها تتطلب تغييرًا في المذاق حتى يمكن أن تستساغ، لأنها تلامس مركز التذوق في الإنسان ألا وهو اللسان.

٣ **الوجه الثالث:** وجود العلاقة الطردية بين نمو الثدي للحامل وبين نمو الجنين، فنمو الثدي مرتبط بنمو الجنين حتى يكون مستعدًا لكي يحل محل الرحم في التغذية عندما يخرج الجنين طفلا، وعليه فإذا كان الإثم ينتفي في حنو المرأة على غير ولدها بإرضاعه، وقد يسند إليها أيضًا أمر تربيته عندما ينتقل الطفل من حجر أمه إلى حجر أسرة مرضعته خلال فترة الرضاعة دون ما سبب أو علة تمنع الأم الوالدة من القيام بأمر الرضاع والتربية، فإنه يصبح من الممكن حلول رحم امرأة محل صاحبة الرحم المعطوب في حمل جنين لها، وإذا كان في انتقال الطفل من أسرته إلى أسرة مرضعته في سن مبكرة خطر ما نظرًا للدور الذي يلعبه العامل البشري في تنشئة الطفل، فإن في الحمل لحساب الغير لا يوجد الأثر المباشر لهذا العامل على الجنين؛ لأن الدور الغالب في فترة الحمل يكون للعوامل الطبيعية التي لا تخضع في عملها لإرادة الإنسان ومشيئته.

المناقشة:

نوقش قياس الأم البديلة على الأم من الرضاع بجامع قصر دور كل واحدة منهما على التغذية بأنه قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:

١ **خصوصية الإرضاع بالضرورة:** إن إباحة الاستئجار للرضاع إنما شرعت للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حياة الطفل، والضرورات التي تبيح المحظورات هي التي تتعلق بهلاك النفس أو إتلاف جزء منها، وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره، وبالتالي لا يجوز قياس الأم البديلة على الأم من الرضاع.

٢ **بطلان دعوى الجمع بين الحمل والإرضاع:** إن تعليل القياس بالجمع بين الحمل والإرضاع في آية واحدة غير مسلم؛ لأن العطف في اللغة يقتضي المغايرة، فالحمل غير الإرضاع ومن ثم فالجمع بينهما غير سديد.

٣ **الفارق بين تغذية الجنين وتغذية الطفل:** إن هناك فارقًا كبيرًا يثبته العقل ويؤكده العمل بين تغذية طفل اكتمل خلقه وانفصل عن أمه، وصار له كيانه الخاص، وبين التغذية التي يحصل عليها جنين لم يكتمل خلقه بعد، بل هو ما زال يتدرج في أطوار الخلق ومراحله، فتغذية الطفل الذي انفصل عن أمه تكون بالرضاع أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي يتغذى بها الطفل في تلك الفترة، أما الجنين الذي ما زال حبيس رحم أمه فتغذيته تكون عن طريق الدم وما يحمله من خلايا تعمل على تكوين الأعضاء.

٤ **الفارق في الأهلية:** إن هناك فارقًا مؤثرًا بين أهلية الطفل بعد الولادة، وأهليته قبل أن يولد، حيث إن الأحكام الشرعية تختلف لكلا الشخصين؛ لأن الأهلية موضع تقدير الشارع في كثير من الأحكام واختلاف نظرة الشارع للأهليتين مرجعه تقديره لاختلاف الطبيعة في الحالين، وهو فارق لا يصح معه القياس.

٥ **اختلاف تكييف الفعل:** قياس استئجار الرحم على الإرضاع مرفوض لاختلاف تكييف الفعل في الحالتين، فالإرضاع عقد إجارة أباحه الشارع وَدَلَّ عليه القرآن وأقرته السنة، أما استئجار الرحم فهو فعل لم يُبِحه نص، بل إن مفهوم النصوص يحرمه، لأن التعاقد على محرم لا يجوز، كما أن المرأة لا يجوز لها من حيث الأصل الإقدام على هذا الفعل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فهذا الفعل وإن كان في ظاهره استئجار لمنفعة الرحم إلا أن حقيقته بيع لطفل مولود، وبيع الحر حرام.

وقد أوضح هذه الحقيقة أحد أطباء المسلمين في القرن الرابع الهجري حيث قال: «السبب في قوام الجنين آلات أمه وغذاؤه من غذائها، وهو يتغذى بسرته، فإذا ولد فليس غذاؤه مثل الذي كان يتغذى من قبل أن يولد لكنه يتغذى باللبن، ثم بالأطعمة، ويشرب الأشربة بفيه، فأما قبل أن يولد فيتغذى بسرته من غذاء أمه، فإذا ولد واغتذى فإنما يغتذي بطبيعته التي توزع غذاؤه في بدنه، وهي التي تبعثه على الاغتذاء».

٦ الاستدلال بثبوت عدم اختلاط الأنساب طبياً:

إنه قد ثبت من الناحية الطبية عدم تحقق الاختلاط بين الأنساب، حيث إن حق الطفل محفوظ عن طريق حمله للصفات الجينية والوراثية للأب والأم.

فيقول علماء الطب: إن البويضة من الزوجة إذا خُصِّبَتْ بماء زوجها ووضعت مخصبة في رحم امرأة أجنبية لا تتضمن اختلاطا للأنساب؛ لأنه في اللحظة التي يتم فيها التلقيح وتتحد كروموزومات البويضة والنطفة تغرز البويضة الملقحة حاجزًا حولها يمنع المساهمة بأية مواد وراثية أخرى حتى تحتفظ الخلية بتكوينها الجيني الذي يحتوي على كل الإرشادات اللازمة لتكوين مخلوق كامل، ولا يمكن تغييرها إطلاقًا، والحياة مليئة بأمثال عديدة تؤيد كل هذه المفاهيم.

٧ الاستدلال بأنه من باب التداوي:

اعتمد المجيزون لتأجير الأرحام في تبريرهم جواز هذه العملية على أن التأجير في هذه الحالة يكون من باب التداوي، والتداوي مشروع، كما أن عدم قدرة الزوجين على الإنجاب يعد من باب الضرورة التي أقرها الشرع.

المناقشة:

١ **التداوي مشروط بإباحة الدواء:** سَلَّمْنَا لكم أن عدم قدرة الزوجين على الإنجاب تعد من قبيل الداء الذي يستوجب الدواء، كما نسلم أيضًا لكم أن التداوي أمر مشروع دعا إليه القرآن ورغب فيه الرسول ﷺ، إلا أن مشروعية التداوي ليست على إطلاقها؛ بل هي مشروطة بكون الدواء المستخدم في العلاج مباحًا لا حرمة فيه.

٢ **قاعدة الضرورة ليست مطلقة:** إن الاعتماد على قاعدة الضرورة على إطلاقها محل نظر؛ لأن لقاعدة الضرورة شروطها وضوابطها التي تكفل الوصول إلى تطبيق أمثل.

٣ **التعارض بين المصالح:** سَلَّمْنَا لكم القول بأن تأجير الأرحام يحقق رغبةً أكيدة للزوجين في أن يكون لهما طفل، إلا أنه بالنظر الدقيق لهذه المسألة نجد أن هناك تعارضًا بين المصالح، حيث إن مصلحة الزوجين التي هي الرغبة في الإنجاب تتعارض مع مصلحة شرعية هي حرمة التعدي على الأبضاع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اختلاط الأنساب والمصلحة الأولى خاصة، والثانية عامة، وعند التعارض يجب إهمال المصلحة الخاصة، أي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وقد قال النبي ﷺ:

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» [سنن أبي داود]

الرأي الراجح: عدم جواز تأجير الأرحام شرعًا

بعد عرض الأقوال وأدلتها أرى أن تأجير الأرحام لا يجوز شرعًا، وذلك لما يلي:

١ **كونه ذريعة إلى اختلاط الأنساب والفساد:** إن هذه الوسيلة فضلا عن كونها ذريعة إلى اختلاط الأنساب نتيجة الازدواج في التكوين والنشأة والخلقة؛ فإنها وسيلة أيضًا إلى الشر والفساد، وكل ما يؤدي إلى الضرر أو الحرام فهو حرام؛ فعادة الشارع ألا يترك المفسدة حتى تقع ثم يعالجها؛ بل يحتاط في منع الوسائل المؤدية إليها. ولا يقال: إن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ لأن ضابط الضرورة خوف الهلاك أو الضرر الشديد على إحدى الضروريات للنفس أو للغير يقينًا أو ظنا إن لم يوجد ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد، ومن ضوابطها كذلك أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع، ومستندة إلى قواعد شرعية، وألا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير، لأن الضرر لا يُزَالُ بالضرر، وأن تقدر بقدرها، والأهم في هذا الخصوص ألا يخالف المضطر مبادئ الإسلام في تحريمه للزنا، وحرصه على ثبوت النسب، وعدم اختلاط الأنساب، والأصل في الإسلام أن: «**دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح**».

٢ **تحويل الأمومة إلى مهنة تجارية:** إن القول بجواز تأجير الأرحام يحول الأمومة من مشاعر مغمورة بالحب والحنان إلى مهنة تصطبغ بالصبغة التجارية، ولقد عانى الغرب من ذلك أسوأ معاناة، فبعد أن انتشرت المراكز التجارية التي تقوم بهذه العملية صارت المرأة تستأجر، وتحولت الأرحام إلى سوق تجاري للربح المادي.

٣ **الإضرار بالمرأة في كل الأحوال:** إننا نعيش في بيئةٍ إسلامية للمرأة فيها وضع خاص يمنع المساس به، وتستمد المرأة هذا الوضع من أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإذا أبيح هذا النوع من الحمل فإنها إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة: فإن كانت متزوجة فمشاكل اختلاط الأنساب لا تنتهي، وإن لم تكن متزوجة فألسنة السوء ستتفوه على المرأة التي حملت من غير زواج، ففي كل الحالات يتم الإضرار بالمرأة.

أ نسب الطفل من جهة الأم:

تعد مشكلة نسب طفل استئجار الأرحام من جهة الأم من المشاكل المعقدة التي ثار بشأنها جدل كبير في الأوساط الفقهية، فبعضهم نظر إلى أصل التكوين، واعتبر الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، والبعض الآخر نظر إلى الغذاء والحمل والولادة، فاعتبر صاحبة الرحم هي الأم، وبعضهم اعتبر أن للطفل أمين، وبالتالي فالمسألة يتنازعها ثلاثة أقوال.

1. **القول الأول: الأم صاحبة البويضة:** ذهب أنصاره إلى أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، وهذا القول هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي برأي أكثرية أعضائه، وأغلب العلماء المعاصرين.
2. **القول الثاني: الأم صاحبة الرحم المؤجر:** يرى أن الطفل ينسب إلى صاحبة الرحم المؤجر التي حملت وولدت، فهي أمه الحقيقية، وهو قول بعض العلماء المعاصرين.
3. **القول الثالث: للطفل أمّان:** يرى د. جابر مهران رأيا مختلفًا في هذه المسألة، فيقول: «إني والله سبحانه وتعالى أعلم أرى أن للطفل أمين الأولى التي حملته، والثانية: صاحبة البيضة».

1. **أما أمومة الأولى (التي حملته):** فدليلها ما ذكره القائلون بأن أمه هي من حملته، وإن كانت أدلتهم لا تصلح إلا لإثبات الأمومة الناقصة للولد على أساس فقدان وصف ضروري آخر للأمومة الكاملة، وهو أن تكون بيضتها سببًا في تكوينه ولما لم تكن كذلك فلا محل للقول بأن كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، والأم بالنسبة لولدها، فهي أم بالوكالة فقط، لأن هذه الأم لم تعطه أيا من جيناتها الوراثية.
2. **وأما الثانية (صاحبة البيضة):** فهي أمه أيضًا، لكنها ليست كالأم المرضعة بل إنها أمه التي أعطته جيناتها الوراثية، وإن كانت لم تحمله في رحمها، وعليه فليست أمومتها كاملة، لأن وصفًا من أوصاف الأمومة الكاملة وهو الولادة لم يتحقق.

وبما أن هذا القول لا دليل له إلا ما ذكره قائله، فسأكتفي بعرض أدلة القولين الأول والثاني فقط.

أدلة القول الأول: القائل بأن الأم هي صاحبة البويضة

استدل أصحاب القول الأول على أن الطفل ينسب إلى صاحبة البويضة بالأدلة الآتية:

أ الاستدلال بحديث «الولد للفراش»:

استدلوا بقول النبي ﷺ في صحيح البخاري: «الولد للفراش» .

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ جعل الفراش علة للحكم بالولد، إذ لا معنى للفراش إلا الزوجية الصحيحة، فالولد في الحديث لا يعني إلا التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، وترتيبا على ذلك فإذا كان للرجل زوجة صارت فراشًا له، فإذا أتت بولد لمدة الحمل صار ولده، وتجري بينهما الأحكام المترتبة عليه.

المناقشة الأولى: إن هذا الحديث خارج عن محل النزاع، فهو وارد في النسب من جهة الأب، فليس في الحديث دليل لا من قريب ولا من بعيد على أحقية صاحبة البييضة بالنسب.

المناقشة الثانية: إن الاستدلال مبني على وجود فراش بين الزوج وصاحبة البويضة، وبالتالي ينسب الطفل إلى صاحبة البويضة وزوجها.

ب الاستدلال بالعوامل البيولوجية والوراثية:

استدلوا بقولهم: إن القرآن الكريم اهتم بالعوامل البيولوجية والوراثية كأساس لثبوت النسب.

مراحل تكوّن الجنين كما وردت في القرآن:

1. **النطفة الأمشاج: بداية الانشطار:** ورد في القرآن أن الأصل في الإنسان النطفة وهي المسماة بالنطفة الأمشاج، حيث تبدأ بالانشطار منذ لحظة التخصيب، أي أن الخلية تصبح خليتين، والخليتين أربع، وهكذا حتى يتم تكوين مئات الخلايا التي تشبه ثمرة التوت.
2. **تطور النطفة إلى علقة:** ثم تتطور هذه النطفة إلى علقة.
3. **نمو العلقة وتغذيتها:** وتنمو العلقة عن طريق امتصاص الغذاء من البرك الدموية الرحمية، وفي تلك الفترة يكون الاتصال بين دماء الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالا مباشرًا، وتتغذى الكرة الجرثومية من هذه الدماء، كما أنها تتغذى بإفرازاتها الغدد الرحمية التي يبلغ عددها ١٥٠٠٠ غدة رحمية تفرز جميعها ما يسمى بلبن الرحم الذي تتغذى عليه العلقة.
4. **التطور النهائي إلى نطفة:** وتتطور العلقة بعد ذلك إلى نطفة، وقد جاءت آيات القرآن مؤكدة تلك التطورات.

والحاصل: وعلى ذلك فالجنين إنما يتكون من الخلايا التي تحمل الصفات الوراثية للأم والأب.

MIARA 01054054478

يقول د. عبد المحسن الصالح: «فإذا حملت السيدة غير المتزوجة جنينا غريبًا عنها ووضعته وأرضعته وحضنته وأنشأته، فإن الشعور السائد قد ينسب الطفل إليها على أنها أمه، لكن ذلك ليس صحيحًا من وجهة النظر البيولوجية أو الوراثية، فمثل السيدة التي تلد جنينًا مزروعا كمثل المرضعة التي ترضع وليدًا غير وليدها، فالطفل الرضيع يستخلص من الدم غذاءه، وكذلك بفعل الجنين المزروع، فهو يحصل من دماء الحاضنة على مقوماته الغذائية عن طريق اتصال دورتها الدموية بدورته مع ما ينساب في تلك الدورة من هرمونات لها أثر على الجنين..... إن السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء أساسًا من الخلايا الجنسية للأبوين، فكل خلية بمثابة ميكروفيلم للمخلوق الذي منه قد جاءت، فإذا كان الأبوان شقراوين وطويلين وحدث التلقيح بين خلاياهما الجنسية في الأنبوب، ثم زرع الجنين الناتج في زنجية فإنه لا يحمل أي صفة من صفاتها؛ بل يخرج إلى الحياة كوليد أشقر تماما كصفات والديه».

❶ المناقشة الأولى: قضية عتبة بن أبي وقاص:

المناقشة إن الاستدلال السابق محل نظر؛ لأن الإسلام في مسألة النسب لا يعتمد فقط على الحقائق العلمية؛ بل للقواعد الشرعية دور أساسي، وقد علق النبي ﷺ ثبوت النسب على الفراش مع وجود بعض الصفات الوراثية في الولد.

الوصية: روى البخاري أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه.

المطالبة: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد عهد به إلي.

الاعتراض: فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه.

الخصومة إلى النبي ﷺ: فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد به إلي، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه.

الحكم النبوي: فقال رسول الله ﷺ: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» .

الأمر بالاحتجاب: ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

ويرى ابن القيم أن حكم النبي في هذه القضية مراعاة للشيئين وإعمالا للدليلين؛ لأن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحب الفراش دليل نفي النسب، وأعمل الرسول ﷺ أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوة الفراش، فأعمل الشبه الظاهر بعتبة بن أبي وقاص بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة بنت زمعة.

يقول ابن القيم: «وهذا من أحسن الأحكام وأثبتها وأصحها، ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها، وقد تتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة مثل القتل والردة فإنهما يمنعان من الميراث مع ثبوت النسب، فلا ينكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا محض الفقه».

الجواب: يجاب عن ذلك بأن الشارع لم يعتمد الشبه لوجود معارض أقوى وهو الفراش، وبالتالي إذا لم يوجد الفراش فإن الشبه يعتد به، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين جلدة وقد علم أني رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استثبت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعا بهما رسول الله حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال والله إني لصادق فقال احلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق يقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله ﷺ قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلفت ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين وإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله ﷺ قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فرددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي، فقال رسول الله ﷺ إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر قصفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على الصفة.

٢ المناقشة الثانية: أقوال الأطباء:

المناقشة إن الطب قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجنين نتاج العوامل الوراثية، فهو يتأثر بها، ويتعامل مع البيئة المحيطة به، وأشد تلك البيئات هو الرحم، وقد جاءت عبارات الأطباء دالة على هذه الحقيقة، ومن عباراتهم:

الطبيب	الرأي
دكتور جمال أبو السرور	إن عدم تغير الصفات الوراثية للجنين بانتقاله إلى رحم جديد ليس القول الفصل في المسألة؛ لأن الجنين يتغذى ويتأثر بالرحم، وأن المعروف أن نمو الجنين وتكوينه لا يعتمد فقط على الكروموزومات من أمه وأبيه؛ بل يتأثر بالبيئة المحيطة، وربما يؤدي تناول عقاقير معينة أو سلوك عادات ضارة — كشرب الكحول أو التدخين — إلى تشوه الجنين؛ لأن الأم الحاضنة تتفاعل مع جنينها، ولا بد أن تؤثر بالسلب أو بالإيجاب، وبالتالي لا نوافق على موضوع الأم الحاضنة أو تأجير الأرحام طبيا.
دكتور محمد عبد السلام	إن الرحم ليس مجرد وعاء، بل هو غذاء ومناعة ومشاعر ودفء، وبه أجسام مضادة للأمراض، وهناك جدل كبير حول هذه العمليات في الغرب، فلماذا نفتح

هذا الباب هنا، بالتأكيد الأم الحاضنة أسهمت في إنتاج المولود فلمن ينسب؟ وكيف نقول لها ليس لك حق فيه وماذا لو حدث تلاعب بالأجنة؟

الدكتورة إكرام عبد السلام

تغذية الجنين في الرحم ليست فقط بإمداده بالغذاء والأكسجين، ولكن دم الأم الحاضنة الذي يصل إلى الجنين يحمل كل مكوناته الوراثية، وعلى سبيل المثال: إذا زاد هرمون الغدة الدرقية في دم الأم الحاضنة أثناء الحمل أدى إلى اختلاط نشاط الغدة الدرقية للجنين، كذلك إصابة الأم الحامل بمرض السكر يتأثر به الجنين، وإذا كانت الأم الحاضنة حاملة لجين أحد الأمراض الوراثية مثل بعض أمراض سوء التمثيل الغذائي الوراثية، فإن ذلك يؤثر على الجنين ويستمر تأثيره إلى فترات متفاوتة بعد الولادة، لذلك فإن الأم الحاضنة لا يقف تأثيرها على حمل الجنين، بل يتعدى إلى التأثير المباشر في مكونات الدم الوراثية، وبالتالي على الجهاز العصبي والغدد الصماء للجنين.

وغير ذلك من أقوال الأطباء التي لا يتسع المجال لذكرها.

الجواب: يجاب عن ذلك بأن الصفات الوراثية تُؤْخَذُ من الأب صاحب الحيوان المنوي، والأم صاحبة البييضة بصفة أساسية، والتأثير الذي تقولون به مهما بلغ مداه فلن يرقى إلى التغيير في الصفات الوراثية، سواء من ناحية الأصل أو الطبع، لأن أصول كل إنسان ترجع إلى الوالدين صاحبا النطفة والبييضة.

٣ المناقشة الثالثة: الاحترام الشرعي للمائين:

الأصل: النسب لا يقوم على العوامل البيولوجية وحدها: القول بأن أساس ثبوت النسب هو العوامل البيولوجية فقط قول غير مسلم.

الشرط: احترام الماءين: لأن الإسلام عند إقراره أن الطفل من ماء الزوج والزوجة اشترط في هذين الماءين أن يكونا محترمين، وإلا فيعتبران هدرًا لا قيمة لهما.

النتيجة: عدم ثبوت النسب من الأم البديلة: وبالتالي فالأم البديلة أو صاحبة الرحم التي ليست بفراش للزوج صاحب النطفة لا يثبت منها نسب المولود.

السبب: التصرف في غير إطار الشرع: لأن هذا التصرف لا يجوز شرعًا، لأنه تم في غير الإطار الذي رسمه الشرع، إذ إنها لم تحمل بطريق صحيح أو فاسد بشبهة، ولكن بإدخال حيوان منوي وبييضة أجنبية عنها مخصبة بهذا الحيوان المنوي مما يعد في معنى الزنا والسحاق الموجبين للعقوبة، وعدم اعتبار النسب منها لغيرها مطلقا، إلا أنه ليس بأب شرعي.

المعيار: اعتبار الشرع: وبالتالي فالمدار في ذلك كله اعتبار الشرع وعدمه، والشرع وإن تشوف لثبوت النسب وأثبته بمجرد الإمكان إلا أنه اشترط أن يكون ذلك في إطار علاقة من العلاقات التي رتب عليها الشارع هذا الأثر، والأم البديلة لا تدخل تحت أي علاقة من تلك العلاقات.

⚠ **الفرق: جماع صورة ومعنى:** بل إنها وإن لم يصدق عليها وصف الزنا ظاهراً، إلا أنه يصدق عليها معناه، فظاهر الزنا أو صورته المادية تتمثل في الإيلاج، أما حقيقته ومعناه وهو إنزال المني لما يترتب عليه من اختلاط للأنساب، فإنزال المني في الفرج عن طريق الجماع يسمى جماعًا صورة ومعنى أما إنزاله فقط يسمى جماعًا معنى.

ج الاستدلال بالقياس:

١ **قياس نسب الأم على نسب الأب:** إذ إن الأب الذي هو صاحب النطفة نسب إليه الطفل، فكذلك الأم قياسًا عليه.

٢ **قياس الرحم المؤجر على أنبوب الاختبار:** فالأنبوب الذي ينمو فيه الطفل ليس له تأثير في النسب، فكذلك الرحم المؤجر باعتبار أن كلا منهما وعاء.

المناقشة نوقش الاستدلال السابق من وجهين:

نوع القياس	المناقشة
قياس نسب الأم على نسب الأب	إن القياس على نسب الأب قياس مع الفارق؛ لأن النسب الثابت للأب ليس لأن الطفل تخلق من مائه، بل يثبت له النسب لأنه صاحب الفراش الذي ولد عليه المولود، والغالب في صور التأجير للرحم أن يكون صاحب الماء أجنبياً عن صاحبة الرحم، وبالتالي فالفراش لا وجود له هنا، وبالتالي فالقياس غير صحيح.
قياس الرحم على أنبوب الاختبار	قياس رحم المرأة على أنبوب الاختبار مرفوض لثلاثة أسباب: إن استخدام الأنبوب لا يؤدي إلى الشك في الأنساب بخلاف رحم المرأة، وإن الأنبوب ليس إنسانًا يمكن مطالبته بحق أو متطلعا لذلك الحق، وإنه يوجد ترابط وتلاحم كاملين بين الجنين وصاحبة الرحم مع إيجاد عاطفة بينهما عكس الأنبوب.

الجواب: يجاب عن ذلك بأن المولود من جهة الأب ينسب إلى صاحب النطفة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فإذا وُجِدَ مانع وهو الزنا انتفى الأصل، إلا أنه لا يلزم من انتفاء النسب عن صاحب النطفة انتفاؤه عن صاحب البويضة، لأن الشارع أثبت نسب المولود من جهة الأم المزني بها، وهو اتفاق العلماء بين مع نفيه عن الزاني صاحب النطفة.

أدلة القول الثاني: القائل بأن الأم هي صاحبة الرحم

استدل القائلون بأن الأم هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت بالأدلة الآتية:

أ الاستدلال من القرآن الكريم:

قال تعالى في سورة المجادلة: «إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» ، وقال تعالى في سورة البقرة: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» .

وجه الدلالة: دلت الآيتان دلالةً لا خفاء فيها على أن الأم الحقيقية لطفل تأجير الأرحام هي التي حملت وولدت حيث صرحت الآية الأولى أن الولادة هي سبب الأمومة، والآية الثانية أسندت أمومة الولد إلى المرأة القائمة بالإرضاع ومفهوم المخالفة يقتضي انتفاء صفة الأمومة عن التي لم تلد ولم ترضع.

وقال تعالى في سورة النجم: «وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» ، وقال تعالى في سورة الزمر: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» .

وجه الدلالة: بين القرآن الكريم أن للخلق أطوارا، وهذه الأطوار تحدث للجنين في رحم الأم، وبالتالي فإن الأمومة تعتمد على تخلق الجنين في بطن الأم، لذا وجب الحكم بأنها الأم الحقيقية، أما صاحبة البييضة فهذا الوصف غير متحقق فيها وبالتالي تنتفي عنها صفة الأمومة.

المناقشة نوقش الاستدلال بالآيات السابقة بمناقشات ثلاث:

1. **المناقشة الأولى:** إن مفهوم الأمومة الوارد في هذه الآيات يقتضي أن الأم هي التي تحمل المولود في رحمها بعد اختلاط مائها بماء زوجها، فهي بذلك تشارك في تكوين المولود، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تقوم بحمله في رحمها مدة الحمل حتى تضعه، وعلى هذا المفهوم تتنزل جميع الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام أما إذا كانت البويضة من امرأة والحمل والولادة من امرأةٍ غيرها فلا تدخل في مفهوم هذه النصوص الشرعية، فالأم الواردة في هذه الآيات هي الأم التي تخلق الجنين في رحمها ابتداءً وانتهاءً، فالتكوين والحمل لا يبدأ إلا عند تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل، وصاحبة الرحم ما كان لها أن تحمل ثم تلد لولا زرع اللقيحة في رحمها.
2. **المناقشة الثانية:** إن حصر الأم في المرأة التي تحمل وتلد يتعارض مع قوله تعالى في سورة النساء: «وأمهاتكم التي أرضعنكم» لأن الله تعالى سماها أما.
3. **المناقشة الثالثة:** إن حصر الأم في التي تحمل وتلد ليس مقصودًا هنا، لأن للآية سبب خاص، حيث نزلت ردًا على الذين يشبهون زوجاتهم بأمهاتهم الظهار.

الجواب: يجاب عن هذه المناقشات بجوابين: **الأول:** سَلَّمْنَا أن الآية نزلت في بيان أمر الظهار، إلا أن ذلك لا يعتبر دليلاً على نفي حصر الأمومة في الولادة، لأن الآية وإن كانت قد نزلت في شأن الأم والزوجة إلا أنها تفيد تحديد المعنى الحقيقي للأمومة وحصرها في الولادة، وأن أي امرأة أخرى سواء الزوجة التي ظوهر منها أو غيرها ليست أما بالمعنى الحقيقي للأمومة. **والثاني:** لا نسلم لكم القول بأن حصر الأمومة في الولادة يخرج الأم من الرضاعة لوجود الفارق الكبير بينهما، لأن الأم المرضعة وإن سميت أما إلا أنها ليست أما بالمعنى الحقيقي للأمومة، فتسميتها أما لترتب بعض الأحكام الشرعية على الرضاعة.

ب الاستدلال بالغذاء وآلام الحمل:

استدلوا بقولهم: إن الغذاء الذي نما به الطفل وترعرع في بطن الأم إنما كان من دم المرأة صاحبة الرحم كما أنها هي التي تحملت آلام الحمل والولادة وأوجاعهما، فكان منطقيًا أن تكون هي الأم على عكس صاحبة البييضة التي لم تذق أيا من هذه الآلام.

ج الاستدلال بقياس الدجاجة الحاضنة:

استدلوا بقياس صاحبة البويضة على الدجاجة التي تبيض البيض ولا تحضنه فالفرخ الناتج عن هذه البويضة ينسب إلى الحاضنة لا إلى صاحبة البييضة.

المناقشة:

الوجه الأول: إن القياس منقوض بما لو كان البيض الذي تحضنه الدجاجة بيضًا لطيور أخرى كالبط والحمام، فقطعًا أن البطة أو الحمامة لا تنسب إلى الدجاجة.

الوجه الثاني: إن الشارع لم يرتب على أنساب الحيوانات أحكامًا شرعية، ولذا لم يشترط شروطا للإنجاب بين الحيوانات بخلاف الإنسان، وحينئذ فهو الفارق.

الرأي الراجح: ترجيح أن الأم هي صاحبة البويضة

من خلال ما تقدم عرضه من أقوال في هذه المسألة يترجح عندي قول من قال بأن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، وذلك لما يلي:

١ إن هذا القول هو ما تطمئن إليه النفوس نظرًا لاتفاقه مع الفطرة السوية.

٢ إن الأدلة التي استدل بها أنصار هذا القول قوية في الدلالة على أن صاحبة البييضة هي الأم الحقيقية للطفل.

٣ إن المعتبر في نظر الشرع هو لحظة تلقيح البييضة، فما دام التلقيح تَمَّ بين بييضة الزوج والحيوان المنوي من الزوج فإن صفة الاحترام وجدت في الماءين، وبالتالي يثبت النسب لهما، أي أن نسب الطفل قد ثبت لصاحبة البييضة قبل أن تدخل اللقيحة في الرحم الآخر، واستمر هذا النسب ثابتًا طيلة وجود اللقيحة في الرحم.

ثانيا: النسب من جهة الأب

اختلف العلماء في نسب الطفل من ناحية الأب، فبعض الفقهاء اعتبر أن الأب هو صاحب النطفة، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن النسب لصاحب الفراش أي زوج المرأة التي غرست اللقيحة في رحمها، وإذا كانت ليست بذات زوج أخذ هذا الولد حكم ابن الزنا.

ولكن بعيدًا عن الخلاف السابق أرى أنه في ظل التطورات العلمية والتقدم الطبي، فإن النسب يثبت لصاحب الحيوان المنوي حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تكفل اتخاذ الحيطة والحذر لضمان سلامة هذه العملية من أية شوائب، إذ يمنع الاتصال الجنسي بين صاحبة الرحم وزوجها طيلة الفترة الأولية المخصصة لإجراء العملية، لذا فإن الطفل ينسب إلى الرجل صاحب الحيوان المنوي.

تدريبات: على الوحدة الثانية

١ بين المفهوم العلمي والشرعي لعملية تأجير الأرحام.

٢ تأجير الأرحام يأخذ صورًا عديدة، اذكرها على سبيل الإجمال.

٣ اذكر دليلين من أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام، ثم قم بمناقشتها، والرد عليها.

٤ لمن ينسب طفل تأجير الأرحام من جهة الأم؟

٥ متى يكون تأجير الأرحام جائزا؟

MNAPA 01105405473

القضية الثالثة: موت الدماغ وجدال فقهي حول نزع الأجهزة ونقل الأعضاء «وهل يعد موتاً حقيقياً؟»

١. هل **موت الدماغ** موتٌ حقيقيٌّ تُبنى عليه الأحكام؟

٢. ما موقف الفقهاء من **نزع الأجهزة** عن مريض موت الدماغ؟

٣. ما حكم **نقل الأعضاء** من ميت الدماغ إلى غيره؟

٤. ما **التكييف الشرعي** الصحيح لهذه المسألة النازلة؟

وبما أن الإنسان دائماً يحن إلى أصله قصد ذلك أم لم يقصد، فإن فلسفة وجوده وبقائه ونهايته لا تزال مسيطرة عليه وعلى فكره، فقضية الحياة والموت تشغل بال الفرد ليل نهار، بل إن **فلسفة الموت** تأخذ حيزاً من التفكير أكبر من تلك التي تأخذها فلسفة الحياة؛ لأن الإنسان إذا ولد وبلغ وترعرع، فإن الموت يكون في انتظاره، أما قبل ذلك فلا يفكر في حياة ولا ينتظرها، لأنه لا وجود له من حيث الأساس، لذلك فإن مفهوم الموت أمر لا يحتاجه الفرد ليسيطر على مشاعره؛ بل ليؤثر في سلوكه وتخطيطه لحياته، فهو المؤثر على حاضره ومستقبله.

ولقد كثرت المفاهيم التي تنازعت معنى الموت، وكشف الأطباء عن صور حديثة للموت **كموت الدماغ** ، وصرح أغلبهم بأنه موت بالمعنى الحقيقي، ويجب بناء الأحكام عليه، إلا أن هذا الاتجاه وجد معارضة من بعض الأطباء وأغلب علماء الشريعة؛ نظراً لأن للموت عندهم علامات لا بد من تحققها.

من خلال الاطلاع على أغلب ما كتب في هذا الموضوع، من الناحيتين الشرعية والطبية، بات واضحاً أن المشكلة تكمن في **عدم الوصول إلى عناصر أساسية** في التحديد الدقيق لمفهوم الموت حتى نستطيع من خلالها الحكم على الشخص بالموت أو عدمه، فبينما ينظر الفقهاء إلى الموت باعتباره انقطاع تعلق الروح بالجسد وعدم صلاحية هذا الجسد لخدمة الروح؛ نجد الأطباء ينظرون إلى المآلات وما توافر عندهم من القواعد العلمية المعروفة في المجال الطبي.

موقع الخلاف: الفقهاء ↔ الأطباء

الفقهاء: الموت هو **الموت الكلي لكافة أعضاء الجسم مجتمعة** ، بحيث إن بقاء أحد الأعضاء أو بعضها قائماً بوظيفته يخرج المريض عن وصف الميت ويثبت له صفة الحياة.

الأطباء: المخ هو **المحرك الرئيسي** لسائر الأعضاء، وأن **تلفه أو موته هو النهاية التي لا مفر منها** ، وأنه لا أمل في إصلاح هذا التلف.

دوافع إعلان الوفاة عند الأطباء: بما أن باقي الأعضاء تموت تدريجياً واحداً تلو الآخر، فليس هناك ما يمنع عندهم من إعلان الوفاة، تحقيقاً لمنافع **اقتصادية** كرفع أجهزة الإنعاش وتوفير التكاليف، أو منافع **معنوية** كإنهاء معاناة أهل المريض بمجرد إعلان الوفاة، وتقليل فترة حزنهم، أو تحقيق منافع **إنسانية** «على حد قولهم» كالحصول على الأعضاء في حالةٍ جيدة لزرعها في أجساد مرضى آخرين في حاجة ماسة إليها.

السؤال المحوري: وبالتالي بات واضحًا أن المشكلة هي **عدم التوافق بين المفهوم الشرعي والمفهوم الطبي** في هذه المسألة، مما أثار تساؤلاً مؤداه: هل الخلاف بين الفقهاء والأطباء يمكن رَأْبُ صَدْعِه عن طريق إمكانية الوصول إلى مفهوم توافقي فيما بينهما ينهي هذه المسألة؟

أضف إلى ذلك أن الخلاف الذي شب بين الفقهاء والأطباء يأخذنا إلى خلاف أكثر خطورة، وهو **تحديد لحظة الوفاة** ، إذ يترتب على تحديد تلك اللحظة الكثير من الأحكام، فهل يتم إعلان الوفاة رسمياً بمجرد موت الدماغ؟ أم أن الإعلان يتم بعد توقف سائر الأعضاء؟ وهذه النقطة أكثر خطورة؛ لأننا بحاجة ماسة إلى معرفتها، حتى يمكن ترتيب أحكام الموت عليها، إذ إننا نريد معرفة:

عدة الزوجة: الوقت الذي تبدأ فيه عدة الزوجة.

شروط الإرث: مسألة توافر شروط الإرث من عدمها، وهل يرث لو مات له وارث، وهل يرث منه الغير إذا حكمنا بموته.

حكم نقل الأعضاء: وهل يجوز شرعاً الحصول على أعضائه أم لا؟

كل هذه إشكالات لا بد من إيجاد حلول جذرية لها حتى تستقيم أحكامها الشرعية، لكل ذلك حاولت الوصول إلى القول الفصل في هذه المسألة من خلال هذا البحث الذي أسميته «**التكييف الشرعي لموت الدماغ وأثره في عمليات نقل الأعضاء: دراسة فقهية طبية مقارنة**».

وقد نظمت الحديث في هذه المسألة في مقدمة وثلاثة مباحث:

هيكل البحث

خطة البحث ومنهج معالجته

المبحث الأول: مفهوم موت الدماغ	المبحث الثاني: التكييف الشرعي لموت الدماغ	المبحث الثالث: حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ

المبحث الأول: مفهوم موت الدماغ

يعد تحديد مفهوم موت الدماغ **نقطة البدء** في هذا الموضوع، إذ بتوضيح مفهومه تظهر أوصافه، ويسهل بيان حكمه، وكما قال العلماء: **حقيقة الشيء فرع عن تصوره** . لذا أقوم في مطلب أول بتعريف الموت بصفة عامة، وأتبعه بتعريف الموت الدماغي وطرق تشخيصه في مطلب ثان.

المطلب الأول: تعريف الموت

لا يتخذ القرآن الكريم عند حديثه عن الموت موقفاً فلسفياً؛ بل **يعمل على بيان حقيقته** مضفيًا عليه الناحية التربوية، أي أن القرآن الكريم لا يهتم ببيان حقيقته، ولا بالكيفية التي يتم بها، بل يهتم **بالسبب الداعي إليه**، وما يأتي بعده من أمور تتعلق بالسؤال والحساب وغير ذلك.

وتقرر معظم الأديان والفلسفات الأدبية، أن الموت هو **خروج الروح من بدن الإنسان** ، ومغادرتها إلى حيث لا يعلم، وهذا المفهوم هو الذي ساد لدى الأمم القديمة، كقدماء المصريين والبابليين والآشوريين والهنود والإغريق، ويعتقد البوذيون أن الروح تظل حبيسة الجسد، وبالتحديد في **الجمجمة**، ولا تنطلق إلا بعد حرق الجثة وانفجار الجمجمة، أما الهنود فيعتقدون بـ**تناسخ الأرواح**، وأن الروح الشريرة تعاد في كل جسد حقير، كالكلب والخنزير، وتظل في تلك الدورات حتى تتطهر، وأن الروح الصالحة الخَيِّرَة تظل تتنقل في الأجساد الخيرة، حتى تصل إلى مرحلة السعادة الأبدية المطلقة في الروح الطليقة المتصلة بالأزل والأبد.

أ الموت في اللغة

الموت والحياة في لغة العرب متناقضان، لذا فإن معاجم اللغة العربية تُعَرّفُ كل واحدٍ منهما بأنه نقيض الآخر وضده، فعند تعريف الحياة يقال: الحياة نقيض الموت والحي من كل شيء نقيض الموت، والجمع أحياء، وعند تعريف الموت يقال: الموت والموتان ضد الحياة، وهو خلق من خلق الله تعالى، و **أصل الموت في لغة العرب السكون** ، وكل ما سكن فقد مات، ولذلك تقول العرب: ماتت النار موتاً إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء، وماتت الريح إذا ركدت وسكنت، وماتت الخمر أي سكن غليانها، والموت ما لا روح فيه.

يقول **ابن فارس**: «الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء ومنه الموت خلاف الحياة.».

وقد ورد الموت في القرآن الكريم بمعان متعددة، منها:

- **إزالة القوة الحية:** الموجودة في الكائنات قال ﷻ: «لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا»
- **زوال القوة الحساسة:** قال ﷻ: «وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا»
- **النوم الأبدي:** قال ﷻ: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»
- **موت الفكر:** قال ﷻ: «أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ»
- **المصيبة الكبرى:** ما يفقدك نعم الحياة قال ﷻ: «فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ»

ب الموت في الاصطلاح

الموت عند **جمهور أهل السنة**، صفة وجودية مضادة للحياة، وقالت **المعتزلة**: هو عدم الحياة عما شأنه، ويرون أن المراد بالخلق في قوله ﷻ: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» هو التقدير.

يقول **الغزالي**: «اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنوناً كاذبة قد أخطأوا فيها، فظن بعضهم أن الموت هو العدم، وأنه لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشر، وأن موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النبات، وهذا رأي الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولا يتألم بضار، ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر، وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلا، وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق، بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه **أن الموت معناه تغير حال فقط** ، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة.».

تعريف الموت عند المذاهب الفقهية الأربعة

المذهب	التعريف
الحنفية	هو صفة وجودية مضادة للحياة، وقيل هو عدم الحياة.
المالكية	الوفاة هي مفارقة الروح للجسد.
الشافعية	الموت مفارقة الروح الجسد.
الحنابلة	لم يعرفوا الموت اكتفاء بذكر علاماته.

الخلاصة: وبناءً على ما سبق فإن الموت الذي يصيب الإنسان هو **موت نسبي** ، أي موت بالنسبة لعلم البشر في حدود تكليفهم، فهو موت جزئي يقتصر على مفارقة الحياة الدنيا، ولا يمتد إلى حياة البرزخ، فالموت **انتقال** من دار معروف حقيقتها إلى دار وحياةٍ أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى.

يقول **القرطبي**: «قال ﷻ: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا»

«وهذا حض على الجهاد، وإعلام أن الموت لا بد منه، وأن كل إنسان مقتول أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله، وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي تفارق جسده».

تعريفات الأطباء للموت

التعريف الأول: هو التوقف النهائي لكل **مظاهر الحياة**، أو التفاعلات الحيوية بالجسم مع وجود بعض مظاهر الحياة عقب الموت العام، ولكن بالأنسجة والخلايا.

التعريف الثاني: انقطاع الحياة «سواء في الإنسان أو الحيوان» نتيجة توقف واحد أو أكثر من أجهزته الحيوية عن العمل.

ومن خلال ما سبق يمكن بيان ما يلي:

١ **إن الموت مخلوق كالحياة فليس فناءً محضاً** ، لذلك يجب على الإنسان ألا يخاف منه بالصورة التي تعكر عليه صفو حياته.

٢ **إن الله ذكر الموت أولاً قبل الحياة** ، فقال سبحانه: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» وهذا الترتيب الوارد في الآية وإن كان لفظياً، إلا أنه ينبيء عن الترتيب الطبيعي بين الموت والحياة، وهو ما يدعو إلى فهم جديد للآية، بمعنى أن ذكر الموت أولاً ومن بعده الحياة، يعد دليلاً على التغير والتطور، فالتغير عبارة عن موت مرحلة وبداية مرحلة أخرى.

٣ إن الحكمة من خلق الموت والحياة كما جاءت في القرآن الكريم هي **الابتلاء والاختبار**، فالموت والحياة في منطق القرآن ما خُلِقَا إلا لأجل الاختبار، وهذا الاختبار يجب أن يُحَوّل خوف الفرد من الموت كفناء إلى خوف تربوي له أثره في السلوك، كما ينبغي أن يخلق عنده روح المنافسة، فتتحول كل الطاقات إلى البناء لا إلى الهدم، كما أنه يجعل حياة الإنسان حقلاً للسعي والإنتاج.

٤ إن تعريفات الفقهاء اقتصرت على الإشارة إلى **العلاقة الكائنة بين الروح والجسد**، حيث انتهت إلى أن الموت هو مفارقة الروح للجسد، دون الإشارة إلى أية تفصيلات أو أمور أخرى، وهذه التفصيلات وإن كانت أمراً عادياً فيما مضى، إلا أنه صار لها أهمية كبيرة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال الطبي.

ج صعوبة وضع تعريف جامع للموت

يعد الموت هو نهاية الحياة الإنسانية وهو أمر لا يشك فيه عاقل مستقرئ للأحداث والوقائع، فما من حي إلا ويموت إلا الله عز وجل، وقد أخبر القرآن الكريم بهذه الحقيقة فقال ﷻ: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» ، إلا أن هذه المسألة ليست هي محل الجدل والنقاش، بل المسألة التي أثارت انتباه العلماء والباحثين هي **تحديد اللحظة التي يحكم فيها بموت الإنسان** .

ففي الماضي كان هذا الأمر سهلاً ميسوراً، إذ بمجرد خروج الروح وظهور علامات الموت المعروفة يحكم بالموت، ومن هذه اللحظة يصبح الشخص في عداد الأموات، أما في العصر

الحاضر وفي ظل التقدم في مجال العلوم الطبية وانتشار أجهزة الإنعاش الصناعي، وظهور المصطلحات الطبية الجديدة كـ**الموت الإكلينيكي**، و**موت الدماغ** وما إلى ذلك، صار من الصعب تحديد لحظة الوفاة، وبمعنى أدق تحديد اللحظة التي يحكم فيها بموت الشخص وجريان أحكام الموت عليه، ومما يزيد من صعوبة هذه المسألة **خلوها من النص الذي يبين حكمها** ، وهو على العكس تماماً مسألة بداية الحياة، حيث وردت فيها الأحاديث الصحيحة التي تبين بدايتها بطريق اليقين.

ويرى البعض أنه في ظل غياب النص الذي يحدد نهاية الحياة الإنسانية، فإنه ينبغي عند تحديد هذا الوقت الانطلاق من قاعدتين أساسيتين:

⇄ **القاعدة الأولى:** إن الأمر بين تحديد البدء وتحديد الانتهاء ينبغي أن يكون **عكسياً أو متناقضاً** ، بمعنى أن حياة الإنسان تنتهي عكس ما بدأت به، فإذا كانت البداية هي تعلق الروح بالبدن، فالمنطق أن تنتهي الحياة بانقطاع هذا التعلق.

القاعدة الثانية: إن الروح خلق من خلق الله عز وجل يمكن للإنسان البحث فيه من حيث **خصائصه وصفاته وأنشطته وآثاره** في البداية وتأثره فيه، ووقت تعلقه به ومفارقته له.

فالقاعدة الأولى هي نتيجة منطقية تنطلق من **قاعدة السببية** التي تحكم هذا الوجود، والتي تقضي بأن كل شيء جعله الله متوقفاً على سبب لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يقوم أو يحيا في حالة مفارقة هذا السبب، وبما أن الله عز وجل جعل لبداية الحياة سبباً، هو **تعلق الروح** بالجسد، فإن النهاية حتماً تكون بالافتراق، وإذا كان علماء الإسلام لم يحددوا اللحظة التي تتم فيها تلك المفارقة فإنهم أكدوا أن **ملازمة الروح للجسد مرهونة بصلاحية هذا الجسد لخدمة الروح** ، وتنفيذ أوامرها، وبالتالي إذا صار الجسد عاجزاً عن خدمة الروح والقيام بالوظائف المنوطة به، كان ذلك سبباً داعياً للافتراق.

٢ المطلب الثاني: تعريف موت الدماغ وطرق تشخيصه

تجدر الإشارة إلى أن هناك **تناقضاً واضحاً** في تحديد المفهوم العلمي لموت الدماغ، حيث يختلف تعريفه من بلد لآخر في البلدان التي تعترف به وتقره، فيختلف التعريف على سبيل المثال بين أمريكا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، بل إن هناك العديد من البلدان لا تعترف من حيث الأصل بفكرة الموت الدماغي كاليابان والدانمارك، بل الأغرب من ذلك، أن التعريف قد يختلف في البلد الواحد، نظراً لاختلاف المعايير المتبعة والتي يتم الأخذ بها، ففي

أمريكا «مثلاً» توجد تشريعات مختلفة في ولاياتها، وبالتالي من الطبيعي أن يختلف التعريف وبناءً عليه تختلف طرق التشخيص.

ويقرر الأطباء المختصون أن المريض في غرفة الإنعاش لا يخلو حاله من إحدى ثلاث صور:

الصورة	الحالة السريرية	قرار الطبيب
الأولى «العودة»	عودة أجهزة المريض من التنفس وانتظام ضربات القلب وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.	**رفع أجهزة الإنعاش** لتحقق السلامة وزوال الخطر.
الثانية «التوقف التام»	التوقف التام للقلب والتنفس وعدم القابلية لآلة الطبيب.	**موت المريض تماماً** بموت أجهزته من الدماغ والقلب، ومفارقة الحياة لهما، الأمر الذي يستتبع رفع الأجهزة لثبوت تحقق الوفاة لديه.
الثالثة «موت جذع الدماغ»	قيام علامات موت الدماغ من الإغماء وعدم الحركة، وعدم أي نشاط كهربائي في رسم المخ بآلة الطبيب، لكن بواسطة العناية المركزة وقيام أجهزتها عليه كجهاز التنفس وجهاز ذبذبات القلب، ولا يزال القلب ينبض والنفس مستمر.	موت المريض بموت جذع الدماغ الذي هو **مركز الإمداد** للقلب، وبمجرد رفع الآلة عن المريض بتوقف القلب والتنفس تماماً.

أولاً مفهوم موت الدماغ

تباينت الرؤى واختلفت الاتجاهات في تحديد مفهوم موت الدماغ، وانبثقت كل رؤية من المنهج الذي ينتهجه أصحابها، وقد عُرف موت الدماغ بتعريفات متعددة، أهمها:

١ عرف بأنه: « **تلف دائم** في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه، بما فيها وظائف **جذع الدماغ**».

٢ قيل في تعريفه: إنه **غياب الآداء السريري للدماغ غياباً لا يقبل الانعكاس** ، بما في ذلك جذع الدماغ، وينتج موت الدماغ من الأمراض العصبية الأساسية بسبب جرح حادٍ في الرأس، أو نزيف فيما تحت الغشاء العنكبوتي نتيجة تمدد الأوعية الدموية، لكن في وحدات العناية المركزة العلاجية والجراحية يمكن لإصابات الدماغ بسبب نقص الأكسجين وفقر الدم، أو الفشل المفاجئ أن تؤدي إلى غياب آداء المخ غياباً لا يقبل الانعكاس.

MIARA 01054058478

ثلاثة عوامل للموت عند الطب الشرعي: ويقرر الطب الشرعي أن حالات الموت تحدث فيها ثلاثة عوامل تتمثل في: توقف **الدورة الدموية**، توقف **التنفس**، توقف **الجهاز العصبي ونشاط الدماغ**.

التغيرات التي تحدث تدريجياً بالموت

ومع التسليم بهذه الحقيقة، إلا أن هناك مجموعة من المتغيرات تحدث تدريجياً بالموت وهي **التلون الموتى، وبرودة الجسم، والتيبس الموتى، والتحلل الموتى** .

تفصيل التيبس الموتى: والتيبس الموتى هو تصلب العضلات الإرادية واللا إرادية بعد الموت بفترة وجيزة، ويبدأ هذا التيبس تدريجياً في العضلات الصغيرة حول **الفك السفلي والرقبة** ثم عضلات الوجه وجفون العين ثم يمتد تدريجيًا إلى عضلات الصدر والبطن والعضدين والفخدين ثم عضلات الساعدين والساقين، ثم عضلات الكفين والقدمين، ويحدث التيبس في العادة في **فترة تتراوح بين ساعتين إلى ثنتي عشرة ساعة** ويحدث التحلل خلال **أربع وعشرين ساعة**.

قاعدة طبية سليمة: ومن الطبيعي أنه إذا لم تحدث تغيرات ما بعد الموت في الجسد، فإن هذا الجسد **ما يزال حياً**، ولذلك فإن الرأي الطبي السليم يقرر أنه **إذا لم نستطع أن نقطع بزوال علامات الحياة، فإننا لا نحكم بالموت إلا بعد ظهور تغيرات ما بعد الموت على الجسد** ، بل إن هذه التغيرات على درجة من الثبات والتدرج الزمني المعروف، حتى أنها تستخدم لتحديد الفترة الزمنية التي مضت بعد حدوث الموت أي أنها تستخدم **لتحديد ساعات الموت**.

أسباب موت الدماغ

يلخص الدكتور **محمد علي البار** الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث ما يسمى بموت الدماغ فيما يلي:

السبب	النسبة	ملاحظات
إصابات الدماغ بسبب الحوادث	**٥٠٪ من جميع حالات موت الدماغ**	أهمها حوادث المرور — وفي السعودية تمثل ٦٠٪ من جميع وفيات الدماغ
نزف داخلي بالدماغ	٢٠٪ من جميع حالات موت الدماغ	بمختلف أسبابه
أورام والتهابات الدماغ	٣٠٪ من حالات موت الدماغ	أورام الدماغ والتهاباته وخراج الدماغ والسحايا

إحصائية لافتة: وتعتبر حوادث المرور في منطقة الخليج العربي صاحبة الرقم الأعلى في العالم، حيث تبلغ النسبة عشرة أضعاف ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالنسبة لكل مائة ألف من السكان، وفي عام ١٩٩٤م توفي في السعودية ما يزيد على ٣٧٠٠ شخص منهم ٧٥٪ لم تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً، كما أُصيب في حوادث المرور إصابات بالغة أدت إلى دخول المستشفى أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص كل عام.

أهمية التشخيص المبكر لموت الدماغ وطرقه

يعتبر التشخيص المبكر لموت الدماغ «عند القائلين به» من المسائل الهامة والشديدة الخطورة، ويلجأ الأطباء في تشخيص الموت عموماً إلى إحدى طريقتين:

الطريقة	التعريف
الأولى – «التشخيص السلبي»	تتمثل في البحث عن **مظاهر الحياة** للتأكد من زوالها.
الثانية – «التشخيص الإيجابي»	هي البحث عن **علامات التغيرات** التي تصيب الجسد بعد الموت للتأكد من ظهورها.

والطريقة الأولى تثبت فور حدوث الموت، أما الطريقة الثانية فإنها لا تثبت إلا بعد مرور ساعات من حدوثه، ولا عتباراتٍ كثيرة يكون من الأفضل إثبات الموت فور حدوثه، فيلجأ الأطباء إلى الطريقة الأولى والتي تعتمد على زوال مظاهر الحياة، و **ينبغي على الطبيب قبل الحكم بالموت التأكد من زوال جميع علامات الحياة** ، وإذا التبس عليه الأمر في التشخيص السلبي للموت وجب عليه انتظار التشخيص الإيجابي بظهور التغيرات المعروف حدوثها بعد الموت، ولكن هذا الالتباس يعد من الأمور **النادرة الحدوث**.

ويتم تشخيص موت الدماغ وفق ما يلي:

١. **غيبوبة عميقة** مع انعدام الإدراك والاستجابة.

٢. **العلامات السريرية (الإكلينيكية)** لتوقف وظائف جذع الدماغ، وتشتمل على غياب منعكسات الحدقة والقرنية، واختلاف المنعكس الرأسي العيني، والمنعكس العيني الدهليزي البلعومي، ومنعكس السعال والتقيؤ.

٣ **انعدام قدرة المصاب على التنفس التلقائي**، بالاختبار المتعمد أثناء توقف مضخة التنفس لفترة محدودة، وهي عدم التنفس لمدة ثلاث أو أربع دقائق، أو عشر دقائق حسب المدارس المختلفة بعد إبعاد المنفسة، ويشترط لإيقاف المنفسة أن يتنفس المصاب أوكسجين ٩٥% مع ٥% ثاني أكسيد الكربون لمدة عشر دقائق بواسطة قسطرة يتم إدخالها إلى القصبة الهوائية ويتم التنفس بواسطة المنفسة؛ وذلك يؤدي إلى رفع ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى ٤٠ مم زئبق أو فوقها، وهو مسؤول عن تنبيه مركز التنفس في جذع المخ.

٤ **عدم وجود حركة الدمية** عند تحريك الرأس، وإعادة فحص وظائف الدماغ من فريق آخر بعد مرور عدة ساعات.

٥ لا يعتبر **رسم الدماغ** أساسياً في تشخيص موت الدماغ، إلا أنه قد يكون دليلاً إضافياً مفيداً من الناحية القانونية.

وعموما فإن الغالب أن تشخيص موت الدماغ يعد عملاً **سريريًا** بالدرجة الأولى، إلا أن الطبيب في سبيل التأكد من هذا التشخيص يلجأ إلى إجراء مجموعة من الاختبارات المساعدة، وذلك بعد التأكد من وجود الترابط بين الغيبوبة المصحوبة بانقطاع التنفس وانعدام الانعكاس العصبي، وتكون أمامه أربع خيارات:

- **الأول:** أن يقوم بالانتظار لمدة **اثنتي عشرة ساعة**.
- **الثاني: سكون في كهرباء قشرة الدماغ** كما يظهر في رسم المخ.
- **الثالث:** خطوة نحو **إلغاء إمكانات جذع الدماغ السمعية المثارة** في سلسلة اختبارات متتابعة.
- **الرابع:** إظهار مؤقت **دورة الدم داخل المخ** عن طريق رسم للأوعية، أو رسم صوتي.

المعايير العالمية: وقد وُضِعَتْ العديد من المعايير في بعض دول العالم لمحاولة وضع قواعد يتم الاستهداء بها عند تشخيص موت الدماغ، ومن أهم المعايير التي وضعت في هذا الشأن، **معايير هارفارد**، و**معايير مينيسوتا**، و**معايير الجمعية الطبية الكندية**.

MARA 01105405478

تعد مسألة موت الدماغ من نوازل العصر التي تتطلب حكمًا شرعيًا يقطع الخلاف الدائر حولها، والتكييف الشرعي لهذه المسألة أحد أمرين:

- إما القول بأنه يعتبر موتًا، وبالتالي تترتب عليه جميع آثار الموت المقررة فقهياً.
- وإما القول بعكس ذلك وبالتالي لا يتم إعلان الوفاة ولا يدخل في عداد الأموات.

والوصول إلى تكييف محدد في هذه النازلة ليس بالأمر اليسير؛ بل يتطلب بحثًا دقيقًا في أحكام الموت وعلاماته من الناحية الشرعية، ومقارنة ذلك بما قرره الأطباء، مع مراعاة القواعد العامة في الشريعة، ومحاولة التوفيق بين أقوال الفقهاء وما قرره الأطباء.

1 تحرير محل النزاع

الاتفاق	موضع الخلاف
اتفق الفقهاء والأطباء على أن الموت يتحقق بمفارقة الروح للجسد مع توقف القلب والنبض والتنفس، وتترتب عليه أحكامه. واتفقوا كذلك على أن الغيبوبة وتوقف الدماغ وحدهما لا يُحكم بهما بالموت ؛ لأن معظم حالاتهما قابلة للعلاج.	مع الاتفاق على ما تقدم إلا أنهم اختلفوا فيما إذا تم تشخيص المريض على أنه **ميت دماغيًا** وفق الأصول العلمية، إلا أن قلبه لا يزال ينبض، ويتنفس بأجهزة التنفس الصناعي — فهل بموت دماغه فقط يعتبر ميتًا تجري عليه أحكام الموتى، أم لا بد من توقف التنفس والنبض والقلب؟ وبمعنى أدق: هل **موت الدماغ يعتبر موتًا بالمعنى المعروف أم لا** ؟

خريطة الخلاف – نظرة إجمالية

الرأي	بيان الرأي وأبرز القائلين
الأول – لا يعتبر موتًا حقيقيًا	يرى أنصاره أن موت الدماغ **لا يعتبر موتًا حقيقيًا** ، ولا بد من **توقف عمل جميع أعضاء الجسم**، وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الحياة. وأبرز القائلين به: **بكر أبو زيد**، و**جاد الحق علي جاد الحق**، و**محمد سعيد البوطي**، و**محمد الشنقيطي**. تبنّاه: **المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي**، و**لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية**.
الثاني – يعتبر موتًا حقيقيًا	يرى أنصاره أن موت الدماغ **يعتبر موتًا حقيقيًا** ، وتترتب عليه أحكام الموت. وأبرز القائلين به: **أغلب الأطباء**، وبعض الفقهاء المعاصرين وبعض القانونيين.

تبنّاه: **مجمع الفقه الإسلامي الدولي** في مؤتمره الثالث المنعقد بعمّان عام ١٤٠٧هـ.

أدلة الرأي الأول – القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا

استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا بـ **الكتاب** و **السنة** و **القواعد الفقهية** و **المعقول** .

1 الدليل الأول من الكتاب – قصة أصحاب الكهف

الآيات الكريمات: قال ﷻ: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾»

وجه الدلالة: تعد قصة أصحاب الكهف من أعجب القصص في القرآن الكريم، وقد اختلف في سبب إيواء الفتية إلى الكهف على قولين:

- **الأول:** قيل إنهم هربوا بدينهم إلى الكهف، وهو ما يفسره قوله ﷻ: «فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾»
- **الثاني:** أنهم كانوا أبناء عظماء وأشراف، خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد، فقال أسنهم: أجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده، إن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذًا شططًا، ثم دخلوا الكهف ليختبئوا فيه، وظلوا فيه ثلاثمائة سنة وتسعًا.

وقد استدل بهذه الآية القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا، حيث إن أصحاب الكهف طيلة هذه المدة الطويلة لم يكونوا في عداد الأموات؛ بدليل أن الله ﷻ لم يصفهم بالموت، بل إنه أفقدهم القدرة فقط بدلالة قوله ﷻ: «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾» والضرب على الآذان هو المنع من الاستماع، فكان دليلًا على أنهم لم يموتوا.

يقول **د. توفيق الواعي**: «أجمع الفقهاء والمفسرون على أن كلمة «بعثناهم» معناها أيقظناهم؛ لأن أجسامهم كانت حية، وفيها الحياة ولم تفقدها، بدليل قول الله ﷻ بعد ذلك: «وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾» ».

وبالتالي ففقد المريض الإحساس بالشعور لا يُدْخِلُه في عداد الأموات ما دامت الأعضاء الأساسية لا زالت تعمل، ويترتب على ذلك أن **موت الدماغ لا يعد موتًا بالمعنى الحقيقي لكلمة موت** ، إذ إن أعضاءه لا زالت تعمل، كما هو الحال في قصة أصحاب الكهف، وإذا كان الله ﷻ لم يحكم بموتهم ولم يصفهم بالموت، فكذلك موتى الدماغ.

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأنه مبني على أن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس، وهو أمر لم يقل به أحد؛ بل هو تعطيل لمركز الأوامر الحياتية في الإنسان، بما لا يبقى معه حياة بعد رفع أجهزة الإنعاش، فإن الأطباء مجمعون على أنه لا أمل في إعادة حياة من ثبت تشخيص موت دماغه؛ لاعتبار ارتباط أسباب الحياة فيه. أضف إلى ذلك أن ما حدث مع أصحاب الكهف ليس موتًا بل **نوم عادي** طالت مدته ولا شيء فيه من الموت أو الإغماء.

الجواب: يُجاب بأننا لم نقل إن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس، ولم يكن هذا هو الفارق بين موت الدماغ وبين الحالة التي كان عليها أصحاب الكهف، بل إن وجه الشبه بينهما هو **بقاء الأعضاء حية** ، وما دام أصحاب الكهف أحياء لبقاء صفة الحياة في الأعضاء، فكذلك الميت دماغيًا لوجود ذات العلة فيه.

2 الدليل الثاني من السنة – حديثان

الحديث الأول – حديث عمرو بن تميم: ما رواه الطبراني عن عمرو بن تميم بن عويم، عن أبيه عن جده، قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ فيها بالدية، وفي جنينها بغرة عبد أو وليدة، فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطر ولا استهل؟ فمثل هذا يطل، فقال رسول الله ﷺ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ»

الحديث الثاني – حديث أبي هريرة: ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

وجه الدلالة: استدل القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا بالحديث من وجوه:

- **الأول:** إن النبي ﷺ قضى بالدية على الجاني، والجنين الذي في بطن الأم لم تكتمل له كل مظاهر الحياة وعلاماتها، بل منها ما ظهر، ومنها ما كان في طور الظهور، أي أنه جعل مناط الحكم مطلق العدوان على كل ما يسمى جنينًا، وقد حدد الفقهاء أقل ما يكون به ما في البطن جنينًا، فقال المزني: «أقل ما يكون به جنينًا، أن يفارق المضغة والعلقة، حتى يتبين شيء من خلق آدمي من أصبع أو ظفر أو عين وما أشبه ذلك».
- **الثاني:** إن قضاء النبي ﷺ بذلك يدل بمفهوم المخالفة على اشتراط موت جميع الأعضاء للحكم بالموت؛ حيث أثبت الحياة له لثبوت حياة بعض الأعضاء دون البعض الآخر، والميت دماغيًا باتفاق الجميع ما زالت الحياة سارية في بعض أعضائه، بل إن هناك تشابهًا واضحًا بين الجنين والميت دماغيًا في أمارات الحياة الظاهرة على كل منهما، وهي التنفس والنبض واستمرار النمو، فكان الميت دماغيًا بناءً على ذلك حيًا، ولا يجوز الاعتداء عليه.

3 الدليل الثالث – علامات الموت عند الفقهاء

إن الفقهاء عند بيانهم لحقيقة الموت حددوا جملة من **العلامات** لإصدار الحكم على الشخص بالموت، وهذه العلامات هي:

1. **استرخاء القدمين:** حيث تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل.
2. **اعوجاج المنخر:** أو ميل أنفه؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة بالإنسان، فإذا مات ارتخى.
3. **انخساف الصدغين:** لأن اللحيين ينطلقان فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفًا.
4. **امتداد جلدة الوجه:** وامتدادها من علامات الموت.
5. **تدلي جلدة الخصية:** من علامات الموت.

حديث طلحة بن البراء: وقد اعتبر النبي ﷺ هذه العلامات، وحكم بقرب حدوث الموت بناءً عليها، فقد أخرج أبو داود عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده،

فقال: «إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ»

والعلامات التي ذكرها الفقهاء تعني **موت جميع الأعضاء**، وعدم بقاء الحياة فيها كلية، لذا فإن موت الدماغ الذي يقول به الأطباء **لا يعتبر موتًا بالمعنى المعروف لدى الفقهاء**، لبقاء أجزاء الحياة في الجسد، ولعدم ظهور علامات الموت المؤكدة، وبالتالي يجب الاعتبار بتلك العلامات، وليس هناك ما يمنع من اعتبار كلام الأطباء والأخذ به، فهم أهل الخبرة والاختصاص، شريطة ألا يكون مخالفًا لما قاله الفقهاء، وما اعتبروه عندهم.

4 الدليل الرابع – قاعدة سد الذرائع

استدلوا على قولهم بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا بقاعدة **سد الذرائع**، والتي تعني حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها، وقيل: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور، فهي بناءً على ذلك سد جميع الطرق الموصلة للمحرمات. وإعمال قاعدة سد الذرائع في مسألتنا يتحقق من عدة وجوه:

الوجه الأول: إن الاعتراف بهذا المفهوم يتيح أجسادًا للبحث العلمي أقرب ما تكون إلى الحياة، وبالتالي تكون نتائج البحوث أكثر دلالة، ويستفيد منها آخرون، وهذا يعني أن هذه الأجساد ليست ميتة، الأمر الذي يكون عائقًا أمام التقدم في وسائل علاجهم، إذ من المعروف أن كل داء لا بد له من دواء، غاية الأمر أن الدواء لم يتم اكتشافه بعد، واحتمال إيجاد دواء لمرضى موت الدماغ أمر ليس بالمستحيل. ووفقًا لما قاله الأطباء، فإنه في حالات إصابة الرأس — التي تعتبر سببًا رئيسًا لموت الدماغ — يتضرر المخ، فيؤدي إلى إعاقة جزئية لإمدادات الدم للمخ، ونتيجةً لذلك فإن الخلايا العصبية لمركز التنفس تصبح خامدة، ثم تموت بعد ذلك، كما أن مرحلة التغيرات الوظيفية **قابلة للعلاج**، وقد قال أحد الأطباء مؤكدًا ذلك: «إن التغيرات الوظيفية تخضع لمحاولات العلاج حتى في الوقت الحالي، وأن العلاج الدوائي في المستقبل قد يظهر أن جذع المخ الذي انعدمت وظائفه لم يدمر بطريقة لا يمكن إصلاحها؛ ولكن فقط تعطل تعطلاً مؤقتًا».

الوجه الثاني: إن قبول التعريف الجديد للموت قد يكون عاملاً أساسيًا في **فقدان الجمهور الثقة في الأطباء**؛ لأن المعلوم لدى الجميع أن الأطباء رحمة من الله، وسبب من أسباب جلب الشفاء، فإذا تغير المفهوم المتأصل لدى الناس حيث يتحول الرحمة إلى مجرد المتاجرة بالأجساد، فإن ذلك تكون له أضراره الكبيرة، وبالتالي فضرر قبول هذا المفهوم للموت على الأطباء أكثر من غيرهم.

الوجه الثالث: إن تعريف الموت بناءً على مفهوم غامض أدى إلى ظهور **معايير مختلفة للتشخيص** من بلد لآخر، بل من مستشفى لآخر في نفس البلد، فيصبح المرء ميتًا في إحدى المستشفيات، فإذا انتقل إلى مستشفى آخر صار حيًا، وهذا الأمر يعكس عدم مصداقية المفهوم، والتعجل في التطبيق الذي لا يستفيد منه المريض، كما أنه يتعارض مع مبدأ مسئولية الطبيب عن مريضه.

5 الدليل الخامس – الاستصحاب

استدلوا بـ **الاستصحاب** باعتباره دليلًا من الأدلة الشرعية، ومعناه: **بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل** . ووجه الاستصحاب في مسألتنا أننا أمام أمرين: أحدهما ثابت لا خفاء فيه، والآخر مدعى، فالحياة ثابتة والموت مُخْتَلَف في حدوثه ومشكوك فيه، وإعمالاً لهذه القاعدة ينبغي الحكم بالحياة للمريض، حتى يقوم الدليل على انتهاء حياته ودخوله في عداد الأموات.

المناقشة: يناقش هذا الاستدلال بأن الحياة وإن كانت ثابتةً باعتبارها الأصل، فإن الموت قد طرأ، وقد قامت عليه الأدلة مما ذكره الأطباء بعد الفحص، وكذلك استخدام أجهزة رسم المخ وما توصلوا إليه من خلال دراساتهم وبحوثهم.

الجواب: يُجاب بأن الأدلة التي ذكرها المجيزون لاعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا لا تنهض من حيث قوتها على إثبات العكس؛ حيث إن هذه الأدلة تبناها المجيزون من الأطباء، في حين رفضها البعض الآخر، وأقاموا الأدلة على عدم القطع بصحة ما تؤدي إليه، وبالتالي فالدليل الطارئ ليس في قوة الدليل الأصلي، وبذلك تنعدم المخالفة.

6 الدليل السادس – مظاهر الحياة في موتى الدماغ

إن الأطباء قرروا أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم على أنهم موتى دماغ، تتوافر فيهم **علامات الحياة** ، وهذه العلامات هي:

استمرار الأفعال المنعكسة: من سعال وقيء، وهذا أمر يحدث كثيرًا لدرجة أن اثنين من الأطباء المتحمسين لموت الدماغ وهما د. بيتس *PITS* ود. كارونا *CARONNA* أكدا أن هذه الأفعال يجب ألا تلغي تشخيص موت الدماغ.

النشاط العصبي العضلي: والارتعاشات العضلية، والحركات المعقدة للأعضاء والجذوع: كثني الذراعين عند المرفقين وإبعادهما عن مكانهما الأصلي، ورفعهما عن الطاولة، وتحريك اليدين إلى الصدر.

الاستجابة المنعكسة الدموية: على شكل ارتفاع في معدل النبض وفي ضغط الدم، وهذه الأعراض تحدث عادةً استجابة للتحدي في حالة الاختناق والاستجابة للمثير الجراحي خلال حصد الأعضاء.

المحافظة على حرارة الجسم: حيث إن الشخص المتوفى دماغيًا يمكن أن يظل جسمه محتفظًا بحرارته خلال المدى المعتاد، مما يشير بوضوح إلى وجود نشاط، كذلك يمكن أن يرتفع ضغط الدم، وتتكاثر كريات الدم البيضاء.

الحياة الخاملة: يظل الشخص الميت دماغيًا محتفظًا بما يسمى بالحياة الخاملة، بمعنى أن أظافره وشعره يستمران في النمو، وجهازه المعوي يمكن أن يهضم الطعام ويمتصه.

يقول **د. أحمد الشواربي — أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة عين شمس**: «إنه من الثابت في كل المراجع الطبية، أن حالات موت المخ يكون أصحابها أحياء، تظهر فيهم مظاهر الحياة المختلفة، رغم توقف بعض وظائف المخ، حيث ينبض القلب نبضًا عاديًا، ويحتفظ الجسم بحرارته الطبيعية، وتظل إفرازات معظم أجهزة الجسم على طبيعتها، ويستمر التمثيل الغذائي للكبد، وعمل الكليتين، ويحتفظ الجسم بالكثير من الأفعال الانعكاسية الإرادية، كما يستمر شعره وأظافره في النمو، وأن الحمل في حالة السيدات الحوامل اللاتي تم تشخيصهن بموت المخ يستمر طبيعيًا طوال فترة الغيبوبة، حتى تتم الولادة في موعدها الطبيعي، وهو ما تم تسجيله علميًا ونشر بالمجلات والصحف في عشرات المرات في السنوات الأخيرة، وإن هذه الدلائل كلها تقطع باستمرار الحياة في هذه الأجساد، ومن ثم فإن تدخل الطبيب بإنهاء حياة هؤلاء، إنما هو **قتل النفس التي حرم الله قتلها** ».

المناقشة:

- **المناقشة الأولى:** إن وجود هذه الانعكاسات لا يعني نفي موت الدماغ، وله شبيه في الطب كالميت الذي يتحرك بمجرد تعرض الجثة للصعق الكهربائي، حيث إن هذا الميت لا يمكن القول بأنه حي، بل كل ما في الأمر أن الصدمة الكهربية أحدثت تنبيهًا للجهاز المركزي العصبي لدرجة أنه يتحرك، بل يجلس ويرجع إلى وضعه مرةً أخرى، فليس معنى أنه يحرك يديه أن نستبعد موت الدماغ.
- **المناقشة الثانية:** إن بقاء عضو من الأعضاء على قيد الحياة أو في حالة قابلية للحياة، لا يتعارض مع موت صاحبه؛ فالقلب العضوي يمكن أن يستمر في العمل خارج الجسد منفصلًا عن

صاحبه لساعات عديدة، إذا ما تم توفير الغذاء والحرارة المناسبة له، وهو في هذه المرحلة يكون صاحبه قد مات ودفن، وكذلك كثير من أعضاء الجسد، ولذلك لا يمكن الاستدلال بحياة عضو من الأعضاء على حياة صاحب العضو أو موته.

الجواب: يُجاب عما سبق بأن استمرار عمل الأجهزة المختلفة في الجسم كالقلب والكبد والجهاز الهضمي والكليتين، وإفراز الهرمونات والاحتفاظ بدرجة الحرارة، كلها تعد أدلة قاطعةً على **الاستمرار في الحياة** لهؤلاء المرضى، إذ لا يمكن أن يوصف المريض الذي تعمل فيه كل هذه الأجهزة بأنه ميت. وفرنسا التي تعتبر من أفضل الدول في هذا المجال، لم تحكم على هذا الشخص بأنه ميت بل إنهم أسموه بـ **الميت الحي** ، وقالوا في تفسيرهم لهذا المصطلح: إنه حي لأن أعضاءه حية، وأنه ميت حسب الوجهة القانونية، وفقًا للقانون الفرنسي، لأنه فقد الاتصال بالآخرين.

7 الدليل السابع – القلب ينبض والدورة الدموية تعمل

إن المحكوم عليه بالموت بناءً على الاعتراف بموت الدماغ لا يزال **قلبه ينبض** ، ودورته الدموية تعمل، وهذا أعظم دليل على استقرار الحياة في الجسد، إذ الإنسان لا يعتبر ميتًا بتوقف الحياة في بعض أجزائه؛ بل يعتبر ميتًا بـ **الموت الكلي لجميع الأعضاء** ، فلا تبقى في الجسد حياة. أضف إلى ذلك أن هناك اتفاقًا بين علماء الشرع وعلماء الطب على طبيعة العلاقة بين الروح والجسد، وأن الروح متصلة بالجسد اتصالًا وثيقًا، وأن علامة صلاحية الدماغ هو مكان الإدراك، وأن الروح تدرك المدركات باستعمال الدماغ، وأنها تتصرف بالأعضاء بواسطة الدماغ، وأن علامة مفارقة الروح للجسد هي موت الدماغ بصورة نهائية، وأن الحركة الاضطرارية لا تدل على حياة أو موت الإنسان، وأن حياة الخلايا الجسدية تميز حياة الروح، وإمكان اتصالهما وانفصالهما.

يقول **د. توفيق الواعي**: «إن تعطل الإنسان لا يدل على فقد الحياة، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز أو التشبيه، فلا يقول عاقل مثلًا أن النائم ميت، ولا يقول إن المجنون فاقد للحياة، كما لا يقال ذلك لناقص الأهلية كالصبي غير المميز، ولا يقال إن هؤلاء يعاملون معاملة الأموات، كما لا يقال إن المريض حين يكون في غيبوبة تحت أي ظرف يعامل معاملة الأموات إلا إذا كان الموت والحياة أصبحا بيد البشر، وحاشا لله أن أحدًا ذلك يدعي.».

8 الدليل الثامن – جهاز رسم المخ

إن الاعتماد على **جهاز رسم المخ** كليةً للوصول إلى اليقين والقطع أمر غير مقبول؛ لأن الوقائع تكذب نتائج هذا الجهاز، ويدل على ذلك ما يلي:

- **الحالة الأولى:** بعض المرضى الذين تعرضوا لاختبارات رسم المخ، وَحُكم عليهم بأنهم موتى لما أراد الأطباء نزع أعضائهم، ظهرت عليهم **علامات الحياة الطبيعية** ، الأمر الذي جعلهم يوقفون هذا العمل، متجهين إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإفاقة.
- **الحالة الثانية:** بعض المرضى الذين اعتبروا موتى بموجب نتائج هذا الجهاز ظهرت عليهم علامات تؤكد أنهم على قيد الحياة، ومن هذه العلامات: الكحة والاستعداد للقيء عند إدخال شيء في الفم. النشاط العضلي والعصبي وانقباضات العضلات، وتحرك الأطراف. ثني الذراعين ومحاولة القيام من فوق منضدة العمليات وضم اليدين إلى الصدر. تغير النبض، وضغط الدم أثناء عملية نزع الأعضاء مثلما يحدث تمامًا للشخص العادي.

9 الدليل التاسع – الميت الجديد

إن القائلين بفكرة موت الدماغ — بالرغم من اعترافهم أن المخ هو أهم أعضاء الجسم — إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان موت المخ موتًا لسائر الجسم أم لا، فيقترح **جايلين** أن يطلق على الشخص الذي مات مخه اسم **الميت الجديد** ليميز بذلك الجسم الذي يتنفس صناعيًا عن الجسم الميت موتًا حقيقيًا، وجاء اقتراحه لهذا الاسم لأنه أكثر قبولًا عند الناس من وجهة نظره.

أضف إلى ذلك أن البلاد التي تم فيها قبول فكرة الموت الجديد، كان المرضى والأطباء فيها **غير متأكدين** من صلاحية استخدام معايير موت المخ لإعلان وفاة الشخص، وكأنهم قبلوا أن المخ قد مات، إلا أنهم ترددوا في مدى كفاية ذلك للقول بموت الإنسان. وفي مجال إجراء البحوث على مرضى موت الدماغ اعترف الباحثون أن الميت الجديد **يشبه الشخص الحي أكثر من شبهه بالشخص الميت** ، لدرجة أن هذا أثار التساؤل عما إذا كان الميت الجديد يعتبر ميتًا أم لا.

10 الدليل العاشر – قابلية إثبات العكس

إن الأطباء يقررون أن وفاة الإنسان تتحقق بتوقف خلايا المخ عن أداء وظيفتها، إذ يستحيل بحسب الحالة الراهنة للعلم عودتها للحياة، إلا أن هذه القواعد التي ذكرها الأطباء **قابلة**

لإثبات العكس ، وذلك بالكشف عن علاجات في المستقبل، والتطور العلمي أكبر شاهد على ذلك، فهناك العديد من الأمراض مات بسببها الكثير من الناس، حيث لم تكن قد اكتشفت لها العلاجات، أما الآن فقد تم الكشف عن تلك العلاجات.

وفي وقت ليس بالبعيد اعتبر توقف القلب سببًا من أسباب الوفاة، إلى أن تم اكتشاف أساليب العلاج عن طريق وسائل إنعاش القلب، أو غيرها، وبالتالي فالحكم بالموت بناءً على عدم وجود أدوية أو علاجات أمر لا يمكن قبوله.

أضف إلى ذلك أن الاختبارات التي يبنى عليها تشخيص موت المخ، كلها اختبارات للكشف عن غياب أنشطة المخ، ولا تعتبر كاشفة عن موت المخ، إلا أن مفهوم موت المخ مبني أساسًا على أن تغيرات معينة حدثت بالمخ أدت إلى تورمه لزيادة كمية السائل المحتجز به، وأدى هذا التورم إلى زيادة الضغط داخل الصندوق العظمي للجمجمة إلى درجة أوقفت الدورة الدموية للمخ، فأصبح المخ معطلًا وبلا دورة دموية، أي ميتًا، وحدثت به التغيرات المتوقعة لانقطاع الدورة الدموية.

١١ الدليل الحادي عشر – فترة الاحتضار

أقر الأطباء أن هناك فترةً لا تقل عن أربع دقائق بين توقف القلب والتنفس وبين تشخيص الموت الإكلينيكي، وخلال هذه الفترة تكون أغلب الأعضاء حية وقابلة للاستمرار في العمل إذا ما تم إنعاشها بتوفير المحيط الملائم لها من تغذية وتصريف للفضلات، وخلايا المخ في هذه الفترة تكون حية.

ولو تم إسعاف هذا الشخص بتدليك قلبه، أو بإعطائه الصدمات الكهربية مع التنفس الصناعي لرفع الأكسجين بالدم، وإعطاء المنشطات والمسعفات اللازمة، فمن الممكن أن يبدأ التنفس الذاتي في العمل، ويعود الإنسان إلى وعيه — هذا إذا كان سبب الوفاة الأصلي يسمح بذلك. وبهذه الطريقة يمكن إنقاذ حياة بعض المرضى في هذه الفترة الحرجة التي يعتبر الإنسان فيها ميتًا بكل المقاييس الإكلينيكية الطبية، ولكنه لا يكون بالفعل كذلك؛ لأن مخه ومعظم أعضاء الجسم لا زالت حية. وهذه الفترة تسمى فترة الاحتضار ، وبالتالي فإن القيام بأي فعل يؤدي إلى تعجيل الموت — سواءً أكان فعلًا إيجابيًا أم سلبيًا — يعتبر جريمة قتل، لأنه اعتداء على إنسان حي.

ومع التسليم بما توصل إليه العلم فإن الصواب ألا نحكم بالموت على هذا الشخص، فلا يعتبر ميتًا، وإنما هو في سبيله إلى الموت؛ لأنه في حالة احتضار، و **المحتضر لا يوصف بأنه ميت** .

12 الدليل الثاني عشر – الموت حقيقة وجودية

إن الموت حقيقة وجودية خلقت ضد الحياة، والموت والحياة لا يجتمعان في بدن واحد في وقت واحد. فإن مرضى الغيبوبة الدماغية أو مرضى جذع المخ إما أن يوصفوا بالموت أو الحياة، ووصفهم بأنهم أموات منقوض باستمرار مظاهر الحياة التي أكدها الأطباء في أبدانهم، ولا يجوز الحكم بموت إنسانٍ وبدنه ما زالت فيه حياة، ولا يزال يقبل الدواء، وتظهر عليه آثار تقبله من نمو وغيره.

والأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحياة إلا إذا كانت حية، فالحياة البدنية هي المعتبرة وليست الحياة الإدراكية، لأنها مناط التكليف ولكن انتهائها بالغيبوبة لا يعني موت صاحبها إن توافرت لديه مظاهر الحياة، ومن ثم فيتعين وصف هؤلاء المرضى بأنهم **أحياء** ، لم تفارق أرواحهم أبدانهم لوجود دلائل بقائها فيها.

ومما يؤكد هذا الأمر مفهوم الحياة عند الأطباء أنفسهم، حيث حددوا مفهومها بأنها العمليات التي تقوم بها الكائنات الحية، والتي في مجملها تميزها عن النظم غير الحية، و **الأيض** هو أكد علامات الحياة وضوحًا، وهو مجموع كل العمليات الكيميائية التي تتم في الكائن الحي، ويمثل كذلك مقدرة الكائن الحي على تحويل المواد الغذائية التي تصل إليه إلى وحدات كيميائية نباتية، ممكن أن يصنع منها مواد أخرى.

13 الدليل الثالث عشر – دول لا تعترف بموت الدماغ

إنه لا زال من الأطباء — بل من الدول — من لا يعترف بأن الشخص الذي حدث له ما يسمى بموت الدماغ يعامل باعتباره ميتًا. فمع أن القوانين في معظم الدول في العالم تعتبر أن الشخص الذي مات جذع المخ عنده صار ميتًا حتى لو كان قلبه لا زال ينبض، فإنه لا زالت الكثير من الدول لا تعتبره كذلك. وعلى هذا فإن **معظم دول العالم الثالث** ومنها بعض الدول الإسلامية، وكذلك **الصين** لا تعترف بأن الشخص قد مات الموت الحقيقي، فلا تعترف هذه الدول بالموت إلا إذا توقف القلب والنبض.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية — ومع أن معظم الولايات فيها تقول بموت الدماغ وتعترف به — إلا أن هناك بعض الولايات لا ترى ذلك. و **اليابان** هي الأخرى لا تعترف بالموت، إلا إذا ماتت جميع أعضاء الإنسان، أي أن موت الدماغ ليس كافيًا عندهم للحكم بالموت.

14 الدليل الرابع عشر – مفارقة الروح للجسد

إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية لا يتحقق إلا بـ **مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة** ، بحيث لا يبقى أثر للارتباط بينهما، وهذا ما دلت عليه عبارات الفقهاء التي أكدت أن الموت هو مفارقة الروح للجسد.

وبالثورة الهائلة في المجال الطبي أكد الطب أنه من الممكن التأكد من موت الدماغ، وذلك بالعرض على جهاز رسم المخ، إلا أن هذا الأمر **لم يصل بعد إلى مرتبة الحقيقة العلمية المستقرة** ، وبالتالي لا يجوز اعتماد هذه الظاهرة وحدها، وبناء الأحكام الشرعية عليها.

15 الدليل الخامس عشر – وجوب حفظ النفس والاحتياط

أمر الإسلام بحفظ النفس، وفرض العقوبة على من يعتدي عليها، سواء كان هذا الاعتداء عمدًا، أم كان بطريق الخطأ، وما شرع الإسلام تلك العقوبات إلا لأهمية النفس، وأن في الحفاظ عليها استمرار للحياة. ومن مقتضيات حفظ النفس **الاحتياط والانتظار والتريث** قبل الحكم على شخص ما بالموت، إذ لا ينبغي أن يتم الحكم إلا بتوافر الأدلة القاطعة التي لا تقبل العكس طبيًا كانت أو شرعية، وهو ما قرره الفقهاء، حيث قرروا أنه في حالة الشك في حصول الموت من عدمه، فإنه يجب الانتظار والتريث لحين ظهور العلامات المؤكدة.

يقول **ابن قدامة — في المغني**: «وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ، اعْتُبِرَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ مِنْ اسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ، وَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ، وَمَيْلِ أَنْفِهِ وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ وَجْهِهِ، وَانْحِسَافِ صُدْغَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً كَالْمَصْعُوقِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ حَرْبٍ أَوْ سَبُعٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَنْتَظِرُ بِهِ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ، حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، قَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَصْعُوقِ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا، قَالَ أَحْمَدُ — رَحِمَهُ اللَّهُ —: إنَّهُ رُبَّمَا تَغَيَّرَ فِي الصَّيْفِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قِيلَ: فَكَيْفَ تَقُولُ؟ قَالَ: يُتْرَكُ بِقَدْرِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَيِّتٌ، قِيلَ لَهُ: مِنْ غَدْوَةٍ إلَى اللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.».

يقول **شيخ الإسلام ابن تيمية**: «قد استفاضت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأن الأرواح تقبض، وتنعم وتعذب، ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة.».

يقول **النووي**: «يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته بأن يموت بعلةٍ، أو تظهر أمارات الموت، فإن شك بألا يكون به علة واحتمل أن يكون به سكتة، أو ظهرت أمارات فزع أو غيره، أُخِّر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو غيره.».

وتحقق موت الدماغ — بناءً على ما تم تقريره — أمر مشكوك فيه، وبالتالي ووفقًا لما تقدم، فإنه يجب الانتظار لحين حصول اليقين.

المناقشة: نوقش الاستدلال السابق بأن العلامات التي ذكرها الفقهاء سابقًا ليست قطعيةً وليست بالضرورة دالةً على موت الإنسان، فالله ﷻ قادر على أن يعيد الحياة للإنسان بعد ظهور تلك العلامات، وفي هذه الحالة لا يمكننا الحكم على أي شخص بالموت حتى ينتن وتظهر رائحته، لذا كان الاعتماد على ما ذكره الأطباء في هذا المقام أولى.

الجواب: يُجاب بأن الله تبارك وتعالى أناط الحكم بموت الإنسان بالعلامات التي تدل عليه مع الاحتياط في الحالات التي تكون استثنائية كغرق، واحتراق، وانتشال من تحت أنقاض هدم، فالعهدة في الحكم بالموت بعد استكمال العلامات كلها مع الحيطة الزائدة في الحالات الاستثنائية. أما موت الدماغ وحده دون وجود سائر العلامات الأخرى، فالعهدة في الحكم فيها على الذين اجتهدوا وقاسوا، ولا شك أن هذا **قياس مع الفارق** .

أدلة الرأي الثاني – القائلون باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا

استدل أصحاب الرأي الثاني على قولهم باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا بـ **الكتاب** و **السنة** و **المعقول** ، والأدلة الآتية:

1 الدليل الأول – حديث أم سلمة

الحديث: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا، حيث أفاد أن الروح إذا فارقت البدن تبعها البصر، وبالتالي لا يبقى أي منعكس من منعكسات العين، وهذا هو حقيقة موت الدماغ.

يقول **المناوي — في فيض القدير، نقلًا عن القاضي**: «يحتمل أن الملك المتوفي للمحتضر يتمثل له فينظر إليه نظر شزرًا ولا يرتد إليه طرفه حتى تفارقه الروح، وتضمحل بقايا القوى ويبطل البصر على تلك الهيئة، فهو علة للشق، ويحتمل كونه للإغماض؛ لأن الروح إذا فارقته تتبعه الباصرة في الذهاب، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة.».

المناقشة: يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه استدلال أخرج الحديث عما يرمي إليه، حيث إن العلماء قرروا أنه يحتمل أمرين:

- **الأول**: أن ذلك يكون بعد خروج الروح من أكثر البدن، وهي لا تزال باقية في الرأس والعين، فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم ينته كلها، نظر البعض إلى القدر الذي خرج، وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه، فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سَكَنَ النظر، وبالتالي يكون معنى قوله «إذا قُبِض» أي: إذا شُرِع في قبضه ولم ينته.
- **الثاني**: أن يحمل ذلك على أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجةً، فيرى ويسمع ويرد السلام. وبالتالي فالحديث خارج عن محل النزاع.

الجواب: حُذف الجواب من المصدر — يُكتفى بالمناقشة.

2 الدليل الثاني – عجز الجسد عن خدمة الروح

إن العلماء — القدامى منهم والمحدثين — قرروا أن الإنسان روح وجسد، وأن علامة الحياة هي **ملازمة الروح للجسد** حتى يقوم الجسد بخدمة الروح، وقرروا أيضًا أنه إذا أصبح الجسد عاجزًا عن خدمة الروح فإن ذلك يعد نهاية لحياة ذلك الشخص، وموتى الدماغ تتحقق فيهم تلك الأوصاف، حيث لا يستطيع الجسد فعل أي شيء للروح، إذ صارت الأدوية غير مجدية في علاج مثل هذه الحالات.

يقول **الإمام الغزالي**: «معنى مفارقة الروح للجسد، انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها، فإن الأعضاء آلات الروح تستعملها، حتى أنها لتبطش باليد، وتسمع بالأذن، وتبصر بالعين، وتعلم حقيقة الأشياء. وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بالقلب بفساد مزاج يقع فيه، وبشدة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها، فتكون العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء، وقد استعصى عليها بعضها. والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها، وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها.».

يقول **ابن القيم**: «الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح.».

يقول **د. محمد نعيم ياسين**: «إن ملازمة الروح للجسد الإنساني مرهونة بصلاحية هذا الجسد لخدمة هذه الروح وتنفيذ أوامرها، وقبول آثارها، وأن الله قد كتب عليها أن تفارق مسكنها المؤقت، وهو جسد الإنسان عندما يغدو عاجزًا عن القيام بتلك الوظائف.».

المناقشة: يناقش هذا القول بأنا نسلم لكم أن الجسد خادم للروح، وسلمنا كذلك بأن الجسد إذا صار عاجزًا عن خدمة الروح كان ذلك إيذانًا بنهاية الحياة، ولكن لا نسلم لكم اليقين بأنه في حالة موت الدماغ يتحقق عجز الجسد عن خدمة الروح. ثم إن المقصود بعجز الجسد الذي يحكم بناءً عليه بالمفارقة للحياة هو **العجز الكلي** ، والمتمثل في عدم القدرة الحالية، وعدم إمكانية ذلك مستقبلًا، وهذا ما لا يمكن القطع به وفقًا للقواعد الطبية، بدليل خرق بعض الحالات لتلك القواعد. فالعجز المقصود هنا هو موت سائر أعضاء الجسد كلية، وهو غير متحقق في مسألتنا.

3 الدليل الثالث – عدم تجدد خلايا المخ

استدلوا بقولهم: إن من مات مخه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود للحياة، إذ من المبادئ الأساسية في علم الأمراض العصبية أن **خلايا المخ لا يمكن أن تتجدد في حالة تلفها** ، وبالتالي فوجود أعضاء الجسم حية بعد موت المخ لا يعني أنه بإمكانها أن تستمر كذلك طويلًا؛ لأن جميع أعضاء الجسم وخلاياه تعمل تحت سيطرة المخ وتستمد بقاءها منه، فهو القائد الذي يقودها، وبالتالي فبمجرد موت المخ تبدأ الأعضاء في التحلل التدريجي وفقًا لمدى اعتمادها على وظائف المخ في البقاء. وأسرعها في الزوال الوعي، ووظائف الحس والحركة الإرادية، ثم باقي الأعضاء، أي أنه بذلك يفقد ما يميزه كإنسان وهو كاف لإعلان الوفاة الحقيقية.

المناقشة:

- **المناقشة الأولى**: إن التسليم بذلك يعد أمرًا في غاية الخطورة، بل قد لا يقبل عقلًا ولا عملًا، لأنه يفتح بابًا واسعًا من الاعتداءات والانتهاكات لأجساد المرضى، إذ يترتب على التسليم بذلك أن

المجنون يجوز التصرف في جسده، لفقدانه لتلك الخاصية. وهذا المفهوم لموت الدماغ يواجه معارضةً كبيرة، إذ وفقًا له يجوز الحكم بالموت على كل مرضى الغيبوبة العميقة، وكذلك مصابو الأمراض العقلية، وقد مال بعض الأطباء العرب إلى التأكيد على الأخذ بهذا الرأي، رغم المعارضة الشديدة والواسعة، وهو أمر تتفاقم خطورته، لأنه وفقًا لذلك سيكون المرضى النباتيون والمولودون بدون دماغ في عداد الأموات، بالرغم من حياة أبدانهم. وقد قرر هذه الحقيقة المؤتمر الدولي لموت المخ الذي عقد في عام ١٩٩٢م إذ قرر أن موت المخ يكتنفه التخبط بين الأطباء حول حقيقة حالة المرضى الذين توقفت وظائف المخ لديهم، ولكن خلايا وأنسجة الأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة تستمر في الحياة.

- **المناقشة الثانية**: إن هذا الاستدلال منقوض بوجود حالات تم تشخيصها على أنها موت دماغ، ثم عادت إلى الحياة.

الجواب: يُجاب عن المناقشة الثانية بأن الحالات التي تمت إفاقتها، وبالتالي عودتها إلى الحياة فوق ندرتها لم يتم تشخيصها في البداية تشخيصًا صحيحًا، كما أن الخلط بين الغيبوبة الطويلة وموت الدماغ هو خلط بين الحياة والموت، وأنه ليس من المقبول أن تكون تلك الحالات قد شخصت كحالات موت مخ حسب البروتوكولات والشروط الموضوعة، وفقًا للمعايير العلمية المعترف بها.

4 الدليل الرابع – عبارات الفقهاء القدامى

إن عبارات الفقهاء القدامى تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الشخص لا يطلق عليه أنه ميت إلا إذا انعدمت فيه **كل مظاهر الحياة** من تنفس، ونبض، وحركة، وما إلى ذلك، وقد تحدثوا عن هذه المسألة تفصيلًا في معرض حديثهم عن حكم الاشتراك في القتل:

يقول **الزركشي — في المنثور**: «وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ هِيَ أَنْ تَكُونَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ وَمَعَهَا الْحَرَكَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ دُونَ الاضْطِرَارِيَّةِ، كَالشَّاةِ إِذَا أَخْرَجَ الذِّئْبُ حَشْوَتَهَا وَأَبَانَهَا حَرَّكَتْهَا حَرَكَةً اضْطِرَارِيَّةً، فَلَا تَحِلُّ إِذَا ذُبِحَتْ. كَمَا لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَلِهَذَا لَوْ طُعِنَ إِنْسَانٌ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ يَوْمٍ، وَقَتَلَهُ إِنْسَانٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَجَبَ الْقِصَاصُ، لِأَنَّ حَيَاتَهُ مُسْتَقِرَّةٌ، وَحَرَكَتَهُ الِاخْتِيَارِيَّةُ مَوْجُودَةٌ، وَلِهَذَا أَمْضَوْا وَصِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — بِخِلَافِ مَا إِذَا أُبِينَتْ الْحَشْوَةُ؛ لِأَنَّ مَجَارِيَ النَّفْسِ قَدْ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ الْحَرَكَةُ اضْطِرَارِيَّةً. وَقَدْ تَكُونُ الْحَوَاسُّ سَلِيمَةً وَالْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةً وَالْحَرَكَةُ اخْتِيَارِيَّةً، وَيُعْطَى الْإِنْسَانُ فِيهَا حُكْمَ الْأَمْوَاتِ كَالْوَاقِعِ فِي بَحْرٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ. وَأَمَّا حَيَاةُ عَيْشِ الْمَذْبُوحِ وَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا إبْصَارٌ وَلَا نُطْقٌ وَلَا حَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ.».

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن الفقهاء لم يحكموا بموت الشخص إذا كانت حياته غير مستقرة، وإنما لم يوجبوا القصاص على من طعن من أُبينت حشوته؛ لأن فعله ليس هو المؤثر في موته، وإنما أثر في موته إبانة حشوته، إذ إن من أُبينت حشوته لا يبقى معها حياة، لكنه لا يأخذ حكم الميت حتى يتيقن منه. ومما يؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا أن المجني عليه إذا صار إلى مرحلة الحياة غير المستقرة بسبب مرض لا بسبب جناية، أو فعل حيوان مفترس، كما لو صار إلى مرحلة النزع، فأجهز عليه مجرم وهو في هذه الحالة فإن جمهور الفقهاء يذهبون إلى إيجاب القصاص على هذا الشخص.

5 الدليل الخامس – النسيج الشبكي وإعلان سيدني

أثبتت المصادر الطبية أن **النسيج الشبكي** هو المسئول عن وعي الإنسان، وإذا فقد الإنسان وعيه لأي سبب من الأسباب، فيكون هذا النسيج قد تعرض لضرر، وليس هناك أمل لدى العلماء في إيجاد بديل للمخ في المستقبل يكون بديلًا للمخ التالف، نظرًا للتعقيد الشديد في تركيب الدماغ ووظائفه. وبالتالي فالمخ الحي لا يكون إلا في إنسان حي، ونقل المخ منه يعد بمثابة قتل محقق. وقد جاء في إعلان سيدني الصادر في عام ١٩٦٨م:

يقول **إعلان سيدني — ١٩٦٨م**: «إن الموت على مستوى الخلية أو مستوى الأنسجة عملية تدريجية، والأنسجة تختلف في تحملها لحرمانها من الأوكسجين، وليس المهم تحديد موت الأعضاء المختلفة أو مجموعات الخلايا، وإنما المهم التأكد من أن عملية الموت قد وصلت إلى نقطةٍ لا يمكن عندها وقفها مهما استعمل من وسائل العلاج والإنعاش، وإن وجد عضو أو مجموعة من الخلايا حية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكائن ذاته حي.».

6 الدليل السادس – اختصاص الأطباء

إن مسألة تحديد نهاية الحياة من اختصاص الأطباء، فهم الذين يقفون على الثغرة الحرجة من هذه المسألة، فملازمة الروح للجسد الإنساني مرهونة بصلاحية هذا الجسد لخدمة هذه الروح، وتنفيذ أوامرها وقبول آثارها، وأن الله ﷻ قد كتب عليها أن تفارق مسكنها المؤقت، وهو جسد الإنسان عندما يغدو عاجزًا عن القيام بتلك الوظائف. والعلم هو الذي يستطيع أن يعرف تلك اللحظة التي يصبح فيها الجسد عاجزًا، ومما لا شك فيه أن معرفة التشريح النسيجي والفسيولوجي للدماغ وحالات مرضه، ومن ثم موته، تعد من **أمور الدنيا** ، فهي ليست أمرًا دينيًا.

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأنه محل نظر؛ لأن الحكم على شخص بالموت أو بعدمه هي **مسألة شرعية قبل كونها طبية** ، إذ يترتب عليها أحكام شرعية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلو سلمنا أن المسألة اختصاص أصيل للأطباء، فالأطباء أنفسهم مختلفون فيما بينهم، فمنهم من يعتبره موتًا حقيقيًا، ومنهم من لا يعتبره كذلك، مضافًا إلى ذلك كله الأخطاء التي قد تحدث في التشخيص، والتي أقر الأطباء بوجودها، مع كل ذلك لا ينبغي الاعتماد على قول الأطباء وحدهم.

7 الدليل السابع – الفوائد المترتبة على القول بالجواز

إن القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يؤدي إلى جملة من **الفوائد** ، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، ومن هذه الفوائد:

- **اهتمام فريق نقل الأعضاء:** باستخدام الميت باعتباره متبرعًا.
- **توفير التكاليف:** الباهظة للملاحظة في العناية المركزة.
- **توفير سرير في العناية المركزة:** لحالة مريض آخر، قد تكون الآمال في إنقاذ حياته أكبر من المريض الميت دماغيًا.
- **التقليل من الفترة المحزنة:** للأقارب.
- **منع الإساءة إلى المتوفي:** بتركه معلقًا على الأجهزة.
- **رفع أجهزة الإنعاش:** عن المحكوم عليهم بالموت، وإسعاف من مات قلبه دون دماغه.
- **إزالة الإحباط:** الذي يصيب العاملين في وحدة العناية المركزة، حين يُجبرون على تمريض جسم شخص ميت.
- **ترتيب الأحكام المترتبة:** البدء في ترتيب أوضاع المستحقين للإرث، واتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بأحكام الموتى.

المناقشة:

- **أولًا:** إن الفوائد المادية التي من الممكن تحقيقها من الحكم بموت الدماغ، لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال من العوامل المؤثرة في تحديد الحكم الشرعي لهذه المسألة، ولو كان لها اعتبار لتغيرت الكثير من الأحكام ولصار المجتمع مجتمعًا يقوم على المادة، دون أدنى اعتبار للكرامة الإنسانية.
- **ثانيًا:** القول بتقليل الفترة المحزنة للأقارب في حالة الحكم بالموت قول غير مقبول؛ فإذا كان

الأقارب يحزنون على بقاء مريضهم تحت أجهزة الإنعاش فترةً من الزمن، وكان هذا الحزن سينتهي أو يقل لو تم إعلان موته، فإن الحزن سيزداد ويتعاظم في حالة علمهم أن ميتهم قد أخذت أعضاؤه لينتفع بها غيره، فكأننا بذلك جمعنا عليهم بلاءين: بلاء الموت، وبلاء هتك حرمته.

▪ **ثالثًا**: الادعاء بأن العاملين في المستشفى القائمين على تمريضه يصابون بإحباط أمر غير متصور؛ بل غير منطقي؛ لأن التسليم بذلك يعني أنه يجب إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه وفقًا للقواعد العلمية، كمرضى الإيدز، والسرطان، وغيرها من الأمراض التي لم يتوصل الطب لعلاج لها حتى الآن، وهو أمر لا يجوز شرعًا ولا عقلًا.

▪ **رابعًا**: إن هذا القول يتعارض مع الهدف من مهنة الطب والتمريض؛ فالطبيب يقوم بعلاج المريض مهما ساءت حالته، باذلًا أقصى ما في وسعه لإنقاذ حياة المريض، فإذا لم يتم الشفاء، فإن ذلك هو قدر الله خارج عن إرادته، أما إذا ترك المريض بدون علاج بدعوى عدم جدوى العلاج، فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها شرعًا وقانونًا.

8 الدليل الثامن – السائد عالميًا

إن تحديد الوفاة بموت الدماغ واعتباره موتًا حقيقيًا ساد العمل به في معظم البلدان المتقدمة خلال العقود السابقة، وحقيقة الموت واحدة للإنسان، ويجب ألا تختلف باختلاف البلدان؛ إذ إنه وضعت علامات واضحة للوفاة الدماغية، وأنها تعادل وفاة الجسد، وأن جميع من ماتوا لتوافر شروط التشخيص فيهم، لم يرجع للحياة مرةً أخرى. ففي مراجع الطب الأدبي وجد بليس «*كريستوفر*» عدد **١٠٣٦ حالة** موت دماغي، نشرت في ستة عشر تقريرًا بين عامي ١٩٦٨ - ١٩٨٨ جميعها توقفت قلوبهم، بالرغم من الاستمرار في علاجهم وإبقائهم على أجهزة الإنعاش.

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأن فيه نوعًا من التناقض؛ إذ إنه أفاد أن حقيقة الموت للإنسان واحدة، ويجب ألا تختلف باختلاف البلدان، وهذا كلام مقبول، ولكن الثابت الذي لا جدال فيه ولا مراء أن القواعد التي يتم بها التشخيص **تختلف من بلد لآخر**، بل تختلف من ولاية لأخرى في ذات البلد، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن القول بأن كل من تم تشخيصهم على أنهم موتى دماغ لم يرجع منهم أحد للحياة مرةً أخرى مردود بأنه قد ثبت رجوع بعضهم للحياة بعد أن حُكم عليهم بأنهم موتى دماغ وفقًا لقواعد التشخيص المعترف بها، فالدليل بناءً على ذلك لا ينهض حجة في الموضوع.

9 الدليل التاسع – موت القلب

إن موت القلب لا يعد موتًا نهائيًا؛ وإنما الموت النهائي هو **موت جذع الدماغ** ، والدليل على ذلك أن عملية زرع القلب بعد استئصال القلب الأصلي لا تعد موتًا، ولا أحد يعتبر المريض أنه قد مات مع أن قلبه الأصلي قد مات، وكذا من أخذ القلب منه، فإن قلبه لا يزال حيًا مع أن صاحبه قد مات منذ زمن. حيث إن للموت علامات مبكرة وعلامات متأخرة، فالمبكرة تتمثل في فقدان الوعي والإحساس والحواس، وتوقف التنفس، وتوقف القلب عن النبض، والعلامات المتأخرة تتمثل في برودة الجثة، وتيبسها، وتغير لونها إلى اللون الأزرق، وتعفنها.

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأنه **خارج عن محل النزاع** ؛ فمحل النزاع موت الدماغ وليس موت القلب، والخلاف في وفاة الإنسان شرعًا بعد موت دماغه وقبل توقف القلب والتنفس اللذان يعملان فيه بسبب الآلة، وبالتالي فلا يصلح هذا الدليل في مسألتنا.

10 الدليل العاشر – قول اللخمي

يقول **اللخمي**: «اخْتُلِفَ فِي الْحَرَكَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْعُطَاسِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْحَيَاةِ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ أَقَامَ يَوْمًا يَتَنَفَّسُ وَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ وَيَتَحَرَّكُ حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَحَرَكَتُهُ كَحَرَكَتِهِ فِي الْبَطْنِ لَا يُحْكَمُ لَهُ فِيهَا بِحَيَاةٍ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَقَدْ يَتَحَرَّكُ الْمَقْتُولُ أَوْ عَطَسَ، تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ، أَوْ بَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: بَوْلُهُ لَغْوٌ، أَوْ رَضَعَ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَعَارَضَ هَذَا الْمَازِرِيُّ وَقَالَ: لَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ دَلَالَةِ الرَّضَاعِ عَلَى الْحَيَاةِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهُ مُحَالٌ بِالْعَادَةِ أَنْ يَرْضَعَ الْمَيِّتُ، وَلَيْسَ الرَّضَاعُ مِنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَكُونُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الطَّبِيعَةِ وَالِاخْتِيَارِيَّةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنَّ الْعُطَاسَ يَكُونُ مِنْ الرِّيحِ، وَالْبَوْلُ مِنْ اسْتِرْخَاءِ الْمَوَاسِكِ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقَصْدِ إلَيْهِ، وَالتَّشَكُّكُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْحَيَاةِ يُطْرِقُ إلَى هَدْمِ قَوَاعِدَ ضَرُورِيَّةٍ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَالِاسْتِهْلَالِ بِالصِّرَاخِ.».

يقول **المواق**: «فَقَدْ كَانَ عُمَرُ: لَمَّا طُعِنَ مَعْدُودًا فِي الْأَمْوَاتِ، لَوْ مَاتَ لَهُ مَوْرُوثٌ لَمَا وَرِثَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ عُمَرَ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — حِينَئِذٍ لَمَا قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ حِينَئِذٍ يَتَكَلَّمُ وَيَعْهَدُ. وَفَرْقٌ بَيْنَ وَلَدِ الْبَقَرَةِ مَثَلًا تَزْلِقُهُ وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ، وَبَيْنَ الْمَرِيضَةِ الَّتِي أُيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا، هَذِهِ يُرَاعَى الِاسْتِصْحَابُ فَتُحْسَبُ حَيَّةً وَتَتَعَلَّقُ بِهَا الزَّكَاةُ بِخِلَافِ الْمُزْلَقِ.».

فقد دلت النصوص السابقة على أن الحياة لا تثبت إلا بالصوت، والصوت حركة مرتبطة بالدماغ، فإذا كان الدماغ هامدًا لا يعطي أوامره، ولا يضبط الإرجاع عن المؤثرات فإنه لا

حياة. ولذلك قدروا أن العطاس والبول والرضاع لا يعبر عن الحياة، وتنبه المازري إلى أن الرضاع **حركة إرادية** ، يعني أن الدماغ هو الذي يتدخل ليرضع الإنسان، فالامتصاص ليس عملية طبيعية، وإنما هو عملية إرادية لا تكون إلا إذا كان الدماغ عاملًا.

١١ الدليل الحادي عشر – توقف بعض الأعضاء مع موت الدماغ

من المتعارف عليه طبيًا أن بعض أعضاء الجسد قد تبقى حية وتقوم بوظيفتها، على الرغم من موت صاحبه دماغيًا، وإن استمر تنفسه بواسطة المنفسة، أو نبضه وتدفق دمه من الشرايين والأوردة ما عدا الدماغ. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يحدث للمحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، فبمجرد الشنق تنقطع الدورة الدموية عن الدماغ، لأن جذع الدماغ يتمزق بعظمة ناتئة من الفقرة الثانية من العمود الفقري، تخترقه وتسبب توقف الدم عنه، بينما يستمر القلب في ضخ الدم لعدة دقائق قد تصل إلى **١٥ أو ٢٠ دقيقة** ، الأمر الذي يؤكد وجود فترة زمنية بين موت القلب وموت الإنسان، وهذه الفترة يمكن التحكم في إطالتها باستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي، التي تضمن استمرار القلب في النبض وضخ الدورة الدموية في الجسم، وتكون النتيجة أن تطول فترة حياة الأعضاء بعد وفاة صاحبها.

٢ الرأي الراجح

من خلال ما تقدم عرضه من آراء، وما اعتمد عليه كل رأي من أدلة وما ورد عليها من مناقشات يتضح لي أن هذه المسألة من المسائل الشائكة التي تنازع فيها الأطباء والفقهاء، ولكل منهم وجهة نظره التي يدافع عنها. فالأطباء يرون في عجز الأعضاء عن خدمة الروح **موتًا محققًا** ، ولا عبرة عندهم ببقاء بعض الأعضاء على قيد الحياة بعد موت الدماغ، اعتمادًا منهم على أن الدماغ هو المحرك الرئيس لباقي الأعضاء، وأن بقاء الحياة في بعض الأعضاء بعد موت الدماغ لن يستمر طويلًا، فمصيرها إلى الزوال. أما الفقهاء فإنهم يرون الجسد والروح شيئًا واحدًا، وإن كان لكل منهما مهمته، ورؤية الفقهاء هذه تنبع من أن كلًا منهما مرتبط بالآخر ارتباطًا وثيقًا، بحيث لا يمكن أن يستغني أي منهما عن الآخر، ويعتبرون أن بقاء عضو من الأعضاء حيًا يعد **مؤشرًا واضحًا ودليلًا على حياة صاحبه** .

الراجح: أرى أن **الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول** من القول **بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا**، وذلك للوجوه الآتية:

قوة الأدلة: قوة الأدلة التي اعتمد عليها هذا القول، وضعف أدلة المخالف.

قواعد قابلة للنقض: إن الأدلة التي اعتمد عليها الرأي المخالف تقوم على أساس قواعد علمية متعارف عليها في المجال الطبي، وهذه القواعد تم إثبات عكسها في بعض الحالات، وهذه الحالات وإن كانت نادرة إلا أنها تضع علامة استفهام حول إمكانية الأخذ بها كقاعدة عامة، لأن الأمر يتعلق بالأرواح، وقد يترتب على ذلك الحكم على شخص حي بدخوله في عداد الأموات.

مخالفة المنطق: إن القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يخالف المنطق، ويتجافى مع ما يرمي إليه العقل، بل يؤدي إلى قتل الأبرياء، حيث إن الأطباء في الماضي كانوا يرون أن المعول عليه في الموت هو توقف القلب عن العمل، ثم بعد ذلك وجدت الأساليب التي يتم بها إنعاش القلب، مما أدى إلى التغاضي عن معيار توقف القلب، ثم نجدهم الآن يقررون أن موت الدماغ هو الفيصل في تقرير إعلان الوفاة، وكل ذلك بناءً على ما لديهم من معلومات، وبالتالي فمن المنطقي جدًا أن يتم استحداث منعشات للدماغ في المستقبل كما تم للقلب.

مخالفة المعنى المتبادر للموت: إن معنى الموت الذي يعلمه العامة قبل الخاصة عدم صلاحية الجسد لأن يحدث به أي مظهر من مظاهر الحياة، وهذا يختلف تمامًا مع ما يسمى بموت الدماغ، حيث إن الأطباء أنفسهم القائلين بفكرة موت الدماغ قرروا أن الميت دماغيًا تظل له بعض مظاهر الحياة، كنمو شعره وأظافره. والواقع أثبت ذلك أيضًا، فقد نقل أن امرأة من فنلندا دخلت في غيبوبة طويلة، وتم التقرير بموت دماغها، وكانت هذه المرأة حاملًا وولدت طفلها أثناء تلك الغيبوبة كامل النمو، ثم عادت المرأة للحياة بعد ذلك، ولو كان موت الدماغ كافيًا في إنهاء الحياة لماتت تلك المرأة، ولما كانت صالحة لأن تقوم بما يقوم به الأحياء، وبالتالي فاجتماع النقيضين مستحيل.

التناقض الظاهر: إن هناك تناقضًا واضحًا يدركه كل عاقل عند نظره لهذه المسألة، مفاده أن القائلين بموت الدماغ أطلقوا عليه اسم «الميت الحي» واتفقوا على حياة بعض أعضائه وأجهزته الحيوية، فهل يجتمع الموت والحياة في جسد واحد؟ هذا أمر محال الحدوث، فعلماء اللغة يعرفون الموت والحياة بأن كلًا منهما نقيض الآخر.

الميؤوس من شفائه مريض لا ميت: إن الأطباء عندما تكلموا عن موت الدماغ دائمًا ما يرددون عبارة «توقفًا لا أمل في رجوعه» أي يقولون إنه ميؤوس من شفائه، وأنا أتساءل: هل الميؤوس من شفائه والشخص الذي لا أمل في رجوعه للحياة، هل هو شخص حي أم ميت؟ هو بالمنطق يعد حيًا؛ لأنهم يطلقون عليه **مريض** ، والمريض لا يمكن أن يكون ميتًا بأي حال.

تعد مسألة الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ من المسائل ذات الأثر الواضح في هذه القضية، إذ شاع لدى الكثيرين أن الهدف الرئيس من إقرار ما يسمى **بموت الدماغ** هو **إيجاد مبرر قانوني وشرعي** للحصول على أعضاء هؤلاء الأشخاص في حالة جيدة، وهذه المسألة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: **المحور الطبي**، و**المحور الشرعي والقانوني**، و**المحور الأخلاقي**، وبين المحاور الثلاثة ارتباط لا يقبل التجزئة؛ لأن الأطباء المسلمين لن يقوموا بهذا العمل إلا إذا توفر لهم الغطاء الشرعي والقانوني الذي يجعلهم في مأمن من العقاب والمساءلة الدينية والقانونية، فهم مرتبطون بأخلاقيات المهنة الطبية.

لذا كانت مسألة الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ مثار خلاف بين الفقهاء:

أولًا تحرير محل النزاع

الاتفاق الأول: لا خلاف بين الفقهاء في **عدم جواز نقل الأعضاء** عموماً إذا ترتب على هذا النقل ضرر، سواء بالمنقول منه أم المنقول إليه، لنهي الشريعة الإسلامية عن إلحاق الإنسان الضرر بنفسه أو بغيره.

الاتفاق الثاني: لا خلاف بين الفقهاء على **حرمة نقل الأعضاء** إذا تم ذلك **بمقابل**، حتى لا يكون جسم الإنسان وأعضاؤه محلاً للاتجار، مما يفتح باب شر يصعب إغلاقه.

يقول **ابن الهمام — في شرح فتح القدير**: «لا يجوز بيع أجزاء الإنسان، ولا الانتفاع بها، لأن الآدمي مكرم لا يبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا.».

مع اتفاق الفقهاء على ما تقدم، إلا أنهم **اختلفوا في الاستفادة بأعضاء موتى الدماغ** عن طريق استئصالها وزرعها للغير. وانتهى هذا الخلاف إلى رأيين:

خريطة الخلاف – نظرة إجمالية

الرأي	القائلون به	المبنى عليه
الأول «عدم الجواز»	الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد رأفت عثمان، وغيرهم	**الميت دماغيًا يعتبر حيًّا** ، ونقل الأعضاء بين الأحياء لا يجوز.

الثاني «الجواز»	القائلون باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًّا، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية	**موت الدماغ موتٌ حقيقي** ، والميت لا حرمة له في النقل لضرورة.

قرار هيئة كبار العلماء – رقم ٩٩ الصادر في ٦/١١/١٤٠٢هـ: «قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم، أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي: **جواز نقل عضو من إنسان ميت إلى مسلم** إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. **جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه**، أو جزئه إلى مسلم مضطر لذلك».

أدلة الرأي الأول – القائلون بعدم الجواز

استدل أصحاب الرأي الأول على قولهم بعدم جواز استقطاع أعضاء موتى الدماغ بـ**السنة والقياس والمعقول**، ونصوص الفقهاء.

1 الدليل من السنة النبوية:

الدليل الأول – حديث جابر رضي الله عنه قال النبي ﷺ: «لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ. قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ فَقَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ»

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ توعد من أقدم على إهلاك نفسه؛ لأن **الإنسان لا يملك أن يفسد من نفسه شيئًا** ، وفي نقل الأعضاء إفساد بالنفس؛ لأن صاحبه تصرف فيها على غير وجهها الشرعي. والميت دماغيًا فاقد للقدرة على التعبير عن إرادته، ولا يملك قبولًا ولا رفضًا، وبالتالي فالتصرف في أعضائه لا يجوز، ومن يقدم على فعل ذلك من الأطباء آثم يستوجب العقاب.

الدليل الثاني – حديث عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»

وجه الدلالة: أثبت الحديث **معصومية الجسد** ، أيًّا كانت الصفة القائمة به، وساوى بين الحي والميت في العقوبة المترتبة على الاعتداء على كل منهما. وما دام أن الإنسان الحي لا يجوز نقل أعضائه أو قطعها لينتفع بها الغير، فكذلك الميت؛ لأن الاعتداء على الميت أشد وأخطر؛ لفقدانه وسائل الدفاع عن نفسه بخلاف الحي.

يقول **الشوكاني — في نيل الأوطار**: «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَمْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَشْبِيهَ كَسْرِ عَظْمِهِ بِكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ إنْ كَانَ فِي الْإِثْمِ، فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّأَثُّمِ فَكَمَا يَحْرُمُ تَأْلِيمُ الْحَيِّ يَحْرُمُ تَأْلِيمُ الْمَيِّتِ، وَقَدْ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لَفْظَ «فِي الْإِثْمِ»، فَيَتَعَيَّنُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ.».

2 أدلة الإجتهاد والرأي:

استدلوا بجملة من النصوص التي وردت عن الفقهاء تدعم وجهة نظرهم، ومنها:

يقول **بلغة السالك**: «فإن بقي شيء من عظامه، فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت ولا جزء منه ولا شعره، لأن هذه الأجزاء محترمة، وفي أخذها انتهاك حرمتها.».

يقول **ابن قدامة — في المغني**: «فإن لم يجد المضطر شيئاً، لم يبح له أكل بعض أعضائه وإن لم يجد إلا آدميًا محقون الدم لم يبح قتله إجماعًا، ولا إتلاف عضو منه مسلمًا كان أو كافرًا؛ لأنه مثله، فلا يجوز أن يبقى نفسه بإتلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإن وجد معصومًا ميتًا لم يبح أكله.».

وجه الدلالة: دلت النصوص على عدم جواز نقل الأعضاء، إذ أفادت عدم جواز استخدام ظفر الميت ولا شعره، لأن في ذلك **انتهاكًا لحرمته** ، ويقاس على ذلك سائر أعضاء الإنسان. والميت دماغيًا ما زال على قيد الحياة «وفقًا لما رجحناه في المبحث السابق» وبالتالي ينطبق عليه الحكم.

3 أدلة المعقول:

الشك والريبة: الحكم على الميت دماغيًا فيه شيء من الشك، وما دام هناك **احتمال ولو ضئيل** في بقاء الشخص على قيد الحياة، فلا يجوز استقطاع أعضائه؛ إذ بهذا الفعل يصبح الموت مصيره المحتوم، ومعلوم أن الضرر محرم شرعًا.

الإيلام والتعذيب: في عملية نقل العضو نوع من الإيلام، لا سيما وأن الميت دماغيًا **ما زالت فيه بعض مظاهر الحياة** من حسٍّ وحركة ونبض وتنفس.

مرسوم الحيوان: نشاط أوعية القلب الدموية ما زال يعمل بصورة طبيعية. وفي مرسوم صدر عام ١٩٦٨م سُمي بـ«*مرسوم الحيوان*» قرر أن **الحيوان يعتبر حيًّا** حتى يحدث توقف دائم لدورة الدم أو تدمير دماغه.

الرسالة السامية للأطباء: استقطاع الأعضاء يتعارض مع الأخلاق الطبية التي توجب التحقق من موت الإنسان بجميع أعضائه. لذا فإن **مصطلح موت الدماغ استُحدث** لتحقيق غرض محدد: الحصول على الأعضاء عن طريق الحكم بالموت قبل أن يموتوا.

عائق أمام إيجاد العلاج: القول بالجواز يقف عائقًا أمام إيجاد علاج لبعض الأمراض المستعصية؛ حيث يعتمد الأطباء على الاستفادة من الأعضاء بدلًا من التكاتف للعلاج. وقد ظهرت دلائل نجاح في التجارب على **الخلايا الجذعية**، وعلى محاليل تُحقن عند الوفاة مباشرة.

الأولى بالحفظ: أولًا: **حرمة المال أقل من حرمة النفس**، وقد أمر النبي ﷺ بتوقي كرائم أموال الناس، فمن باب أولى أن تُتقى أعضاؤهم. **ثانيًا:** لا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية؛ لأنهم أحياء، قياسًا على عدم جواز استقطاع الأبضاع.

المناقشة والرد على دليل الإيلام

المناقشة – الإيلام: نوقش الاستدلال بالإيلام بأمرين:

- **الأول:** الدعوى بوجود الألم لا محل لها؛ لأن تلك العمليات لا تتم إلا بعد تخدير كامل، كما أن الألم محتمل، والحياة مليئة بالآلام، وهذا الألم له أهداف إنسانية.
- **الثاني:** الإيلام المحرم هو المقصود لذاته، أما إذا كان الغرض مشروعًا وَصَاحَبَتْهُ بعض الآلام فلا حرج، وقد كانت العمليات الجراحية والختان تُجرى قديمًا بدون تخدير، ومع ذلك أباحها الفقهاء لما فيها من منافع.

الجواب: يُجاب بأن قولكم بعدم وجود الألم بعد تخدير المريض كليًا محل نظر؛ لأن الميت دماغيًا — من وجهة نظركم — **ميت**، فلماذا التخدير إذن؟ ثم إن المراجع الطبية ذكرت أن مثل هذه العمليات لا يتم فيها تخدير، وذُكر أن بعض المرضى الذين حُكم عليهم بالموت لما همَّ الأطباء بنزع الأعضاء شعر بالألم وزادت حركته، فأوقف الأطباء عملهم.

شهادات العلماء المعاصرين

يقول **د. ديفيد ج. هيل — أستاذ التخدير في جامعة كمبريدج**: «ألم يحن الوقت كي نمنح المرضى على الأقل الحماية ذاتها، التي نصر على منحها للحيوان، وأن نستخدم المعايير ذاتها القاضية بضرورة التوقف الدائم للدورة الدموية، أو تدمير الدماغ لكي نقرر أن الموت قد حدث فعلًا قبل أن نشرع في عملية إزالة الأعضاء الحيوية.».

يقول **د. صفوت لطفي**: «إذا كان الله تعالى قد أمر بعدم قطع شيء من البهيمة قبل أن تموت تمامًا وتبرد حركتها، ونهى الرسول ﷺ أن نتعجل بموتها فتسلخ أو يقطع منها شيء قبل أن تهمد وتبرد، فأولى بذلك أن نتحرج من التصرف في الإنسان الذي كرمه الله حيًّا وميتًا، فنحن منهيون من باب أولى أن نتعجل موته ونبقر بطنه لنأخذ كليته أو قلبه أو كبده قبل أن يموت ويبرد تمامًا. وإذا مات وبرد، فإن أعضاءه لا تصلح، وبذلك يكون الله حماه من استخدام أعضائه.».

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الشأن، أن السبب الرئيس والدافع المحرك لعملية تشخيص موت الدماغ، هو **الحرص على جني الأعضاء الحيوية** من مرضى الغيبوبة ومصابي الحوادث، وبهذا المنطق فإن التبرير يختلف في الحقيقة عما يقال من أن الغرض من تشخيص موت الدماغ هو التعجيل بدفن الميت أي إكرامه، بدلًا من تركه على أجهزة الإنعاش، فالأمر غير مقبول شكلًا وموضوعًا.

فتوى مجمع البحوث الإسلامية – مصر: بأن من يقوم بالانتزاع من جسد لم يزل قلبه نابضًا بالحياة، فهو **قاتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق**، وتجب محاكمته جنائيًّا.

أدلة الرأي الثاني – القائلون بالجواز

استدل القائلون بجواز استقطاع أعضاء الموتى دماغيًا بـ**الكتاب والسنة والمعقول**:

من الكتاب: قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» دلت الآية على أن **حالة الضرورة مستثناة من الحكم العام**، والمريض إذا احتاج إلى نقل العضو يكون داخلًا في حكم المضطر؛ لأن حياته مهددة بالموت.

قول الشيخ طنطاوي: قال شيخ الأزهر السابق: «إن بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده باطل ومحرم شرعًا، وإن **التبرع جائز عند جمهور الفقهاء**، ولا فرق بين تبرع الأقارب أو غيرهم، مادام يؤكد نفعه الأطباء الثقات، وأن المتبرع في هذه الحالة أجره عند الله؛ لأن تبرعه لون من ألوان الإيثار على النفس».

الصدقة الجارية: بقاء الأعضاء لشخص آخر ينتفع بها يعتبر من قبيل **الصدقة الجارية**

- لقوله ﷺ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» وبهذا تكون هذه **صدقة مندوب إليها**، خاصةً إذا أوصى صاحبها بذلك قبل الوفاة، محتسبًا الأجر عند الله، فهو من باب الإيثار.

تفريج الكربات: قال تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»

- وقال ﷺ: «مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» و**المعروف عام** يدخل فيه سائر أنواع البر، والبدن أفضل من المال.

قول الشافعية: من فقهاء المذهب الشافعي من أباح للمضطر أن يقطع جزءًا من جسده ليسد به رمقه، لأن **الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأدنى** ، و**الضرر العام يدفع بالضرر الخاص**.

القياس: الأول: القياس على نقل الأعضاء بين الأحياء. **الثاني**: القياس على التشريح. **الثالث**: **القياس على التبرع بالدم واللبن** — فهما جزء من الجسم، وقد جاز التبرع بهما بشروط وضوابط.

مناقشة أدلة الرأي الثاني: نوقشت أدلة الرأي الثاني من وجوه:

- **أولًا**: إن الصدقة الجارية لها حدودها المأذون فيها شرعًا، فالإيثار شرع في حدود قدرة الشخص، ونطاقه ليس مطلقًا في كل شيء، بل في الحظوظ الدنيوية.
- **ثانيًا**: من أركان التبرع أن يكون المتبرع **مالكًا للشيء الذي يتبرع به** ، والمالك للجسد هو الله.
- **ثالثًا**: الاستدلال بالآية لا علاقة له بنقل أعضاء الميت، بل وردت في المأكل والمشرب، والاستثناء لا يقاس عليه.
- **رابعًا**: نظرية الضرورة لا تُعمل بها في **جرائم النفس** ؛ إذ لا يصلح أن ينقذ إنسان على حساب إنسان آخر، وهو أمر محل إجماع.

الرأي الراجح

القول الراجح: من خلال ما تقدم عرضه من آراء الفقهاء أرى أن **الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول** القاضي **بحرمة استقطاع أعضاء موتى الدماغ؛ ومنها:**

قوة الأدلة: قوة الأدلة التي استند إليها أنصار هذا الرأي، وخلوها عن المعارض الذي يقدح في صحتها من الناحيتين الشرعية والطبية.

بناء الرأي المخالف على أصل ضعيف: إن المجيزين أسسوا رأيهم على اعتبار موتى الدماغ أموات بالمعنى الحقيقي، في حين أن الاتجاه القوي من الفقهاء والأطباء رفضوا هذا المفهوم، حيث يرون أنه **لا يعد ميتًا** . والجزم بعدم عودة المريض للحياة أمر مستبعد؛ حيث إن الله تعالى قادر على إنعاش المريض بعد فقدان الأمل من شفائه.

أضرار على المنقول إليه: عمليات نقل الأعضاء لا تخلو من **أضرار تلحق بالمنقول إليه**: منها الأورام السرطانية — حيث وُجد أن نسبتها في المرضى الذين تم زرع كلى لهم تزيد مائة مرة عن النسب المعتادة، وورم كابوسي يظهر بنسبة تصل إلى **مائتي ضعف** . ومنها مضاعفات جراحة الأوعية من نزيف دموي، وجلطات، وارتفاع ضغط الدم.

الهدف الخفي وراء إثارة المسألة: إن الهدف الرئيس من إثارة الأطباء لهذه المسألة هو الحصول على **الغطاء الشرعي** الذي يسمح لهم بممارسة هذه الأعمال، والاعتداء على أجساد المرضى تحقيقًا لمطامع الشهرة والثراء.

تعارض مع مقصد الشريعة: إن الأصل الذي جاءت به الشريعة هو **المحافظة على النفوس** وليس القضاء عليها. لذا فإن الأطباء إنما يقدمون على هذا الفعل لعلمهم أن الأعضاء تكون صالحة في تلك المرحلة، فيتعجلون، والقاعدة أن **من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه** لذا تُجرَّم هذه الأفعال، مضافًا إلى معاقبة الطبيب الذي يقدم عليها.

تدريبات: على الوحدة الثالثة

١ حدد المفهوم الشرعي للموت، مقارنًا بينه وبين المفهوم العلمي.

٢ ما هو ضابط الموت الذي وضعه الفقهاء، وهل يتماشى مع ما ذهب إليه الأطباء؟

٣ القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يترتب عليه مفاسد كبيرة، اشرح هذه العبارة.

٤ هل يجوز نقل أعضاء موتى الدماغ؟ بيّن الآراء على سبيل الإجمال، مع ذكر الراجح.

٥ حدد مفهوم موت الدماغ كما وضعه الأطباء، ثم بيّن مدى انطباقه على المفهوم الشرعي.

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478